

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar

AÑO XI - NOVIEMBRE 1988

19

VIOLENCIA EN FAMILIA

Editora invitada: Dra. Ana Giller

EDITORIAL	9
PRESENTACION	11
CONCEPCION CIRCULAR DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	13
Dra. Ana Giller y Dr. Oscar Taber	
VIOLENCIA FAMILIAR	21
Equipo de Violencia Familiar. Consultorios Externos. Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear"	
VIOLENCIA Y FAMILIA. UNA TEORIA EXPLICATIVA	27
Dr. Reynaldo Perrone y Grupo de Investigación "Violencia y Familia"	
ABUSO SEXUAL DEL NIÑO EN LA FAMILIA: UN RESUMEN-GUIA SOBRE EL TEMA.	41
Dr. Eduardo Padilla	
TRATAMIENTO CON PADRES MALTRATANTES	55
Dra. Diana Becher de Goldberg	
UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA CONYUGAL: MUJER GOLPEADA.	69
Lic. María Cristina Vila de Gerlic	
EL DESNUDO DEL TRABAJADOR PROFESIONAL EN LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL A NIÑOS.	87
Sebastian Kraemer	
¿CUANDO USTED CUENTA A LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA INCLUYE EL TELEVISOR?.	97
Dra. Graciela Peyru	
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN GRATUITAMENTE PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR.	105

VIOLENCIA EN FAMILIA

Editora invitada:

Dra. Ana Giller

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar
AÑO XI - Nº 19 - Noviembre de 1988

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Asistente de Dirección

Lic. Inés Dates

Secretario de Redacción

Lic. Claudio Hirsch

Coordinadora General

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)
Isidoro Berenstein (Buenos Aires)
Rodolfo de Bernart (Florencia)
Donald Bloch (New York)
Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)
Ives Colas (Lyon)
Alberto Eiquer (Bs. As. - París)
Craig A. Everett (Florida)
Jorge García Badaracco (Bs. As.)
Florence Kaslow (West Palm Beach
Florida)
Raymundo Macías (México)
Juan C. Nocetti (Buenos Aires)
Reynaldo Perrone (Rosario -
Argentina, St. Etienne - Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)
Jacques Rudrauf † (París)
Alberto Serrano (Buenos Aires -
Filadelfia)
Mara Selvini Palazzoli (Milán)
Robin Skynner (Londres)
Carlos Sluzki (Bs. As., Berkshire
Massachusetts)
Helm Stierlin (Heidelberg)
Guillermo Vidal (Buenos Aires)
Gerald Zuk (Nueva Orleans)
Israel Zwerling (Filadelfia)
Lyman Wynne (Rochester - USA)
Mony Elkaïm (Bruselas - Bélgica)
Luigi Cancrini (Roma - Italia)

Comité de Redacción

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk
Lic. Inés Dates
Dr. Carlos Díaz Usandivaras
Dr. Fernández Moya (Mendoza)

Dr. Lino Guevara (Neuquén)
Lic. Sara B. Jutoran
Dres. Fidel y Elena Lebensohn
(Rosario)
Dr. Rafael Skiadaressis

Director Honorario
Alberto Cattán

Asesor Editorial
Alfredo Carlino

Gerente Comercial
Claudio Sfeir

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Ediciones A.C.E., Casilla de Correo 94, Suc. 28, Buenos Aires, Argentina.
Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor.
Nombre de la Revista registrado como marca.
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nro. 332.195.
Registro Internacional de Publicaciones Científicas. ISSN 0325-5905.
Composición y armado: Patricia Tur Tarizzo y Federico Tatter. Tel.: 27-3018.

**Agradecemos profundamente
a la Empresa Argentina FATE SA
quien a través de un subsidio hizo posible
esta edición.**

Carlos Srebrow y Asociados

Asesores en análisis y desarrollo organizacional

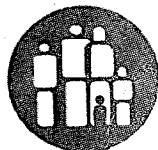
COUNSELING GRUPAL (Grupos de asesoramiento y desarrollo compartido)
Dirigentes de Empresas Familiares - Dueños de Empresas Unipersonales - Directivos de Instituciones y Asociaciones - Líderes y Conductores de Grupos de Trabajo - Profesionales Independientes.

GRUPOS DE ESTUDIO
Introducción al Análisis Organizacional - Teoría y Práctica del Análisis Organizacional - Escuelas y Marcos Conceptuales del Fenómeno Organizacional Empresa y Familia.

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO
Pequeña y Mediana Empresa
Empresa Familiar
Asociaciones e Instituciones
Persona y Rol Profesional

CAPACITACION
ORIENTACION OCUPACIONAL
SUPERVISION
INTERCONSULTAS

NUEVA DIRECCION
Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 2255
(1425) Bs. As. - Tel. 72-3866



TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

Curso bianual de entrenamiento. Da formación básica en Terapia Sistémica. Incluye clases teóricas y de Entrenamiento Vivencial. Cámara Gessel y Video. Dirigido a Psicólogos y Médicos.

TALLERES

**CENTRO
INVESTIGACION
FAMILIAR**

Directora
WANDA SANTI

- I. De Entrenamiento Vivencial.
- II. Profundización Clínica.
- III. Introducción al Pensamiento Sistémico.

DEPARTAMENTO DE EXTENSION COMUNITARIA

- Charlas para profesionales.
- Tratamientos familiares y pareja.
- Area Prevención.
- Son servicios GRATUITOS que da la Institución.

CONSULTAR - ABIERTA LA INSCRIPCION

Azcúénaga 964 2º C

1115 Buenos Aires - Argentina

Teléfono 961-4295

Indice

EDITORIAL	9
PRESENTACION	11
CONCEPCION CIRCULAR DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	13
Dra. Ana Giller y Dr. Oscar Taber	
VIOLENCIA FAMILIAR	21
Equipo de Violencia Familiar. Consultorios Externos. Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear"	
VIOLENCIA Y FAMILIA. UNA TEORIA EXPLICATIVA	27
Dr. Reynaldo Perrone y Grupo de Investigación "Violencia y Familia"	
ABUSO SEXUAL DEL NIÑO EN LA FAMILIA. UN RESUMEN-GUIA SOBRE EL TEMA.	41
Dr. Eduardo Padilla	
TRATAMIENTO CON PADRES MALTRATANTES	55
Dra. Diana Becher de Goldberg	
UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA CONYUGAL: MUJER GOLPEADA.	69
Lic. María Cristina Vila de Gerlic	
EL DESNUDO DEL TRABAJADOR PROFESIONAL EN LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL A NIÑOS.	87
Sebastian Kraemer	
¿CUANDO USTED CUENTA A LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA INCLUYE EL TELEVISOR?	97
Dra. Graciela Peyru	
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN GRATUITAMENTE PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR.	105
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES.	108

Editorial

Dedicar un número de la Revista al tema de la Violencia Familiar, hubiera parecido no hace mucho tiempo atrás, una elección impensable.

La violencia como fenómeno dentro de la familia es tan antigua como la familia misma. Pero por alguna razón nuestra, fue más motivo de atención de otros grupos interesados en la familia, que de los terapeutas.

Ligado más a la concepción moral, legal o social, la violencia ingresa en el campo terapéutico como motivo de preocupación, hace relativamente pocos años. Desde entonces ha ido creciendo rápidamente el interés por la atención de sus diferentes formas de aparición desde los distintos grupos de expertos de variadas profesiones que se ocupan del tema.

La selección de los trabajos para este volumen estuvo inspirada en dos aspectos concurrentes. Por un lado la puesta al día en la Argentina de diversos grupos que han estado trabajando hasta la fecha para presentar la actualidad de variados esquemas referenciales teóricos y formas de trabajo respetando la pluralidad de criterios que sirva al enriquecimiento conceptual que por su jerarquía y actualidad sirvan de estímulo para la reflexión y el intercambio.

Queremos agradecer la valiosa colaboración del Dr. Oscar Taber, Jefe de División Consultorios Externos del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", inteligente interlocutor con quien discutimos la presentación de este volumen y quien ha sido encargado de desarrollar la nada fácil tarea de concretar en la realidad la constitución del equipo de violencia familiar en el Hospital, armando distintos criterios profesionales, distintas formaciones y distintas concepciones.

El conocimiento y difusión de este tema es de singular trascendencia no sólo por el tratamiento de sus distintas manifestaciones, sino porque pensamos incidirá decisivamente en la proyección futura del problema y se podrá trabajar fundamentalmente en la prevención.

Seguramente prevenir en violencia familiar evitará muchos daños y sufrimiento al individuo, a la familia, a la sociedad.

Dra. ANA GILLER

PRESENTACION

Se presentan los trabajos del grupo de Violencia del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear".

Considerada la violencia como una emergencia, éste tema despertó nuestro interés desde la actuación previa en el Hospital P. Piñero hace ya varios años.

Actualmente se han iniciado las actividades con la atención de mujeres golpeadas y en un futuro se desarrollará la tarea con jóvenes y adolescentes.

Los trabajos que se presentan están relacionados, uno con una aproximación teórica que intenta desarrollar una explicación global y abarcativa de la Violencia Familiar y sus distintas formas clínicas, y el segundo es la descripción de la tarea actual en el Consultorio de Violencia del Hospital.

Dra. ANA GILLER
Dr. OSCAR TABER

Concepción circular de la violencia familiar

Dra. ANA GILLER

Médica Psiquiatra. Directora del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear".
Warnes 2630. Capital

Dr. OSCAR TABER

Médico Psiquiatra. Jefe de Consultorios Externos. Dpto. de Emergencias Psiquiátricas del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear".

Trabajo presentado en el "Congreso Mundial de Abuso y Negligencia en la Infancia y Adolescencia", realizado en Río de Janeiro, Brasil, en setiembre de 1988.

"Si quieres ver la verdad claramente no estés preocupado con el bien y el mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente".

De un Maestro Zen.

En la tradición bíblica, con la descripción de la primera familia, aparece registrado el primer caso de violencia familiar, la muerte de Abel, en manos de su hermano Caín. Se observa en la tradición un hecho singular; la violencia es tan antigua como la familia y un problema de relación se dirime con la agresión física.

El relato bíblico comienza con la pareja humana, su desobediencia, la adquisición del conocimiento del bien y del mal, la violencia y, como respuesta el castigo.

Desde esta aproximación, la violencia

queda encuadrada en el concepto de moralidad. Una secuencia lineal claramente definida la puntúa con el establecimiento de un victimario y una víctima, un agresor y un agredido, un culpable y un inocente.

Sin descartar el sentido de la interpretación de la lectura moral lineal, pensamos que una aproximación al tema, desde una perspectiva circular, en tanto involucra conceptualmente a todos los participantes de la situación violenta, podrá ampliar las posibilidades de la interpretación de este complejo fenómeno, iluminando aspectos poco claros de la situación y explorando nuevas alternativas para su modificación.

¿Qué lleva a que una escalada termine en un acto violento?

¿Cómo alguien que ocupa la posición superior de la relación complementaria, actúa la violencia?

¿Cómo alguien que ocupa la posición secundaria de la relación complementaria, actúa para hacerse acreedor de un acto de violencia?

¿Qué motivos encuentra el agresor para ejercer su descarga?

¿Cómo consigue el agredido provocar la descarga violenta?

¿Cómo una cuestión de dirimir el poder, desemboca en la violencia?

Seguramente éstas son algunas de las preguntas que todo aquel que se haya interesado en el tema se ha formulado.

Vamos a desarrollar algunas consideraciones.

El ser humano deberá aprender a manejar las diferentes posiciones de la complementariedad relacional dentro de la familia primero, y luego en el ámbito social.

Así, la comunicación entre las personas se desarrolla en base a acordar las for-

mas en que dentro del vínculo se establecerán los acuerdos y desacuerdos, debiendo negociarse cuáles serán las pautas permitidas o inhibidas entre los que interaccionan.

Estos mecanismos se realizan desde el primer momento del establecimiento de una relación y esto vale para la formación de la pareja, para la relación con los hijos, entre hermanos, con las familias políticas, etc. La familia se forma en la exploración de las pautas permitidas o prohibidas de las diversas transacciones. Es la pareja en la convivencia la que va estableciendo las modalidades de comunicación.

Cada miembro de la pareja trae sus experiencias comunicacionales aportadas desde cada familia de origen, con lo permitido y prohibido para cada caso. Acordado el código común, esto será transmitido a la descendencia.

De esta manera, acuerdos y desacuerdos serán negociados, quedará así establecida la forma en que se hará la negociación. La negociación de los desacuerdos implicará cuáles serán las formas acordadas para su resolución.

Pareciera así, que la violencia se constituye para algunas familias en una fórmula acordada para la negociación de los desacuerdos.

Es así que en las familias a las que llamaremos violentas, o maltratadoras, el código de comunicación incluye el acto violento como instancia permitida, para resolver un desacuerdo o bien es la pauta acordada para finalizar una negociación no resuelta.

Es decir que en códigos familiares donde la violencia es admitida, ésta es vista sólo como un modelo de vinculación, aceptándose como la pauta repetitiva de

un código de comunicación que la incluye como forma de transacción permitida.

La práctica de la violencia en la familia exige una legalidad que la avale, la comparta y la transmita.

Si bien la cultura social inhibe la violencia como valor compartido para la convivencia, hay familias cuya cultura íntima la legitima.

La violencia estalla en la culminación de una escalada que puede terminar con la muerte, la locura, o el abandono de uno de los miembros del grupo.

Aunque la violencia se puede manifestar en el campo de la físico o de lo emocional, pensamos que como fenómeno reconoce una raíz común. A los fines descriptivos podrá ser útil discriminar las manifestaciones pero no olvidando este antecedente que permitirá observar su coexistencia, o bien reacciones alternativas en un individuo o en distintos miembros del grupo familiar.

Quien actúa la violencia, la vivencia como la respuesta adecuada a una situación originada exteriormente y quien la padece la recibe como una acción injusta, inesperada y proveniente de las circunstancias del agresor.

Ni el agresor registra su incapacidad para inhibir su paso al acto violento, ni el agredido tiene clara su condición de provocador de la violencia.

Atrapados en el código compartido de la violencia, víctima y victimario han caído en un círculo vicioso del que no logran salir.

Este círculo vicioso se establece en los términos de una relación complementaria rígida, en la que quien ocupa la posición superior sólo tolera un interlocutor en la posición secundaria de la que no deberá salirse.

Quien ocupa la posición secundaria de la relación complementaria no acepta, no avala o descalifica la posición superior. Esto puede ser en respuesta a una realidad de dependencia como en el niño, o frente a la fantasía de imposibilidad de salida como en el caso de un adulto.

La violencia estalla cuando este equilibrio estable e insatisfactorio se rompe.

Lo que el sistema no avala es el paso de la complementariedad a la simetría, ni avala la posibilidad de que se alteren los roles de definición dentro de la relación complementaria.

Quien se salga de la modalidad aceptada y designada, es castigado violentamente.

Esto se aplica a quien ocupe ese lugar sin importar que sea padre o hijo, niño o anciano, adulto o adolescente, marido o mujer; incluso puede ser hasta un animal doméstico.

Por esto pensamos que en la necesidad de reencuadrar los hechos de violencia familiar en una concepción abarcativa del fenómeno violento global, que dé cuenta de las distintas formas clínicas con que se manifiesta, por ejemplo niño maltratado, mujer maltratada, etc.

¿Qué ocurre con los distintos roles de la relación?

La evolución natural que lleva al trato maduro entre pares en la relación, es percibido como desafío, desacato, competencia, irresponsabilidad, abandono o desamor.

La relación de pares no existe con el sentido de igualdad de equivalencia y todo se dirime en un terreno de contienda.

La debilidad en lugar de estimular la protección y favorecer el fortalecimiento y desarrollo, provoca sometimiento.

Por otro lado la autoridad estimula el sentido de rebelión, desacato, desafío y represión, agresión y castigo, desacato y sometimiento se suceden sin fin.

¿Qué pasa con el individuo en el círculo de la violencia?

Una sociedad altamente competitiva, con una marcada valoración por el rendimiento, la juventud, la producción donde todo aquél que no alcanza el nivel aceptado, es descalificado, estimula el rechazo violento de quien se encuentra en posición secundaria o inferior.

Quien ocupa la posición superior no tolera la salida del lugar a la posición secundaria, porque esta salida no le es tolerada. Nadie tolera para sí la salida del lugar establecido.

La exigencia del éxito por ejemplo, es tal que el fracaso vivido como caída de un nivel superior ideal, a otro secundario frustrante, desemboca en formas de violencia auto-dirigida. Los padecimientos orgánicos de los pacientes sobre-adaptados o los cuadros por stress servirían para ejemplificar este modelo. Otro caso sería el de los suicidios en adolescentes, como solución al conflicto planteado ante la intolerancia al fracaso, al no alcanzar las metas valoradas y establecidas.

Es decir que con esto llevamos el concepto de violencia en lo físico o mental de lo relacional a lo individual, extendiendo el concepto de violencia de lo familiar a lo autoinferido.

Quien aprendió el trato violento, tratará violentamente y se tratará violentamente.

No hay reconocimiento de la limitación del otro, ni de la propia limitación, y la respuesta violenta es la aceptada.

Así en estos individuos la falta de violencia no significa su ausencia sino que

sólo puede representar una evitación defensiva.

Allí es donde se impone la tarea terapéutica de crear nuevas líneas maduras de desarrollo.

¿Cuándo aparecen manifestaciones de violencia?

Establecidas las pautas de la interacción se llega a un equilibrio en la relación que las circunstancias de la convivencia se encargan de alterar.

Si este equilibrio no presenta las condiciones de elasticidad necesarias para adaptarse a los cambios puede aparecer la pauta violenta como manifestación directamente relacionada con la incapacidad de asimilar el cambio. Así las situaciones de crisis vital pueden manifestarse sintomáticamente a través de exteriorizaciones violentas.

Sirvan los siguientes a modo de ejemplo de situaciones que puedan expresarse violentamente. Por ejemplo momentos en la maduración y desprendimiento del niño pueden provocar su maltrato; la modificación en la estabilidad de la pareja con el embarazo expresarse como maltrato de la mujer; el maltrato familiar y social con los adolescentes por su salida del grupo de origen a la sociedad; la conflictiva relación entre familiares políticos (recuérdese a Romeo y Julieta); la intolerancia con cualquier ser que decline en alguna función valorada, sexual, laboral, el discapacitado o bien la vejez.

Un párrafo aparte merece el tema de la sexualidad como fuente de origen y manifestación de hechos de violencia. Siendo uno de los terrenos más importantes y a la vez más arduos en la negociación de la pareja humana es de observación que en muchos casos en lugar de realizarse la sexualidad como ámbito de

mutuo encuentro y realización se transforme en un campo de lucha y violencia con dos manifestaciones claramente antagónicas y significativamente comunes: la violación sexual donde el hombre realiza el acto sexual contra la voluntad femenina y el rechazo sexual femenino donde la mujer ejerce el poder activo de la negativa.

VIOLENCIA Y EDUCACION:

La sociedad ha desarrollado un alto sentido del rendimiento con una marcada sensación de frustración frente al fracaso. La violencia se ha transformado muchas veces en el medio aceptado para el estímulo o bien en el castigo frente al fracaso.

El lenguaje cotidiano ha cristalizado frases que grafican estos conceptos.

Sirvan como ejemplos los siguientes dichos: "porque te quiero te aporreo", "la letra con sangre entra", "si no haces tal cosa... te mato", "a ese chico le falta un buen chirlo".

La pauta es que quien ocupa el rol de aprendiz cumpla con las expectativas asignadas en la forma y modalidad para él previstos como mandato establecido. Si esto no ocurre la violencia puede ser el método usado para corregir el rumbo.

La educación se transforma, así, de un modelo de desarrollo e investigación, de maduración y adquisición de conocimiento pautado con premio y castigo.

El niño deberá explorar en el trato con sus mayores la posición superior de la relación complementaria a través del juego y de las actividades compartidas.

Este aprendizaje incluirá no sólo la ubicación de la relación, sino la calidad

de la relación en el vínculo. Así ese aprendizaje incluirá la modalidad de violencia o de respeto.

La modalidad de poder con violencia desarrollará sometimiento, rebelión y rechazo. El poder con respeto en cambio desarrollará obediencia, aceptación, así como disenso y tolerancia por las diferencias.

EL TEMA DEL TRATAMIENTO

El entorno social ha tenido una actitud ambivalente respecto de la violencia en el hombre. Aceptada y justificada en algunos casos ha sido rechazada y castigada en otros.

¿Qué soluciones se han intentado en el terreno de la violencia familiar?

Si bien el tema existe desde muy antiguo sólo se ha erigido en problemas de los cuidados en salud mental recientemente, habiendo merecido hasta hace muy poco tiempo el trato de la justicia más que el de los agentes de salud.

Desde la perspectiva lineal la justicia identifica a un agredido como víctima y a un agresor como victimario. Tiende a la separación de los involucrados, interfiere la relación, introduce algún representante dotado de poder con el fin de proteger la figura del débil, impone alguna forma de castigo al agresor, con la finalidad de inhibir el mecanismo y revertir la dirección de las fuerzas.

La pregunta es si éste planteo de solución saca a la violencia del círculo vicioso o si es una instancia que lo mantiene; si recordamos el planteo bíblico aparece el castigo para quien agrede a Caín ("el que mate a Caín será siete veces cas-

tigado").

Habría pues que valorar en qué medida el castigo produce realmente la ruptura de la situación o si violencia y castigo no son también parte de un mismo círculo.

El violento que recibe la sanción social y el castigo judicial, puede en realidad acatar la orden y detiene la acción.

Como conoció el código de la violencia, también puede aprender a inhibir la acción. Pero, ¿en qué medida esto significará el real desarrollo de pautas alternativas de relación?

La observación muestra que en familias maltratadoras, los signos de violencia pueden correrse de un área a otra, de un miembro a otro, de lo relacional a lo individual o de lo familiar a lo social.

Respetar la ley de la violencia significa violar la ley del respeto. Y respeto es la condición de lo que no tiene registro el ejercicio de la violencia.

El tratamiento deberá explorar los caminos del respeto para consigo mismo para con el par, para con el inferior y con el superior, imprimiendo registro, acuñando memoria y desarrollando acción de una pauta inexistente y así salirse del juego macabro del que todos participan.

La perspectiva circular enfoca una visión globalizadora de la violencia familiar permitiendo quizás una comprensión abarcativa de todos los integrantes del fenómeno.

Llama la atención la reiteración y mantenimiento a través del tiempo, de estas modalidades de relación en estas familias, así como la falta de registro temprano de la sintomatología.

Dar asistencia al grupo implica no sólo atender lo sintomático y actual de la consulta, sino que podrá influir en las pautas futuras de la relación en familia y en las

sucesivas relaciones.

En el caso de niños maltratados la tarea con el niño y su familia se impone porque el vínculo con los padres es de por vida y por lo menos fundamental hasta la autonomía madurativa del niño.

En el caso de la mujer golpeada trabajar con la pareja significará para ambos verificar su grado de participación y permitirá enfrentar no sólo la conducta sintomática que los vincula sino buscar una vez pautas de relación tanto en el caso de la continuidad o la separación de la pareja así como la modalidad vinculante con los hijos que pueda haber.

EQUIPO TERAPEUTICO

Vamos a ocuparnos de algunos aspectos que hacen al equipo terapéutico.

Poder observar la problemática de la violencia familiar desde una perspectiva circular exige de los terapeutas poder desprenderse de ciertos conceptos que tienen la visión del observador.

La concepción del terapeuta, en su calidad de observador es un punto fundamental a resolver.

Tengamos presente que la definición de lo observado depende de esa ecuación que representa aquella a observar y la condición del observador.

Son usuales ciertas respuestas de los terapeutas que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta en el tema, por ejemplo, temor, rechazo, identificación con la figura débil, ansia de reparación, etc.

Cualquiera de estas reacciones puede ir en detrimento del terapeuta en su capacidad de generar alternativas en estas familias, con pautas altamente rígidas de relación.

Observar circularmente significa la elección de puntuar circularmente.

Por eso es sumamente importante que quien trabaja en estos grupos lo tenga bien definido.

Los grupos terapéuticos multidisciplinarios pueden resultar de ayuda para el tratamiento de su diversidad de enfoque: médicos, psicólogos, asistentes sociales y el equipo de justicia entrelazados.

El marco de la asistencia institucional puede ser útil en cuanto aporte implícita y explícitamente una legalidad no conocida por estas familias.

La técnica de grupos multifamiliares será una indicación útil para generar nuevos modelos de identificación alternativa, con familias de pares como grupos autoayuda o con familias con otras problemáticas, donde se enriquece el intercambio de culturas familiares diversas.

La estrategia a seguir podrá ser trabajar con todo el sistema familiar, con diferentes subsistemas, o aún con el individuo, pero creemos que la concepción familiar y la puntuación circular será de gran ayuda para el que se aproxime al tema.

En resumen, pensamos la violencia familiar como modelo relacional que abarca a todos los miembros del grupo, transmitido por generaciones, avalado por el entorno, compartido como forma de comunicación, que tiene una pauta repetitiva relacionada con la intolerancia al corrimiento de las posiciones establecidas de la relación complementaria y la no aceptación de la genuina paridad, con manifestaciones en cualquiera de los vínculos familiares, incluso del individuo consigo mismo y donde la percepción de los valores está significado por contenidos de dominio y luchas. No se observa el senti-

do armónico de la autoridad, la obediencia o el compartir, sino la sensación de autoritarismo, sometimiento y rebelión.

RESUMEN

Presentamos este trabajo intentando relacionar distintas formas de violencia familiar en un modelo teórico único.

Si se piensa como un modelo de relación que abarca a todos los miembros del grupo familiar, que es transmitido por generaciones, avalado por un entorno, compartido por todos como una forma de comunicación y que tiene una pauta repetitiva relacionada con la intolerancia al corrimiento de las posiciones establecidas de la relación complementaria y la no aceptación de una genuina paridad.

Las manifestaciones se pueden presentar en cualquiera de los vínculos familiares, incluso del individuo consigo mismo y, donde la percepción de los valores está significada por contenidos de dominio y lucha, no existiendo el sentido del respeto y tolerancia.

SUMMARY

We display this work trying to relate different ways of family violence in a unique theoretical model.

It is thought as a relational pattern which involves every member of the fami-

ly group, that is transmitted through generations, supported by the environment, shared by everyone in the group as a way of communication and that has a repetitive pattern related to the intolerance towards the discharge of the established position of the complementary relation and the non-acceptance of the genuine parity.

Manifestations may be present in any family bond, even in the individual with himself and where the perception of the values is meant by contents of power and fight, lacking of the sense of respect.

BIBLIOGRAFIA

- MATURANA, H., "Diálogos con el Dr. H. Maturana", en *Cuaderno de Terapia Familiar*, Ed. CETEFA, Rosario, 1984.
- SLUZKI, C., BAVIN, J., "Simetría y Complementariedad, una definición operacional y una tipología de diadas", en *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 1965, p. 321-330.
- WATZLOWICK, P., y otros, *Teoría de la Comunicación Humana*, Ed. Tiempo Contemporáneo, 1973.
- WALKER, L., *The Battered Woman*, Ed. New York, Harper and Row, 1979.
- MINUCHIN, S., *Familias y Terapia Familiar*, Ed. Gedisa, 1974.
- ROBERTS, A.R., *A Systems Theory Approach* (Giles Sims). Springer Senes on Social Work, Volume I.
- SELVINI PALAZZOLI, M., *Paradoja y Contraparadoja*, ACE, Buenos Aires.
- VON FOERSTER, H., *Sociedad Argentina de Terapia Familiar y ASIBA*, 1988, Bs. As.
- MATURANA, H., *Sociedad Argentina de Terapia Familiar y ASIBA*, 1988, Bs. As.
- BATESON, G., *Pasos hacia una Ecología de la Mente*, *Simetría y Complementariedad*.

Violencia Familiar

**Equipo de Violencia Familiar.
Consultorios Externos. Hospital de
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de
Alvear".**

Profesionales integrantes del Equipo:
Dra. Ana Gillier. Directora del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de
Alvear".
Dr. Oscar Taber. Jefe de Consultorios Externos.
Lic. Amelia Somoza. Jefe de Servicio Social.
Lic. Norma Vidal. Psicóloga.
Lic. Sofía Levita. Psicóloga.
Lic. Patricia Madrid. Psicóloga.
Lic. Raúl Fernández. Psicólogo.
Lic. Viviana Levato. Psicóloga.
Lic. Judith Ben Davis. Psicóloga.
Lic. Elvira Ferradás. Psicóloga.
Lic. Inés Roch. Psicóloga.
Dra. María de los Angeles García Vara. Médica.
Lic. Silvina Madanes. Asistente Social.

El Equipo de Violencia Familiar comenzó a funcionar en marzo próximo pasado con tres profesionales; actualmente está formado por ocho psicólogos, una médica, un asistente social, y dos abogados.

Se trabaja en consultorios externos con pacientes que se presentan espontáneamente, o que son derivados por otras instituciones. La primera vez son recibidos por la asistente social, quien junto con el futuro terapeuta, confecciona una entrevista pautada, donde se recaban en profundidad, datos concernientes en particular a la historia de la violencia conyugal y de las respectivas familias de ori-

gen. Dicha encuesta fue tomada de un modelo americano, y además consta de dos módulos de veinte preguntas cada uno que debe completar el paciente.

En un comienzo, tomamos como referencia el trabajo realizado por otras instituciones existentes en el país, abocadas específicamente a la asistencia de las mujeres maltratadas, tanto física como psíquicamente. Si bien estas experiencias nos resultaron valiosísimas, vimos la necesidad de incorporar a nuestra tarea la asistencia psicológica de la mujer y también de su pareja, cuando es aceptada. Es así, que el servicio se fue estructurando de la siguiente forma:

- Terapia Individual
- Grupo de Autoayuda
- Asistencia Social
- Orientación Jurídica

Es interesante destacar que algunos de los hombres que concurren a la consulta lo hacen en forma espontánea e independientemente de su pareja, y que otros decidieron venir luego de un tiempo de tratamiento de las mujeres. Estos hombres también comenzaron con terapia individual una vez por semana, aproximadamente al cabo de dos meses de tratamiento, se les propuso formar un grupo, pero el intento falló puesto que pusieron excusas de trabajo, horarios, etc., lo que fue interpretado como una resistencia que algunos reconocieron alegando no animarse a enfrentar esa situación.

Creímos conveniente no insistir en ese aspecto y esperar que la evolución del tratamiento determinara el momento oportuno.

Esta necesidad de operar de manera

más amplia en situaciones de violencia y que nos impulsó a sondear los aspectos psicológicos y el funcionamiento psíquico de los hombres y mujeres involucrados en acciones violentas, también nos llevó a pensar que en el momento oportuno deberemos incluir el trabajo de pareja y familia.

En cuanto al grupo, se constituyó como grupo de autoayuda en que cada una contaba sus propias experiencias en forma anecdótica, identificándose en la problemática, y sintiéndose contenidas y protegidas.

La función del grupo fue, pues, de contención, protección, identificación y salida del aislamiento, lo que operó en la canalización del miedo, la desinhibición, el fortalecimiento psíquico y por ende, de la autoestima.

Actualmente el grupo se encuentra en un momento en el que el esclarecimiento es posible y en que la anécdota va siendo reemplazada por la reflexión.

Tal desarrollo está dando espacio para que cada una vaya trayendo temas de interés particular que el grupo toma para su elaboración con mucho interés. Estamos pensando incluir, en coordinación con los terapeutas individuales, algunos temas que surgen en la terapia y que son variables constantes en esta problemática.

Dentro de una casuística reducida que no nos permite hacer afirmaciones contundentes, y sin pretensiones de teorizar o hacer hipótesis apresuradas, observamos que las mujeres maltratadas que atendemos en este servicio, tienen algunos rasgos comunes, y otros que las hacen considerablemente diferentes.

Las características comunes son: celos, asumen el rol de madres frente a su pareja, ambicionan superarse tanto económica

como intelectualmente. En ciertos aspectos se muestran muy suficientes y pareciera sentir placer al hablar de los aspectos negativos del marido, aunque al mismo tiempo lo protegen.

Lo que hemos encontrado como rasgo común importante, es que son personas que sufren intensas ansiedades ante la separación. Su angustia central y por supuesto precedente a su relación de pareja, es angustia de separación o ansiedad de abandono.

Las parejas a las que se unen, son sumamente controladores y dominantes, y aunque las someten a malos tratos, les aseguran por sus propias características similares a la de las mujeres pero encubiertas de bravura, que el vínculo no se romperá, y abundan las amenazas ante la sospecha de un intento de abandono del hogar.

A esta altura, podemos decir que ambos miembros de la pareja, tienen en común temor a la separación y al abandono.

Al parecer sus historias dan cuenta de ello: niños abandonados, y en muchos casos con distintas modalidades de abandono: total o temporal, concreto o psicológico.

Otras veces, por el contrario, fueron hijos de madres muy sobreprotectoras controladoras, dominantes, y siempre con relaciones simbióticas que se repiten en la pareja.

En lo concierne a los hombres golpeadores, estos no suelen consultar espontáneamente. Los que llegan a nuestro consultorio, son "traídos" por sus mujeres, interesadas en modificar la relación establecida en la pareja.

Cito palabras de un hombre golpeador que consultó por motus propio: "tengo miedo de que mi mujer termine muerta y

yo en la cárcel". Tanto en el primer caso como en el segundo, lo que se observa es que estos hombres logran establecer un buen vínculo terapéutico, cumpliendo con el contrato que se pacta en estos casos. Ya en las primeras entrevistas, la violencia física cesa. Pareciera que el terapeuta y la institución obran a manera de ley que prescribe pautas de conducta y pone límites a las pulsiones deshinbidas de estos pacientes.

Los rasgos comunes a los hombres golpeadores podrían generalizarse así: son hombres con carencias afectivas primarias, y casi siempre se encuentra en sus historias, abandono de uno de los integrantes de la pareja parental, adicciones, pareja parental violenta, lo que determina en el paciente un muy bajo nivel de autoestima y una pareja con características similares en la cual la discriminación individual no existe.

El hombre golpeador, en apariencia omnipotente por su fuerza y coraje, es un hombre inseguro, temeroso de ser abandonado por su pareja, en la cual sustituye e intenta restituir fallidamente el vínculo parental.

En el tiempo transcurrido de nuestra experiencia, se intenta desarticular el funcionamiento narcisista de pareja: el otro como un otro independiente y no prolongación de uno mismo.

No estamos en condiciones aún de hablar sobre el alta de alguno de estos pacientes, pero de ser ésta definitiva, cabría la necesidad de un seguimiento posterior.

En cuanto al servicio social, éste interviene desde el momento de la admisión. A partir de la primera entrevista, se trabaja en el establecimiento de una relación de contención profesional e institucional. Cuando el paciente llega a la institución,

lo hace sintiéndose aislado, no comprendido y al igual que con pacientes femeninos, se sienten culpables y desconociendo sus derechos.

El servicio social trabaja en el esclarecimiento de estas situaciones. Asimismo y ante situaciones de riesgo, se orienta sobre la posibilidad de separación temporal, reubicación de la mujer y sus hijos, de sus derechos respecto a estos y sus bienes, la exclusión del hombre del hogar, derivando a la consulta jurídica.

Se trata de una tarea que continúa en el intercambio permanente con los terapeutas, en el conocimiento de los progresos y dificultades de la terapia individual y en el grupo de ayuda mutua.

Sobre el tema de los abogados, informan que en un primer momento hay confusión, la consulta no es clara, es como que confunden la demanda psicológica con la legal, y el planteo propuesto es el divorcio o la separación. Pero en general, desconocen sus derechos y llegan muchas de ellas frustradas por la policía que rechazó y minimizó sus pedidos de ayuda. La información que se les brinda es esclarecedora en cuanto a la diferencia entre exposición y denuncia policial, qué actitud tomar en caso de denuncia y lesiones, a qué se considera abandono del hogar, sobre el pedido de exclusión del hogar del marido, si van a iniciar juicio de divorcio, derechos sobre los bienes, la tenencia de los hijos, alimentos, etc.

Destacan los profesionales, que en estas mujeres hay una gran posibilidad para tomar medidas drásticas, y que creen que su obligación es ser pasivas. Además creen y sienten que la sociedad no las protege. Teniendo en cuenta lo breve de nuestra tarea, no tenemos los datos estadísticos formales, pero de un relevamiento hecho

a través de las fichas, estamos en condiciones de destacar ciertos datos relevantes tales como que alrededor del 70% de las mujeres llevan más de 10 años de unión, el 90% de los maridos provienen de familias de origen violentas, y de las mujeres, el 60%.

El nivel de escolaridad es bastante parejo en ambos miembros de la pareja. Entre las mujeres, sólo unas pocas tienen sólo enseñanza primaria, la mayoría tiene secundaria completa o incompleta, y un 20%, educación terciaria.

Entre los hombres, la mayoría cursó secundaria completa o no, y solamente unos pocos, escasamente la primaria.

La violencia extrafamiliar se manifiesta hacia las cosas y animales, y en tercer término, hacia otras personas. El motivo principal de la violencia son los celos, y con menor frecuencia problemas de dinero, embarazo, los hijos y el trabajo.

Casi el 90% de nuestras asistidas, desempeña actividades laborales fuera de la casa, en forma independiente en la mayoría de los casos, mientras que en los maridos, la inestabilidad laboral es muy frecuente.

En cuanto al tipo de maltrato, todas sufren violencia psicológica, y casi el 90%, física y psicológica. Hemos encontrado que la violación marital es un hecho bastante frecuente.

Con respecto a los hijos, la tercera parte son golpeados. Casi un tercio de las mujeres fueron ya maltratadas durante el noviazgo, otro tanto en el comienzo del matrimonio o durante el embarazo, y el resto, después del nacimiento de los hijos.

El 40% de los hombres son alcohólicos, y en un 25% hay otras adicciones. El 45% de las pacientes llegaron al servicio derivados por otros profesionales o institu-

ciones; el 40% conoció el servicio por la televisión, y el resto, por amigos o caja PAN.

Del total de los casos, encontramos:

- Mujeres: 25, de las cuales 6 han abandonado el tratamiento.

De ellas, 10 se encuentran en terapia individual y grupal; y 7 en terapia individual.

- Hombres: 6, de los cuales 2 han abandonado el tratamiento, y 4 prosiguen su terapia individual.

Del total general (31 pacientes), tenemos 4 matrimonios, además de encontrarse en terapia individual y grupal.

RESUMEN

El equipo formado por psicólogos, una médica, una asistente social y abogados tomó como referencia el modelo de trabajo de los americanos y agrega a esas experiencias y al grupo de autoayuda la asistencia psicológica de la mujer maltratada y de su pareja, ya que algunos hombres comienzan a solicitar atención.

Esto permite observar ciertos aspectos de sus respectivas personalidades, siendo el más relevante la intensa angustia de separación que ambos padecen y que expresada de manera diferente pero complementaria, permite estas uniones simbióticas como intento de restitución del vínculo parental.

La violencia surge ante un profundo sentimiento de abandono que reedita el de la infancia; la respuesta de la otra parte es el sometimiento y el miedo que encubre el miedo a la pérdida del objeto.

La terapia individual, tendiente a refor-

zar la autoestima, completa la acción terapéutica que aporta el grupo de autoayuda cuya función principal es la identificación con sus pares, contención, protección y salida del aislamiento.

La atención psicológica se completa con la asistencia social y jurídica.

SUMMARY

The team formed by psychoanalysts, a doctor, a social worker and lawyers used a USA reference model, adding to that experience and to the self-assistance group the psychological assistance of battered women and their partners, do to the quest for help from some men.

Some aspects of their both personalities are observed. The most outstanding being

the intense separation anxiety suffered by both sides and expressed in a different but complementary way, thus creating symbiotic relationships which are a way of restoring the parental bond.

Men's violent behaviour is brought about by a deep feeling of abandonment such as experienced in childhood. The women's reaction is submission and fear. Fear due to anxiety of the loss of the object.

The individual psychological therapy reinforces the patient's self-esteem and completes the therapeutic action of the self-assistance group. The main objectives of this group are the identification with its peers, protection, reassurance and the overcoming of isolation.

This kind of counseling is completed by social and legal assistance.

terapia familiare

rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale

The Journal is published quarterly (March, July, November) by the Rome Family Therapy Institute.

Editor in Chief: M. Andolfi

Editorial board: P. Menghi, A. Nicolò, C. Saccu

Its aim is to promote research and present studies in the following areas:

- ☐ Theory and practice of family therapy
- ☐ Training in family and marriage therapy
- ☐ The individual, the family, social systems and their correlates (schools, neighborhoods, social and health services, etc.) from a systems point of view.



The journal is published in conjunction with: *Family Process, Journal of Marital and Family Therapy, The American Journal of Family Therapy.*

The journal, established in 1977, has been the only Italian publication in the field of family psychotherapy. It has always been active in the cultural and scientific debate in this field both in Europe and in America.

It includes contributions by:

H. Aponte, L. Boscolo, D. Bloch, I. Boszormenyi-Nagy, M. Bowen, P. Caillé, G. Cecchin, M. Elkaim, J. Framo, J. Haley, K. La Perrière, S. Minuchin, P. Papp, G. Prata, M. Selvini Palazzoli, H. Stierlin, C. Sluzki, P. Watzlawick, C. Whitaker, I. Zwerling.

One year subscription

Europe: u.s. \$ 25
Extra-European countries: u.s. \$ 30

Checks payable to:

I.T.F., s.r.l. - Via Reno, 30 - 00198 Roma

Violencia y Familia. Una teoría explicativa

Dr. REYNALDO PERRONE

GRUPO DE INVESTIGACION "VIOLENCIA Y FAMILIA"

IFACT. Institut de Formation et d'Application des Thérapies de la Communication. 3 Rue de la République 42000 Saint-Etienne

Han participado del grupo de investigación:
Dirección Dr. R. Perrone
Coordinación: Martine Nannini
Jacques Devanthery, Reine Gibert,
Annick Grivet, Monique Lefoulon, Joël Picart,
Nathalie Quinet, Marie-Thérèse Roussel,
Annie Rouvin, Marc Sieber,
Marie-France Thierry

I. INTRODUCCION

En una perspectiva histórica es cierto que desde los tiempos más remotos la familia aparece como uno de los lugares privilegiados de la violencia, dado que es el lugar del aprendizaje social de base.

La familia fue siempre un lugar sin ley y aún quedan residuos importantes de esta tradición.

Para paliar esta irregularidad se han tratado de encontrar mecanismos socializados de reglamento de conflictos, introduciendo en el área familiar la ley social.

Sin embargo, hay que señalar la dificultad que tuvo la justicia secular para intervenir igualitariamente en los asuntos de

violencias familiares y transformarlos en temas de su jurisdicción a la par de los demás casos de violencias sociales.

Si bien la familia fue siempre un lugar sin ley, existe actualmente una marcada tendencia a asimilar el espacio familiar al espacio social suprimiendo las últimas barreras que permitían creer que en la familia, sus integrantes podían sustraerse a la ley general e igualitaria.

Los problemas de violencia familiar constituyen un desafío para nuestra sociedad y a diferentes niveles se trata de buscar modos de intervención para remediar, atenuar o resolver dichos problemas.

Sin embargo, los trabajadores sociales, de la justicia y de la salud mental no están suficientemente equipados para hacer frente a los problemas presentados por las familias de transacción violenta.

El objeto de este trabajo es aportar una explicación interaccional de estos fenómenos y proponer algunas posibilidades de intervención para resolverlo.

A. PRESUPUESTOS

- 1º La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno interaccional.
 - 2º Los participantes de una interacción están todos implicados y son por lo tanto responsables.
 - 3º En principio todo individuo mayor, teniendo las capacidades suficientes para una vida autónoma, es el garante de su propia seguridad. Si él no cumple con esta responsabilidad, estimula los aspectos no controlables y violentos del otro, y así organiza y mantiene una interacción violenta.
- Esta idea permite concebir las relacio-

nes humanas bajo la forma de un sistema transaccional donde cada individuo debe realizar operaciones que tienden a salvaguardar su seguridad personal. Si estas operaciones no se realizan las transacciones se organizan de tal manera que la emergencia de la violencia se vuelve posible.

- 40° Cualquier individuo puede ser violento bajo modalidades o manifestaciones diferentes. Se trata de una situación de equilibrio inestable entre violencia y no violencia en el mismo individuo, más que de estados opuestos donde el uno excluye al otro.

B. LA HIPOTESIS

“En las familias que se estructuran según un modo violento, existe un modelo circular específico en las transacciones.

Debe tratarse de poner en evidencia las secuencias comunicacionales repetitivas y las retroacciones positivas a ciertos mensajes que conducen a la emergencia de actos de violencia en el seno de la familia”.

Es importante definir los conceptos que han servido para elaborar esta hipótesis.

1) Acto de Violencia

Se entiende para acto de violencia todo ataque a la integridad física y psíquica del individuo con un sentimiento de coacción, apremio y peligro percibido por el sujeto.

2) Modelo Circular

El modelo circular puede explicarse a través de una cadena de eventos interdependientes. Si A lleva a B y B lleva a C, y C

lleva a D, se trata de un sistema lineal. Pero si D envía a A el sistema es circular y escapa a la lógica del sistema precedente.

3) Secuencia

El término “secuencia” presupone la unidad de análisis no causal que integra las transacciones interpersonales. Se trata de utilizar la interacción como una primera información y no las características de cada individuo en particular. Aún si la observación está dirigida a una persona su conducta es significativa en tanto que es estimulante de la conducta del otro y no en función de sus motivaciones.

Una transacción es la relación entre dos mensajes contiguos, es decir, el modo de eslabonarse un mensaje con el que precede, el mismo mensaje con el que lo sigue y así sucesivamente. Una secuencia puede incluir varias transacciones.

4) Retroacción

La retroacción es el proceso según el cual una parte de la información es reenviada al sistema que de esta manera se autorregula. La retroacción positiva provoca una desestabilización del sistema mientras que la retroacción negativa mantiene el equilibrio.

5) Mensaje

El mensaje es una información que circula a través de canales comunicacionales verbales, no verbales y contextuales.

C. METODO

El campo de investigación fue esencial-

mente la familia. Las familias observadas fueron elegidas entre aquellas con las cuales trabajaban los participantes del grupo, de acuerdo con los criterios siguientes:

Familias en las que la violencia había sido detectada socialmente, o sea, señalada al juez (adultos o niños) o que había sido objeto de una intervención de la policía o de alguna estructura de asistencia social, de terapia o de tratamiento médico.

Sólo fueron retenidos los actos de violencia vividos entre los miembros del sistema familiar.

No se aplicó ninguna restricción en lo referente a la cultura, la patología o la intensidad de los actos de violencia.

No se prestó especial atención a la problemática intergeneracional, a las causas intrapsíquicas ni a las causas sociales.

Existía la voluntad explícita de poner en evidencia secuencias e interacciones y no las causas o los orígenes individuales de la violencia.

Durante la interacción violenta las personas implicadas pueden ser clasificadas en dos categorías: los participantes y los actores designados.

- a) los *participantes* son aquellos que están presentes en el momento de la acción violenta;
- b) los *actores designados emisores* son las personas que actúan la ejecución del acto violento.

Se entiende por *actores designados receptores* a las personas que actúan recibiendo el acto violento.

Parece más juicioso hablar de emisores y receptores que de agresores y víctimas dado que estos términos hacen referencia a una concepción lineal.

II. INTERACCION VIOLENTA

En el curso de la investigación aparecieron dos formas de violencia en relación con dos formas de interacción.

- a) la violencia “agresión - cólera” se observa entre dos personas que se hallan en relación simétrica.
- b) la violencia “castigo” se observa entre dos personas que se hallan en relación complementaria.

Precisemos lo que hay que entender por relación simétrica y relación complementaria.

- a) *En la relación simétrica* A y B rivalizan y sobrepujan (escalada). Si A define un valor, B a su vez dará otra definición que provocará a A. Los miembros actúan como si tuviesen el mismo status y realizan esfuerzos para el establecimiento y el mantenimiento de la igualdad.

- b) *En la relación complementaria*, A y B están de acuerdo sobre la definición, la función y el lugar de cada uno. Hay una adaptación mutua. A define un valor. B acepta su definición.

En la relación complementaria, los miembros presentan un status desigual. El “pattern” se basa en la aceptación y la utilización de las diferencias.

En cada una de estas dos relaciones, es posible inferir ciertas características diferenciales en cuanto a la forma de la violencia.

- 1) *En la relación simétrica:*

La violencia se convierte en golpes, en agresiones recíprocas que pue-

den llegar hasta la muerte. A veces hay períodos de calma durante los cuales los actores pueden prestarse asistencia.

La violencia puede entonces retroceder durante el tiempo de una relación complementaria.

Se trata de una *pausa complementaria* en el contexto de una relación simétrica. En este tipo de relación la identidad está preservada, existe una cierta autoestima y a pesar del rechazo y de la violencia, se reconoce, existencialmente al otro.

2) En la relación complementaria:

La violencia toma la forma de un castigo. Es el caso de los niños descuidados, encerrados en el armario, en el sótano. Puede haber una falta de asistencia, una ruptura y una carencia total de la relación afectiva y de cuidados maternos.

Notamos en ambos miembros una autoestima muy baja; en el castigado, un trastorno importante de la identidad y el sentimiento de tener una deuda hacia el otro que justifica los golpes, haciéndolo sufrirlos sin decir nada.

El actor emisor es a menudo rígido, carente de empatía, impermeable al otro y a su diferencia salvo en lo que ésta le muestra de peligroso para su propia existencia. Está impregnado de ideas fijas, sometido a repeticiones, y a comportamientos encaminados a corregir lo que es diferente de él. Se nota una denegación del otro, un no reconocimiento de su identidad.

En los dos casos se nota: en el que es violento, un deseo de mode-

lar al otro hasta fracturarlo para hacerlo volverse lo que "tiene que ser", es decir, conforme a la imagen de su propio mundo.

III. ORGANIZACION RELACIONAL DE LA VIOLENCIA

Es bastante excepcional ser testigo de una secuencia de interacción violenta. Efectivamente, la presencia de un observador en una situación de violencia modifica el marco de funcionamiento de esta secuencia.

En cambio, es frecuente poder recoger a posteriori los testimonios de los protagonistas a veces incluso "en caliente". Son sobre todo los comentarios y relatos detallados que sirvieron de base a este trabajo. Antes que nada hay que destacar esta constatación: *el carácter repetitivo, incluso casi estereotipado de las secuencias en las que emerge la violencia.*

Un ejemplo típico será la situación de la familia S. Aquí la interacción que desemboca en la violencia constituye un verdadero guión donde todo parece previsto por el conjunto de actores y de participantes. Al mismo tiempo se diría que nada es controlable.

La escena se desarrolla un viernes por la tarde. Marco, el padre, quien pasó la semana trabajando lejos de su domicilio, se da cuenta de que su esposa Eliana lleva una prenda o una joya que delata su "infidelidad". Entonces le pega. Los hijos (ya vestidos) salen de sus camas. La hija mayor grita, llora, quedándose paralizada de miedo. La más pequeña se pega a su madre. El segundo va a buscar las mantas, ya listas, que van a servir para pasar la noche afuera. Después de los golpes, Marco que-

da solo en la casa mientras que los demás huyen hasta el otro día. Después la vida normal recobra su curso.

Todo se desarrolla como si entre los actores pre-existiese un acuerdo de hecho sobre "el libreto" de sus relaciones.

El contexto de la violencia: el consenso implícito rígido

Así pues, casi siempre se observa una participación e incluso una preparación de la secuencia de violencia. Todos los participantes están incluidos en la secuencia. Se trata de una especie de contrato, de acuerdo, que convendrá definir: **Consenso Implícito Rígido (CIR).**

A pesar de ser bastante preciso en sus términos, este Consenso no es objeto de ninguna comunicación clara entre los protagonistas. Con mayor razón, no existe metacomunicación. Efectivamente, toda explicación del consenso llevaría a salirse del marco establecido y mostraría el carácter ilusorio del conflicto. Esta imposibilidad demuestra la rigidez de este tipo de organización relacional.

El consenso implícito rígido está inscripto en el marco de la interacción.

Este marco se compone de:

- *un aspecto espacial:* Es el territorio donde la violencia es admitida, el lugar de la interacción violenta. Es a menudo señalado y delimitado con tanto rigor como el del ring, el circo o el estadio.
- *un aspecto temporal:* El momento del desencadenamiento de la interacción y la cronología de la acción están predeterminados.
- *un aspecto temático:* En el sentido en que están previstos ciertos acontecimientos, circunstancias, conte-

nidos de comunicación que desencadenan el proceso.

Este conjunto de elementos tienen un valor de señal tal como el de los tres golpes en un teatro.

Estos aspectos del marco son siempre identificables pero su valor relativo varía de una situación a otra. Así, en el caso donde el aspecto espacial domina, hemos podido observar que un simple cambio de lugar provoca una modificación de la secuencia. Entonces una ruptura del contrato es posible y uno de los actores puede sustraerse del consenso implícito-rígido.

Los Disparadores de la Violencia

- * activación puntual simétrica
- * activación puntual complementaria

Otra característica de la interacción violenta es la manera en la cual cada actor puntúa la secuencia. El comportamiento de uno sirve de justificación al comportamiento del otro.

El que agrede lo hace en el momento preciso en que se siente agredido.

Esto es evidente en una relación simétrica. Pero es más difícil concebir en una relación complementaria por ejemplo entre una madre y un bebé. ¿Tenemos que atribuir un papel de agresor al niño? Parece que sí, ya que la madre explica sus actos de violencia como si fueran una consecuencia de los mensajes amenazantes que ella percibe del niño (por ejemplo llantos o un rechazo de alimentos o incluso la ausencia de reacciones).

- * *Activación puntual simétrica:*

En la relación complementaria se introduce una secuencia de simetría, fugaz, pe-

ro determinante en el proceso que inmediatamente después, desencadenará la violencia.

* Activación puntual complementaria

En el caso de una relación simétrica se producen activaciones puntuales complementarias. Por ejemplo en una situación de escalada simétrica, uno de los protagonistas puede manifestar una actitud dominante o de pseudo abandono de la lucha o de pseudo sumisión. El efecto de estos mensajes será determinante para la inmediata emergencia del acto violento.

Es por eso que estos fenómenos deben ser analizados en términos de comunicación. En vez de hablar de actitudes, de comportamientos, de intenciones, etc... conviene utilizar aquí los conceptos de emisor, receptor y mensaje.

Ciertos mensajes analógicos y digitales puntuales constituyen así *activaciones simétricas en las relaciones complementarias y activaciones complementarias en relaciones simétricas*.

Por supuesto, como en toda comunicación se produce una distorsión eventual entre el código del emisor y la descodificación por el receptor. Así pues, desde el punto de vista de un observador exterior, ciertos mensajes parecerán "reales", es decir, realmente emitidos y otros simplemente "alucinados" por el receptor.

En todos los casos, estos mensajes puntuales son los desencadenadores inmediatos de la violencia.

IV. EL ACTO VIOLENTO

A. Sistema de Creencias y Modelo del Mundo:

Aceptemos que el hombre, para vivir en

sociedad, para organizar su existencia, necesita puntos de referencia. Estos últimos son fundamentales, ya que jalonan el tiempo y el espacio, le dan un sentido al devenir y una connotación a los actos vividos, sea directamente, sea indirectamente. Cada hombre es protagonista, testigo y depositario de situaciones vividas por él o por los otros, y el valor dado a estas miríadas de acontecimientos depende de las tablas de descodificación personales y colectivas.

En sociedad, el hombre percibe, y le da un sentido a lo que percibe.

Le da un valor y una significación a sus percepciones y esto le sirve para elaborar su mapa del mundo que lo rodea.

De hecho realiza operaciones de distinción, ordenando el conjunto de sus percepciones y se construye así su universo cognitivo.

Sin esta planificación no le sería posible sobrevivir y estaría permanentemente amenazado por un caos que lo destruiría. Cuando ordena, le da un valor singular a los objetos percibidos y después un valor absoluto, "real", inmutable en el cual cree.

En otras palabras, percibe con sus receptores sensitivos, que le dan informaciones sobre sí mismo y sobre su medio ambiente; los descifra y después les otorga un valor necesariamente arbitrario, puesto que arbitrario es su sistema de descodificación.

Así construye un mundo adecuado a sus necesidades, recreando una realidad que pasará a ser la suya, y que de ahí en más podrá compartir.

De este modo cree en una realidad *verdadera* que organiza sus acciones y su pensamiento. El modelo del mundo es el mapa, del que se sirve para ubicarse en la

realidad, así como el mapa le sirve al viajero para ubicarse en el territorio.

Pero el mapa no es el territorio, según lo ha explicitado G. Bateson.

Se puede entender por Modelo del mundo el sentido subjetivo, singular, otorgado a las percepciones, el orden acordado a los objetos percibidos así como el valor relativo comparativo dado a esos objetos, la relación subjetiva única establecida percepción tras percepción, distinción tras distinción, experiencia tras experiencia.

Cuando el conjunto de experiencias vividas por sí mismo y por los demás a través de las generaciones constituye un todo coherente y funcional, este conjunto se vuelve un sistema de creencias a las cuales se adhiere, en las que se cree y de las que se sirve para actuar. Tal es, el "Sistema de Creencias".

B. Amenaza y Ruptura del Sistema de Creencias

Ahora parece posible entender el concepto de amenaza y ruptura del Sistema de Creencias.

Se da por sentado que cada individuo prueba y confronta su Sistema de Creencias. Este hecho moviliza y hace entrar en juego estrategias de acomodación o mecanismos defensivos y de transformación de su sistema de creencias y del del otro.

Por cierto, el encuentro de dos seres con creencias diferentes no es un hecho trivial, ni tampoco lo es el encuentro de dos seres con sistemas de creencias que se parecen.

Quizás el motor más formidable para la movilización de las masas consista en poner en fase, con un máximo de coheren-

cia interna, los sistemas de creencias de los participantes.

Efectivamente todo sistema de creencia (incluso cada ideología) está dotado de una fuerte coherencia interna que actúa como una coraza protectora contra la conmoción de la confrontación con *otra realidad*.

Un sistema de creencias no tiene necesidad de ser compatible con la realidad, pero debe darse una lógica y una coherencia interna que justifiquen su existencia.

Las contradicciones no tendrán importancia mientras las redefiniciones sucesivas del contexto garanticen la permanencia de la lógica planteada. Pero más allá de este estado, la coherencia misma se fura y aparecen entonces las acciones de acomodación.

Estas permiten que nuevas integraciones se realicen a través de síntesis creativas inéditas y resultan eficientes cuando son compatibles con el sistema de creencias y lo modifican permitiendo así su evolución.

Si la acomodación es imposible, se crea una situación de ruptura inminente del sistema de creencias y, en consecuencia, de la idea global que el sujeto se hace de su propia existencia.

C. Normalización y Acto Violento en su Contexto:

En este punto una acción dirigida a normalizar "la otra" realidad se vuelve necesaria. El acto violento puede ser interpretado así.

Efectivamente, el acto violento aparece, según este punto de vista, como "un mensaje analógico de normalización del otro" o como "una acción encaminada a

la 'normalización' de la otra realidad". La característica fundamental de esta acción, de este mensaje analógico, es que responde a una consigna prioritaria de normalización, es decir: hacer que el otro corresponda al sistema de creencias propio.

V. TEORIA DE LOS "RELAIS"

Ningún sistema dispone de la posibilidad de auto-observación. No puede tener todas las informaciones acerca de su propio funcionamiento.

Sin embargo puede ser consciente de su propia disfunción, pero entonces choca con los límites impuestos por la organización de su naturaleza. Para que pueda "verse funcionar", es necesario que salga de sus límites; lo puede hacer sólo si las informaciones que da al funcionar son percibidas por una instancia exterior al sistema que reflejándole la imagen de su funcionamiento le permitirá regularse.

Si la instancia exterior al sistema pudiese existir en el interior del sistema, éste se volvería autónomo con respecto a la instancia pre-citada.

Así, esta autonomía podría existir sólo si la instancia exterior fuese interiorizada por el sistema, volviéndose entonces parte integrante de este último, aumentando así su complejidad. La capacidad de incorporaciones sucesivas del sistema lo hace independiente con respecto a las instancias de quienes era previamente dependiente.

Cuando este proceso se realiza, es posible definir la instancia reguladora interiorizada como *regulador*. Este concepto será retomado ulteriormente en este capítulo.

Es necesario recordar que cuando se establece una comunicación entre dos po-

los comunicacionales, ésta puede ser simétrica o complementaria. La última puede tener dos modalidades según que los participantes se sitúen en posición baja o alta (ver croquis 1).

Se establece una "corriente" comunicacional que tiene como particularidad un grado óptimo de tensión y que va hacia la estabilización. Esta observación es fundamental para entender los conceptos que siguen.

Definición del "Relais"

Ahora es posible aplicar el concepto de "relais" a la relación.

Antes que nada, algunas definiciones de este concepto:

1. Una persona, un lugar intermediario entre otras dos personas...
2. Un aparato destinado a producir en un circuito, una modificación dada, cuando ciertas condiciones se realizan en ese mismo circuito.
3. Un dispositivo que retransmite, amplificándola, la señal que ha percibido.
4. Un dispositivo de control de la intensidad de la corriente.

El relais puede concebirse como una instancia que detecta una diferencia significativa en la estabilidad de una relación.

Cuando percibe una desestabilización, él se activa e interviene para evitar un aumento de los trastornos que originaron la señal.

Definición del Regulador:

Es necesario recordar que la noción de "relais" está asociada a la noción de "Tercero".

Los "Terceros" son los participantes integrados en la constelación familiar, que participan en las interacciones, o también los participantes que pertenecen a una red social, en la cual el sistema familiar está incluido. Ej.: vecinos, trabajadores sociales, justicia, policía. Dijimos antes que un sistema se vuelve autónomo cuando la instancia dirigente exterior era interiorizada por el sistema.

Esta se vuelve parte integrante de aquel provocando un aumento de su complejidad y aportándole al mismo tiempo su capacidad reguladora.

La autonomía está, pues, en relación con la capacidad de incorporación sucesiva por el sistema, de instancias dirigentes de las cuales era previamente dependiente.

Cuando estas instancias están interiorizadas, se vuelven lo que llamamos regulador. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo: "no comas con los dedos... calmate...", etc, quiere decir que el niño no dispone de la posibilidad de auto-observación de su propio comportamiento, su madre, instancia exterior, es entonces el Tercero del sistema - niño. Poco a poco, el niño interioriza el Tercero que se convierte en parte integrante.

Desde entonces el niño es independiente de la instancia exterior; la interiorización sucesiva de las instancias exteriores lleva a una complejidad creciente del sistema.

En efecto, cuando el más importante es la interiorización de las instancias exteriores, más se complejiza el sistema. Estas instancias interiorizadas vuelven al sistema independiente del exterior.

Los "relais" exteriores están entonces destinados a ser interiorizados por el sistema y le permitirán acceder a otras fun-

ciones. Ya no son "relais", sino que (como se precisó anteriormente) forman parte integrante del sistema y son llamados *reguladores*.

El hombre interioriza durante toda su vida Terceros, y por la presencia cada vez más importante de reguladores, su estructura es cada vez más compleja. Estos le servirán simplemente para regular su comportamiento.

Sin embargo, también es posible concebir que una minusvalía, pueda disminuir su capacidad de regulación y en este caso el sistema parte a la deriva o es nuevamente dependiente de la instancia exterior.

Los mismos efectos pueden aparecer igualmente cuando el proceso de interiorización fracasa.

Después de haber definido los conceptos de "relais" y "regulador", es posible entender cómo funcionan.

Según el esquema de la figura 3: cuando dos polos A y B están comunicando, se puede observar que tres "relais" situados en tres niveles diferentes pueden estar implicados en esta relación.

1er. Nivel: Se trata de individuos cuya posición les permite detectar una diferencia con respecto a la tensión óptima entre dos polos en comunicación.

Como "relais", se activan cuando la calidad de la relación se modifica e intervienen para evitar una ruptura, una crisis.

Se trata de participantes del sistema familiar o que pertenecen a la red social contigua a la familia (vecinos, familia extensa...).

2do. Nivel: Se trata de individuos exteriores al sistema familiar y a su red, que como "relais", serán activados cuando el

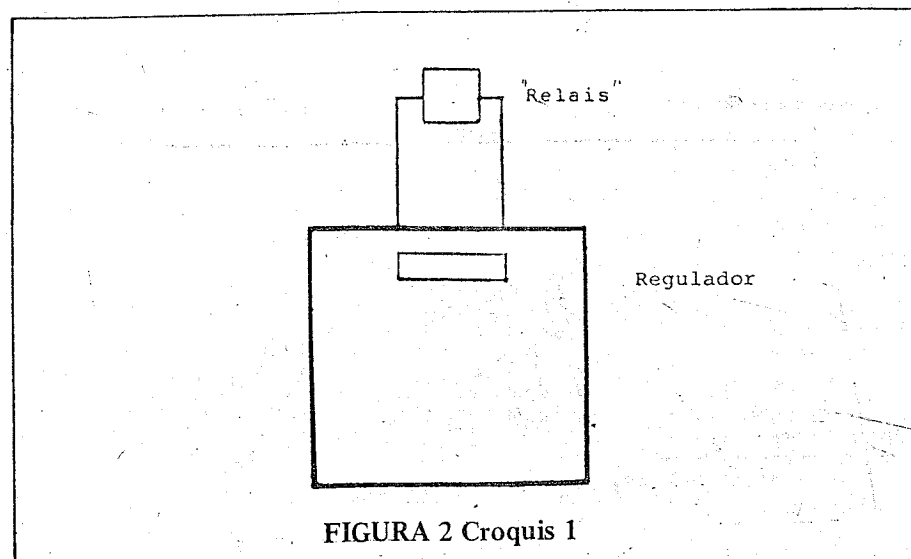


FIGURA 2 Croquis 1

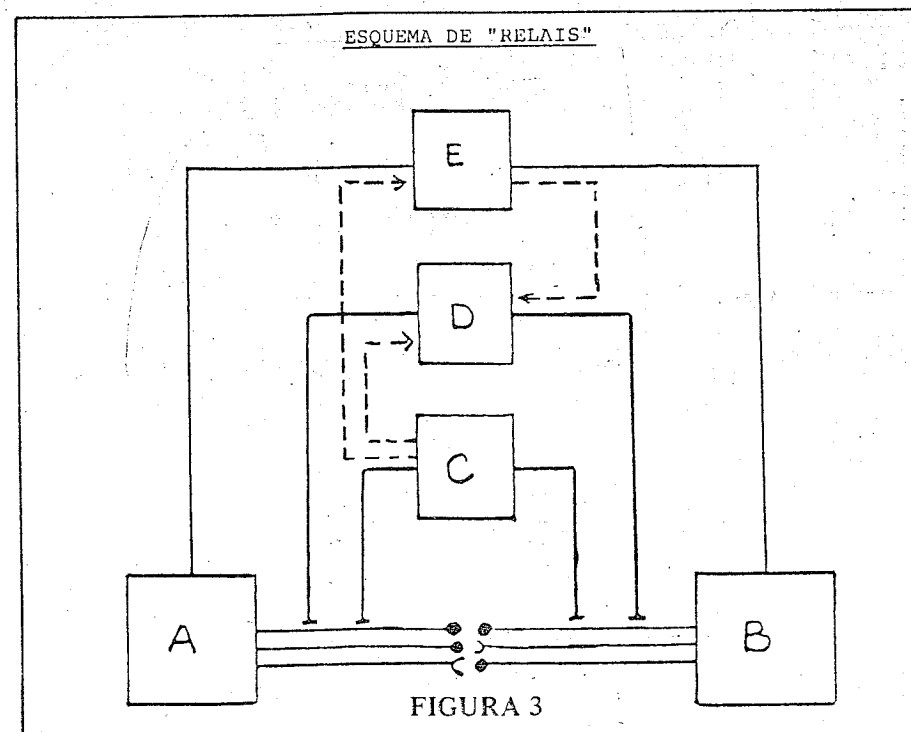


FIGURA 3

- * las salidas de evitamiento
- * las salidas resolutivas

1) Salidas de evitamiento

Se trata de intervenciones que pretenden evitar la emergencia del acto violento sin resolver por ella, la génesis del mismo.

2) Salidas resolutivas

Se trata de intervenciones que intentan cambiar las condiciones mismas de la génesis del acto violento.

El soporte técnico para abordar terapéuticamente la violencia escapa a las pretensiones de este trabajo.

Los autores son conscientes de los interrogantes que pueden suscitarse con respecto a los alcances terapéuticos del mismo, pero pretenden que es posible desarrollar un método para operar eficazmente con los sistemas familiares a transacción violenta.

La investigación centrada en este aspecto ya ha comenzado...

RESUMEN

Los autores proponen una hipótesis que es la base del desarrollo del trabajo de investigación:

"En las familias que se estructuran según un modo violento existe un modo circular específico".

Se trató de poner en evidencia las secuencias comunicacionales repetitivas y las retroacciones positivas que se suponen ligadas a la emergencia del acto violento en la familia.

Luego se propone definir *participantes* a aquellas personas que están presentes en el momento de la acción violenta, *actores designados emisores* a las que actúan la

ejecución del acto violento y *actores designados receptores* a las que actúan recibiendo el acto violento.

Se describen dos formas diferentes de violencia según el tipo de interacción:

- 1) La violencia agresión, característica de la relación simétrica.
- 2) La violencia castigo, característica de la relación complementaria.

Se describe luego la organización relacional de la violencia a través del consenso implícito rígido de los participantes así como los disparadores de la violencia.

El acto violento es definido como un "mensaje analógico de normalización del otro" luego de explicar el concepto de sistema de creencias y el de modelo del mundo.

Finalmente se introduce la noción de "relais" y de regulador como instancias que sirven la primera, a conservar la existencia del sistema y la segunda a regular el comportamiento haciéndolo más autónomo de los controles convencionales.

Finalmente se abren perspectivas terapéuticas no expuestas en el texto.

SUMMARY

The authors put forward a hypothesis which is the base of the development of the investigation work.

"In the families structured under a violent pattern there is a specific circular mood".

We have tried to make evident the repetitive communicative sequences and the positive retroactions that are supposed to be tied to the emergency of the violent act in the family.

Then it is suggested to define partici-

pants, those who are present in the moment of the violent action, and protagonists named receptors, those who receive the violent act.

Two different ways of violence are described according to the kind of interaction:

- 1) aggressive violence, characteristic of the symmetrical relationship.
- 2) penalty violence, characteristic of the complementary relationship.

Then the related organization of violence is described through the rigid implicit consensus both of the participants and of the triggers of violence.

After having explained the concept of the system of beliefs and of the world pattern the violent act...

The violent act is defined as an analogical message of the other's normality.

Finally, we introduce the notion of "relais" and of "regulator" as instances that serve the former to preserve the existence of the system and the latter to control behaviour making it more autonomous of the conventional controls.

In the end, therapeutic perspectives not shown in this text are open.

PALABRAS CLAVES

Violencia familiar
Participante
Actor designado
Violencia castigo
Violencia agresión
Consenso implícito rígido
Activación episódica
Sistema de creencias
Acto violento
"Relais"/Regulador

BIBLIOGRAFIA

- Von FÖRSTER, Heinz, "La construction d'une réalité" en *L'invention de la réalité*.
GIRARD, René, *La violence et le sacré*, Ed. Grasset, 1972.
MATURANA, Humberto, *Diálogos con el Dr. H. Maturana en Cuaderno de terapia familiar*, Ed. CETEFA, Rosario, 1984.
MORIN, Edgar, Von FÖRSTER, Heinz, MATURANA, Humberto, SLUZKI, Carlos, *2ème Colloque International IFATC, Les bio systèmes*, Saint-Etienne, 1984.
PERRONE, Reynaldo, *La famille carte et territoire*, Ed. IFATC, Saint-Etienne, 1982.
SEGOND, Pierre, "Justice Violence et Famille" en *Publications du 1er. Colloque IFATC*, 1983, Ed. IFATC, Saint-Etienne, 1988.
SLUZKI, Carlos, "Violence et famille" in *Publication du 1er. Colloque IFATC*, 1983, Ed. IFATC, Saint-Etienne, 1988.
SLUZKI, Carlos, BAVIN, Janet, "Simetría y complementariedad, una definición operacional y una tipología de diadas" en *Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina*, 1965, p. 321 a 330.
WATZLAWICK, Paul, *La réalité de la réalité*, Ed. du Seuil, París, 1978.
WATZLAWICK, Paul, *Une logique de la communication*, Ed. du Seuil, París, 1972.

Abuso sexual del niño en la familia: Un resumen-guía sobre el tema

Dr. EDUARDO J. PADILLA

Médico Psiquiatra.

Buenos Aires, agosto de 1988.

Uruguay 1280 - P.B. "A". (1016) Bs. As.

"Nadie se juntará carnalmente con consanguínea, ni descubrirá su desnudez. Yo soy el Señor".
(Levítico, 18, 6).

DEFINICION

Siguiendo la idea de R. Kempe,¹ podemos definir el abuso sexual como la participación de niños y adolescentes en actos sexuales que, por el grado de inmadurez natural en su desarrollo, no están en condiciones de comprender cabalmente ni dar consentimiento pleno, o que violan los tabús sociales de los roles familiares.

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA Y SU REPERCUSION PUBLICA

Estando en Francia y en Gran Bretaña puede palparse la enorme importancia que el conjunto de la sociedad le está dando al tema del abuso sexual de los niños. Esto forma parte del empeño en la lucha contra la violencia en general.

Los niños, por su natural dependencia de los adultos —y en especial, por supuesto, de los padres— son las víctimas más fáciles del ejercicio ilegítimo de la fuerza y los que menos posibilidades tienen de buscar ayuda y protección espontáneamente.

De esta violencia, la sexual es por desgracia tremendamente frecuente, como lo mostraremos más adelante cuando comentemos las estadísticas. Los efectos destructivos de estos actos pueden dañar definitivamente una vida que recién está en sus comienzos, o por lo menos, producir ciertos efectos perniciosos de muy larga duración.

Para dar una idea del interés general que se ha suscitado en varios países europeos y en los EE.UU. y la forma en que se debate el problema, podemos recordar un día en que la Radio Televisión Francesa (RTF) puso en el aire una película norteamericana que trata de un incesto entre un padre y su hija. En los anuncios previos al programa, se pedía a los padres que vieran la proyección acompañados por sus hijos, razón por la cual se elegía un horario en que las familias podían estar reunidas en pleno. Concluida la película hubo una discusión entre calificados psiquiatras, abogados, asistentes sociales, jueces, etc., y también de varias personas que en su infancia habían sido víctimas de tales abu-

sos, entre ellos, una escritora que viene de publicar un estremecedor libro con la historia de su propio calvario.

Similares programas pueden verse en Londres, donde existe además un programa de TV que tiene un llamado "child line", esto es, una línea telefónica por la que los niños pueden pedir ayuda. Los que están a cargo del programa pueden dar fe de los muchos desgarradores relatos que entre sollozos alcanzan a balbucear las víctimas en un SOS desesperado. También los diarios, algunos de tirada millonaria como "The Observer", publican avisos de media página ofreciendo ayuda y asesoramiento a las personas que sufren o han sufrido abuso sexual, al tiempo que guía para que los adultos sepan proteger a los niños de esa eventualidad. Demás está decir que en las escuelas todo esto es también ampliamente debatido con los maestros, quienes con la ayuda de video tapes de altísimo nivel, enseñan a los niños el derecho que tienen al respeto de sus cuerpos por el simple hecho de que les pertenecen.

ORGANIZACIONES PRO-INCESTO

Frente a esto existen grupos organizados que con el pretexto de garantizar, como parte de los derechos humanos del niño, el que tengan una libre vida sexual —terminando de una vez con el abusivo monopolio de los adultos— preconizan que sean precisamente los padres los que inicien sexualmente a sus hijos, así como lo hacen con beneficio en tantos otros aspectos de sus vidas. Esta confusión entre sexualidad infantil y adulta es a tal punto explotada que un grupo conocido como la René

Guyon Society, en los EE.UU., tiene como lema "sexo antes de los ocho que si no ya es tarde" ("sex before year eight or else it's too late"). Otro tanto sucede, por ejemplo, con la Sociedad de Intercambio de Información Pedofílica, en el Reino Unido.²

EN LA ARGENTINA

Todo este panorama contrasta con el que transcurre en nuestro país. Salvo cuando la opinión pública es sacudida por hechos criminales, tales como uno reciente en el Chaco en que un hombre mató a una niña de tres años de edad, luego de violarla —niña que resultó ser su nieta y su hija al mismo tiempo—, o el célebre de los hermanos que mantenían una vida sexual con la madre y que asesinaron luego a ambos padres, el hecho de la violencia sexual en la familia es casi ignorado pese a que es un difundido drama cotidiano.

Así es como muchos piensan, entre nosotros, que estos abusos sexuales son hechos raros y que esta preocupación puede ser excesiva y hasta sensacionalista. También hay reacciones que atribuyen todo esto al viejo interés "voyeurista" que se supone tenemos los psicoanalistas por todo lo que concierne al sexo, que sería una suerte de obsesión profesional patológica. También están los que dicen que al fin y al cabo es un fenómeno cultural de las "villas miseria" o de zonas rurales apartadas donde es un hecho considerado normal. Argumento éste que consiste de entrada en desconocer que esas familias son tan parte de nuestra comunidad como cualquier otra y que está visto, por otro lado, que esto sucede en todos los niveles sociales sin excepción, como bien lo han

demostrado los estudios realizados por Finkelhor (1979) y Giaretto (1981)³ en su país. Y no hay por qué pensar que es aquí de otro modo, sino más bien que las personas que llegan a los servicios públicos suelen ser los de menores recursos, quedando los demás al amparo de la consulta privada, si es que ésta sucede. Con respecto al encogerse de hombros aduciendo que es un hecho aceptado culturalmente en ciertos estratos, tiene la misma fuerza que negar que los sacrificios humanos que ciertos pueblos han realizado para complacer a sus dioses no eran hechos de terrible violencia (al menos para la víctima propiciatoria) por más incorporados que estuvieran en sus culturas. O, si se quiere otro ejemplo más cercano en el tiempo, el drama de la esclavitud, en su momento advertido generalmente por pocos.

En el país no existen aún estadísticas amplias sobre el abuso sexual infantil. Varias personas realizan una labor notable en este campo desde hace años en diversos hospitales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Recientemente se ha fundado la Sociedad Argentina para la Prevención del Abuso y Maltrato al Niño y al Adolescente. Una organización pionera como el Centro de Atención a Niños y Jóvenes Abusados (CANJA) que realiza una tarea ejemplar aunque poco conocida por el público, se ha ocupado ya de alrededor de doscientos casos provenientes de diferentes lugares, oscilando la edad de las víctimas entre uno de dos años hasta la de aquellos mayores que piden ayuda por su cuenta. (Si bien es cierto que se atienden algunas adolescentes, enviadas por los tribunales, que se niegan rotundamente a dejar la relación incestuosa, resulta difícil excluirlas de la categoría de víctimas porque sería ignorar la historia previa de la supuesta

primera aceptación, generalmente sucedida muchos años antes).

ESTADÍSTICAS

La falta de estadísticas locales suficientes nos lleva a tener que recurrir a las de otros países que sí las tienen y que nos pueden servir como puntos de referencia para posteriores estudios en nuestro medio.

En los EE.UU. la incidencia anual se calcula entre 60.000 y 100.000 casos. En el Reino Unido, el estudio llevado a cabo por Bentovim, Mrazek y Lynch⁵ que incluía en el término "niños" a los menores de quince años que habían tenido contacto sexual con adultos (excluyendo por lo tanto contactos entre adolescentes y hermanos, excepto si uno de ellos era un adulto), según los siguientes tres agrupamientos:

Tipo I:

Niños golpeados cuyas lesiones estaban predominantemente en el área genital,

Tipo II:

Niños que habían sufrido un intento o la consumación de coito u otro contacto genital con un adulto (por ej., masturbación recíproca),

Tipo III:

Niños que han sido involucrados en actividades sexuales de adultos.

Arrojó una incidencia de 6.000 casos por años, o sea que si se tiene en cuenta la duración de una niñez, significa un promedio de 3 niños por cada 1.000.

El tipo de abuso más frecuente es del tipo II, luego el I y finalmente el III, en el cual se incluyen a los niños obligados a presenciar actos sexuales de adultos o a participar en filmaciones pornográficas.

Sobre esto último digamos de paso que una firma dedicada en Buenos Aires al alquiler de videos pornográficos, cuya publicidad aparecía regularmente en un matutino de esta ciudad, reconoció que más del 30% de los títulos solicitados por sus clientes son aquellos en los que hay relaciones incestuosas. Y como bien se ha hecho notar,⁶ nada es pornográfico hasta que el observador le añada sus propias fantasías.

El 43% de los perpetradores eran miembros de la familia, el 31% conocidos de ellas, y sólo el 26% extraños.

Dentro de la familia el padre, con el 48% de los casos, es el perpetrador más frecuente. Le siguen el padrastro (28%) y la madre (5%).

Las niñas son las más frecuentemente abusadas, en una relación de 85% contra el 15% de varones.

En cuanto a las edades, la víctima menor registrada fue una beba de seis meses que había sufrido un intento de coito, y si bien el 60% tenían menos de 11 años, el 27% tenían entre 6 y 10, y el 13% menos de 6, lo cual es una elocuente respuesta para aquellos que argumentan una supuesta "culpa" de la víctima ("por algo le habrá pasado"), ya sea porque han sido "provocativas" y "seductoras" o si son varones, por tener seguramente alguna inclinación feminoide (recordemos un caso reciente y público y notorio en que una multitud se llegó a la casa de un joven que denunció haber sido violado para cantarle epítetos a su imputada tendencia homosexual: a veces parece más fácil identificarse con el victimario que con la víctima, sobre todo si éste es "popular").

Estos estudios son, en líneas generales, coincidentes con los obtenidos en los EE. UU.

FACTORES DE VULNERABILIDAD

Si bien es cierto que la pobreza, la promiscuidad habitacional y el aislamiento social tanto en áreas rurales como en las grandes ciudades son factores importantes a tener en cuenta, como ya se ha señalado, el abuso sexual del niño se da en todos los medios sociales y culturales.

El alcoholismo y el impresionante auge del uso de drogas son factores importantes a considerar, sobre todo por el efecto de borramiento de límites—entre ellos, el límite generacional—que suelen producir. Cabe también mencionar el número de divorcios con la consecuente formación de nuevas familias, compuestas entonces de manera que se tienen que establecer todo tipo de nuevas relaciones padre-madre - hijos - hijastros - medio hermanos - hermanastros, a veces de generaciones muy diversas.

Bentovim y Okell Jones⁷ señalan como factores sociológicos y psicopatológicos a normas y valores subculturales, pobreza, promiscuidad, desempleo (que lleva a veces a que la madre salga a trabajar mientras el padre queda en casa en su lugar), aislamiento social, alcoholismo y enfermedad o subnormalidad mental. También han observado una mayor incidencia en familias en crisis de disolución (la madre "permite" que las cosas sucedan con tal de que el marido no se vaya), o cuando la madre tiene una enfermedad que la incapacita y una hija queda ocupando su rol. En otras ocasiones, una hija discapacitada a la que hay que cuidar incluso en los aspectos íntimos, es la víctima de la situación de abuso.

Resulta tremendo comprobar también

que en algunas familias muy cerradas y endogámicas simplemente se repite con la siguiente generación el drama de violencia ya vivido con la anterior, ya sea porque los padres fueron a su vez abusados sexualmente, o porque tienen terribles historias de privación afectiva e incluso, de graves castigos en sus propias infancias. Cuando es así, el círculo se cierra implacable y hermetico.

En cuanto a la personalidad del perpetrador, suele parecer al principio alguien dominante y seguro, fachada tras la cual se oculta una persona emocionalmente inmadura, necesitada, débil, aunque muchas veces violenta. Otras veces es simplemente un hombre débil en busca de alguna ternura que no sabe o no puede encontrar, transponiendo los límites y envolviéndose sexualmente con sus hijos en una actividad compulsiva que lo somete como en una drogadicción. Al decir de A. Bentovim, "Prisioneros del Incesto", expresión que como se ve, se refiere a toda la familia.

Desde luego, mucho se puede decir de cómo influye la personalidad de la madre, incomunicada de sus hijos y de su marido, "dejando hacer" sin poder ejercer su papel maternal de cuidado. No suele ser raro que haya sido en su momento también una víctima de lo mismo.

DIAGNOSTICO Y DAÑOS DEL ABUSO SEXUAL

Los que provenimos de una formación psicoanalítica recordamos cómo Freud⁸ cambió su inicial punto de vista sobre la realidad de los relatos que muchos de sus pacientes le hacían sobre abusos sexuales que habían sufrido durante sus infancias

por parte de adultos, incluyendo a sus propios familiares. Llegó posteriormente—quizás presionado por el peso del contexto social de su tiempo en cuanto a temas sexuales se refería— a la conclusión de que dichas historias, por su gran frecuencia, debían ser el resultado de las fantasías y deseos edípicos de sus pacientes, ya que un número tan alto de descripciones similares no parecía poder corresponder a la realidad. Reconocer el valor del descubrimiento freudiano del "mundo interno" que nace a partir de esta rectificación en cuanto a la etiología de las neurosis, no nos debe llevar a desestimar que muchas de sus primeras observaciones debían haber sido también válidas, lo cual él mismo, por otro lado, no dejó de aceptar.

Por lo dicho, con más razón debemos estar atentos a la realidad de los hechos, tanto cuando trabajamos como psicoanalistas de adultos o de niños, o como terapeutas familiares, sobre todo cuando hay indicios como para presumir la posibilidad del abuso sexual. Para la víctima la primera revelación suele ser costosísima (también a veces para el perpetrador o para algún familiar), por lo que si estos sienten que no han sido escuchados y que no se hará algo concreto con el problema, no es raro que quizás no hablen ya otra vez.

Bentovim⁹ describe como señales de alerta signos físicos tales como heridas o hemorragias vaginales o rectales, flujo e infecciones genitales, anales u orales, apertura himenal mayor de 4 mm., y embarazo, sobre todo cuando el padre es sospechosamente desconocido. En cuanto a signos y síntomas psíquicos, los hay inespecíficos, como estado de post-shock, y otros más específicos como lo es la sexualización de la conducta, masturbación intensiva, juegos sexuales inapropiados con

otros niños o el abuso de ellos, comportamiento de "víctima" que lleva a veces a la repetición de nuevas situaciones de abuso, o más frecuentemente en los varones, la identificación con el agresor. No son infrecuentes los intentos de suicidio que parecen absolutamente inexplicables. Por supuesto que no es raro el uso de drogas, la prostitución, la automutilación, la fuga del hogar.

Y ya que mencionamos los elementos diagnósticos, notemos también los daños casi siempre de larga duración si no de por vida que produce el abuso sexual del niño.

Anna Freud que tanto hizo desde su Hampstead Clinic para ayudar a los niños víctimas de los bombardeos a Londres durante la Segunda Guerra, ha escrito:¹⁰ "En cuanto a las posibilidades de dañar el desarrollo normal de un niño, el incesto u otras formas de abuso sexual por las figuras parentales tiene mayor importancia que el abandono, el descuido, el maltrato físico o cualquier otra forma de abuso. Sería un error enorme subestimar las implicancias y la frecuencia con que realmente sucede".

El que esto escribe tuvo oportunidad de tratar en comunidad terapéutica dirigida por J. García Badaraco, tres familias en las que en su momento se había consumado algún abuso sexual. En una de ellas, la paciente designada era una esquizofrénica paranoide crónica que tuvo su primer brote el día antes de su boda, a los dieciocho años de edad. Cuando se recuperó de él se dedicó a la prostitución a cambio solamente de aceptar de sus ocasionales compañías, pequeños regalos, como los que le daba su padre en la infancia para comprar su silencio. Finalmente se casó con uno de sus clientes que tenía

una enfermedad dermatológica que lo hacía físicamente muy repulsivo. Nunca pudo tener una vida sexual —ni tan sólo una vida— satisfactoria. La revelación de su relación incestuosa con su padre la hizo en el transcurso de una reunión de grupo terapéutico multifamiliar, y por supuesto, con la sola excepción de unos pocos lúcidos, se tomó esto como una más de sus locuras. Al frente de los descalificadores se encontraba, militante, la propia familia. El padre ya había muerto: ¿cómo hablar así de su memoria! La madre explicaba que en la época en que se imputaban los hechos, se encontraba postrada por una larga enfermedad ósea, y que su hija era la que hacía de ama de casa. Quizás, por esto, se había confundido en descabelladas fantasías con su padre. Algún terapeuta intervino para interpretar las cosas a la luz del complejo de Edipo. Fue difícil llegar, en la terapia familiar, al punto en que se admitió como cierto el relato de lo sucedido, ya cuando la descripción minuciosa de los hechos no podía ser sino desgarradora e inequívocamente veraz. Ahí, alguien dijo que en el fondo todos sabían que "algo raro" pasaba en la casa.

Por supuesto que casi todas las observaciones de personas adultas que tuvieron experiencia de abuso sexual en sus infancias, provienen de personas perturbadas, o sea de aquellas que acuden o son llevadas a consulta. Por ello se puede alegar que existiría un grupo que no sufre perturbación alguna como consecuencia de lo sucedido, argumento que es usado por los partidarios del incesto, "liberador" de viejos tabúes.

Sin embargo, la experiencia clínica recopilada por Bentovim⁷ muestra que los efectos a largo plazo del abuso son dañinos para la autoestima, la habilidad para

relacionarse, sobre todo sexualmente, y para un buen ajuste en la vida emocional. Desde luego que la extensión del daño tendrá que ver con las posteriores experiencias del individuo, inclusive si ha tenido o no algún tipo de ayuda terapéutica. Por desgracia, esta ayuda suele ser todavía muy infrecuente pese a lo inmensamente necesaria que es.

VALOR DE LA TERAPIA FAMILIAR EN ESTOS CASOS

El cuadro que presentamos es el de una cruda y violenta realidad que no puede sino impresionar a los que trabajamos en salud mental, o a los que desde las áreas de la justicia y la educación tienen también una vocación de servicio a su comunidad. Una actitud primariamente punitiva y retaliatoria no ha demostrado por cierto ser de ninguna utilidad. El perpetrador es enviado a la cárcel donde por una ley no escrita es a su vez violado, (el "violeta", en la jerga carcelaria), continuándose así la cadena de la violencia. La familia queda en el desamparo y la víctima suele ser convertida en el chivo emisario de toda la situación, si es que ya no lo era desde antes. Así pues, el interés del niño, que es lo principal a ser tenido en cuenta, es postergado u olvidado por completo. No es raro que el resultado final sea de esta forma, sólo un nuevo dolor.

Tilman Furniss, que colabora con Bentovim en el Great Ormond Street Hospital for Sick Children de Londres, ha observado luego de trabajar durante años en este tema, que el abuso sexual es mucho más frecuente que lo admitido, que suele continuar por varios años, y que es un problema que emerge en el contexto familiar.¹¹

O sea, que nos encontramos con una familia disfuncional que debe ser atendida. Este tener que atender una familia con esta problemática despierta muchos dilemas morales a más de un terapeuta: por ej., ¿qué derecho tengo de introducirme en la situación, con todas las consecuencias, incluso las legales, si al fin y al cabo han conseguido crear un sistema lo suficientemente estable como para que ya tenga un largo tiempo de duración? (Existen también implicancias de tipo legal, ya que en la Argentina, al contrario por ejemplo de lo que sucede en otros países como el Reino Unido, es obligatorio denunciar un delito). Y como bien lo señala también Furniss, cuando el equipo profesional interviene en una familia incestuosa, la familia deja de ser autónoma y se crea un nuevo sistema, profesional-familia. Y como el equipo debe incluir a varias personas, el nuevo sistema resulta en una nueva interacción emocional y social entre la familia y los profesionales y de estos entre sí, lo cual configura una situación compleja y con problemas difíciles a tener en cuenta y resolver, para todo lo cual se requiere una gran habilidad que se obtiene sólo luego de un buen entrenamiento. El que asume esta tarea debe estar atento al peligro de identificarse demasiado con el niño o con la madre —a veces con el perpetrador porque también inspira compasión—, y dejar de funcionar con una mente abierta y sin ánimos de retaliación o venganza. Algunos de estos peligros son más fáciles de sortear si se trabaja coterapéuticamente hombre-mujer.

La experiencia ha mostrado el valor inigualable de la terapia familiar en estos casos. Cuando decimos terapia familiar no significamos que las reuniones deben ser hechas siempre en conjunto, entre otras

cosas porque esto sencillamente no siempre es posible. El padre puede estar en la cárcel y el hijo enviado a vivir a otro lugar. O como tristemente observamos muchas veces aquí, la realidad es que el costo de los pasajes urbanos para el traslado de todo un grupo al hospital supera las posibilidades de su magra economía. Lo importante es que la perspectiva sea una perspectiva familiar. Luego se puede trabajar con terapia individual, con las diadas, con el grupo de hijos, con grupos de niños abusados o de madres en igual situación. Es también fundamental que si bien el material que un familiar pide que sea mantenido confidencial para otros miembros de la familia sea respetado, no sea por ello excluido del conocimiento del resto del equipo para su integración en una colaboración muy íntima entre todos.

Siempre siguiendo a Furniss, éste recomienda sin embargo que por lo menos se deben efectuar una o dos reuniones conjuntas para dejar claros los cinco objetivos principales siguientes:

1. Establecer los hechos realmente sucedidos, teniendo en cuenta que el tabú del incesto ha sido reemplazado por el tabú de hablar del incesto, situación que se debe intentar revertir. Ningún hecho debe darse como descontado como conocido. Deben explicitarse todas las circunstancias del abuso, dónde estaba cada uno cuando éste sucedía, etc., tarea que debe llevarse a cabo en el clima emocional más neutro posible.
2. Ayudar al padre a hacerse plenamente responsable, relevando así al niño de la culpa que generalmente los demás o él mismo se endilga.
3. Ayudar a ambos padres a reconocer

el grado en que están involucrados como pareja responsable del cuidado de los hijos.

4. Hablar sobre cualquier circunstancia de separación en la familia como consecuencia de lo acontecido (incluso de que el niño sea enviado a otro hogar), de tal modo que quede bien claro que no se trata de actos de castigo al niño.
5. Alcanzar un contrato terapéutico que incluya también la organización de visitas y contactos entre los distintos miembros de la familia.

Bentovim quien tiene una formación psicoanalítica y que se ha especializado en terapias familiares focales a partir de los modelos psicoanalíticamente orientados de Balint y Malan en la Tavistock Clinic, para llegar hoy a un pragmático acercamiento a las aportaciones sistémicas, sostiene que la violencia no pertenece al individuo, ni a la familia ni a la sociedad, sino al conjunto de los tres, por lo que se debe pensar en cómo actúan entre sí estos sistemas. Como terapeutas familiares, elegimos como nuestro primer y difícil lugar de acción, la familia. Y en este campo, dice Bentovim,^{1,2} desde el punto de vista pronóstico nos podemos encontrar con aquellas que dan lugar a esperanzas de que el trabajo de rehabilitación pueda tener éxito, las dudosas, y aquellas para las que no parece haber esperanza alguna. Estas consideraciones se basan en si se puede ver que los adultos de la familia se hacen responsables por la falla en el cuidado del niño: si esto es visto como parte de una falla en el sistema marital y no se llega a la situación cristalizada de un padre acusando al otro; si se reconoce que las necesidades de los niños son las principa-

les a atender; si no se designa al abusado como "chivo expiatorio"; si se percibe que los vínculos familiares están realmente vivos; y si se puede observar que los cambios en la interacción familiar con el medio más amplio son posibles.

Esta evaluación es conveniente antes de entrar de lleno en lo que será un arduo trabajo, entre otras cosas, por los disturbios que pueden producirse en el seno del mismo equipo terapéutico, cuando sus componentes van teniendo que pasar por los conflictos, alianzas, secretos y violencia del grupo que están tratando. Pero sabemos que estamos cumpliendo con la obligación ética de proteger al que está en peligro, sea cual sea el resultado final del esfuerzo.

ALGUNAS IDEAS PARA ORGANIZARNOS MEJOR

Henry Kempe, uno de los pioneros en este campo, describió ya en 1979, los estadíos por los que va pasando una sociedad en cuanto al reconocimiento del abuso de los niños, los cuales ordenó así:

- I. Negación de que el abuso físico o sexual exista en grado significativo. Los casos se deberían a padres psicóticos, borrachos o drogados, o en todo caso, a visitantes que nada tienen que ver con la comunidad como tal.
- II. La comunidad presta atención a los niños severamente golpeados.
- III. La comunidad maneja mejor los casos de abuso físico y se preocupa de los niños que son descuidados físicamente.
- VI. La comunidad reconoce el abuso

emocional y las situaciones de rechazo severo, las de "chivo emisario" y los de privación emocional.

- V. La comunidad presta atención al calvario de los niños abusados sexualmente.
- VI. La comunidad garantiza que cada niño sea realmente querido y provisto de cuidado afectivo, vivienda adecuada, alimento y, prevención y cuidado de primera clase de su salud.

Reflexionamos de acuerdo a esto sobre en qué sentido podemos colocarnos como comunidad y cuánto nos queda por hacer. El autor del presente, actuando como supervisor en el Hospital Infante Juvenil Tobar García y con integrantes del equipo de psiquiatría del hospital de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, ha podido comprobar que no es por falta de buena voluntad y empeño que las situaciones de familias con abuso suelen ser pasadas rápidamente de mano en mano como una papa caliente, sino por falta de una organización social amplia que pueda contener eficazmente la situación sin agregar otro daño más a un grupo ya terriblemente golpeado. Al mismo tiempo, esta impotencia lleva a disimular lo que todos sabemos: que los hechos son muy frecuentes.

El trabajo efectuado por Bentovim puede servirnos de inspiración. En 1981 propuso a la Fundación CIBA que el tema de investigación que ésta realiza cada dos años, fuera esta vez sobre el abuso sexual de los niños. Aceptado esto se organizó un grupo de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, pediatras y miembros de la policía y del cuerpo forense y judicial, los cuales luego de un intenso trabajo produjeron un informe que ha orientado toda la acción sobre el problema en el Rei-

no Unido, y que es de lectura obligatoria para todos los interesados en la cuestión.¹³ Es un eficaz programa de ayuda para todos los que puedan estar involucrados —a veces empezando por el sencillo policia que está a cargo de la comisaría adonde llega el primer pedido de auxilio—, y es también una guía para tener claro cómo se debe reaccionar en una situación donde el impacto emocional suele, ya sea paralizar o llevar a actuar precipitada y equivocadamente. Por otro lado, cabe hacer notar que Bentovim y su grupo realizan una ciclópica tarea en los tribunales, para lograr que la imponente justicia inglesa acepte algunos cambios que permitan a los niños estar solos frente a los jueces con sus majestuosas pelucas rituales, sometidos al mismo tiempo al fuego graneado de los abogados de la parte acusada, y para colmo, teniendo que acusar a un mismo miembro de su familia, muchas veces también querido. Se ha propuesto que se acepte como prueba la utilización de otros recursos que la mera palabra, como ser la filmación de las sesiones terapéuticas donde el niño puede mostrar con muñecos anatómicamente correctos lo que realmente ha estado sucediendo en la intimidad de su hogar. (Las retracciones de la víctima en momentos culminantes del proceso son muy frecuentes. La experiencia muestra que cuando suceden así son una prueba más del abuso, ahora negado por un miedo pánico).

En otro orden de cosas resulta imprescindible una mayor difusión pública del problema. Esta debiera tener en cuenta especialmente a todos los que trabajan en el área de la educación y la justicia y, en cuanto al área de la salud, sobre todo a los pediatras y ginecólogos. Los medios llamados de difusión masiva, pueden ser

de gran utilidad si se mantiene el tema de una tónica muy sincera y franca a la vez que no sensacionalista. Lo importante es estar preparados para ver, lo cual generalmente es más posible cuando se ha enseñado a saber mirar en la dirección apropiada y con la discreción y el tacto que requiere un tema que puede fácilmente caer en la actitud del "cazador de brujas", o por lo contrario, en una fuerte reacción de rechazo a su sola mención.

En cuanto a los terapeutas, y sobre todo a los de familia, es imprescindible facilitarles una formación especial para un trabajo como éste. Al mismo tiempo, se debe hacer conocer al público en qué lugares pueden ser encontrados para dar su ayuda.

UNA TAREA NADA FACIL: EL CASO "CLEVELAND"

Para concluir mostrando hasta qué punto se trata de una tarea difícil en la que poco se puede hacer sin la colaboración de toda la comunidad, pasaremos a relatar lo sucedido hace pocos meses en Cleveland, un pueblo en Inglaterra.

Las dos nuevas pediatras del hospital local creyeron encontrar en sus exámenes de rutina diarios, suficientes indicios para asegurar que existía la posibilidad de que 168 de los niños revisados habían podido ser víctimas de abusos sexuales, específicamente de violación anal. Este criterio fue seguido bajo la principal influencia del uso de un test que consiste en aplicar un dedo sobre la región anal: si al ejercer presión se produce un espasmo y el esfínter se abre —se sostenía— el niño había sido violado. Sin duda las pediatras se entusiasmaron excesivamente con un méto-

do que parecía garantizar en forma harto simple, un diagnóstico objetivo e indubitable de abuso sexual. Con esto se evitaba el peligro de equivocarse y, por un lado, someter por error a una familia entera a las complicaciones derivadas de un diagnóstico tal, y por otro, no dejar pasar por alto un niño en estado de desesperante necesidad de ayuda. Esta ilusión llevó a la sobreestimación del valor de una prueba —la ilusión del signo "patognomónico" de la medicina clásica— llevando a las médicas un paso más allá del sentido común. Y esto invitó a la reacción más enconada, extremista y totalmente fuera del más mínimo sentido común: la policía se retiró de la investigación y el pueblo entero tomó el lugar de los ultrajados en su dignidad de familias honestas y pasaron a acusar a las pediatras de efectuar revisiones indecentes a sus niños. Los ecos del escándalo continúan hasta hoy y se formaron dos bandos de opinión pública opuestos en todo el Reino. Las médicas fueron trasladadas a otro pueblo.

La tarea —está visto— requiere además de valor, equilibrio. Es un tema delicado porque está en juego el cuidado del niño por sobre todo, pero, al mismo tiempo y por la misma razón, el evitar innecesarios y graves riesgos para la familia y la sociedad en que éste vive.

Una vocación de amor, y por él, de re-

NOTA: Se ha preferido utilizar la expresión "abuso sexual en la familia" más que el de incesto, ya que éste último tiene, tanto en la Argentina como en Gran Bretaña, un uso en lo legal que limita su aplicación a sólo los casos en que se ha realizado un coito vaginal entre familiares y sus descendientes directos. Los demás actos sexuales son considerados "abusos deshonestos", agravados por el vínculo.

chazo a la violencia en sus diversas manifestaciones, resultará imprescindible para embarcarse discretamente en el lugar que a esta tarea le corresponde, tan lejos de toda cobardía como de cualquier fantasía de heroísmo mesiánico.

ADDENDA

Luego de escrito el presente trabajo tuvimos oportunidad de recibir la visita en Buenos Aires, del Dr. Arnon Bentovim y de la Trabajadora Social Psiquiátrica Marianne Tranter, ambos del Great Ormond Street Hospital de Londres, y de la Dra. Danya Glazer, del Guy's Hospital, también de Londres.

Los primeros, con más de mil casos atendidos, hicieron notar que continúa en aumento el número de varones abusados. El porcentaje actual ha pasado del 15% consignado aquí en páginas anteriores, al 25%, con un significativo avance también del porcentaje de niños abusados de más temprana edad. En el caso de las observaciones de Glazer, sobre cuatrocientos casos atendidos, se eleva el porcentaje de varones a casi un 40%, coincidiendo en el incremento del porcentaje hacia la zona de menor edad.

Los tres expertos refirieron el buen resultado que se obtiene a través del trabajo terapéutico, incluyendo la terapia familiar en compañía de las otras. Consideran que el abusador actúa menos bajo un impulso como de una compulsión, a la manera de un drogadicto, lo cual explica que los abusos duren casi siempre por largo tiempo. Esto da cuenta también de la pregunta sobre si la víctima y el victimario sienten placer en lo que sucede.

La tendencia a que las víctimas sean cada vez menores y que la discriminación entre niños y niñas abusados vaya disminuyendo, parecen sugerir una sociedad en que la perversión conocida como pedofilia va en constante aumento.

RESUMEN

En este trabajo se ha reunido material sobre el abuso sexual del niño, especialmente a través de la experiencia en el Reino Unido. Está visto que el primer problema con que se debe enfrentar una sociedad a este respecto, es que se reconozca que el problema existe. La tendencia general es a considerar que es algo que sucede en otros lados o sólo en determinados grupos sociales marginales: esto es sólo una actitud escapista frente a situaciones que por su naturaleza son muy movilizantes. Por otro lado, la formación psicoanalítica de un terapeuta le puede llevar a interpretar ciertas manifestaciones del niño como producto de sus fantasías edípicas, perdiéndose una quizás única posibilidad de ayuda. La terapia familiar junto con las terapias individuales, diádicas o de grupos demuestra ser de gran ayuda. Una actitud primariamente punitiva, en cambio, no lo es. Para esto se debe formar terapeutas especializados, lograr el apoyo de la comunidad a través de la comunicación sin sensacionalismo, y preparar a maestros, abogados, pediatras, ginecólogos, policías, jueces y gente de iglesia, entre otros, para estar atentos a la posibilidad de que se esté frente a un caso de abuso y para que si así fuere, saber como actuar teniendo en cuenta que el interés del niño es supremo. El reinstaurar el tabú del incesto que ha sido reemplazado por el tabú de hablar sobre

lo que sucede no es tarea sencilla. El que llega a conocer la existencia de una situación tal, debe pensar antes que actuar y luego comunicarse con quien se irá integrando el equipo de ayuda. Jamás se debe actuar solo ni quedar como depositario único de un secreto que en la gran mayoría de los casos produce daños permanentes sumamente serios. Una vez que el abuso sexual puede ser hablado abiertamente en una reunión familiar, el primer paso hacia la recuperación habrá sido positivamente dado y en el pronóstico cabe una esperanza.

SUMMARY

Information and discussion on the subject of child sexual abuse has here been resumed, taking special account the experience gathered in the U.K. It's quite clear that the first of all problems is to get a society to accept the fact that child abuse exists and is not something that happens elsewhere or only in certain social groups, as this denial is only an intent to avoid coping with a subject that is deeply mobilizing and distressing. Besides, the classical psychoanalytical training might lead a therapist to consider patients disclosures as the product of their oedipal fantasies, thus missing what could mean a unique possibility for help. Family therapy, together with individual, diadic and group therapy prove to be of great use. A primarily punitive attitude, on the contrary, shows to be rather damaging than of any help at all. Family therapists must undergo a special training for this job. Full support from the community is indispensable. Educational programs for teachers, policemen, pediatricians, gynecologists, judges, cler-

gymen, etc. can help them to keep in mind the possibility of sexual abuse and how to act without forgetting that the child's interest is paramount. Reinstating the taboo of incest that has been replaced by the taboo of talking of what's going on is a difficult task. First one must be able to think before acting. Then go on to ask for the proper help from the rest of the team. Keeping the situation secret has shown to be of long lasting damage. Once the situation has been put into the open during family meetings, the first step towards recovery has been positively taken and the outcome might then be hopeful.

REFERENCIAS

1. KEMPE R.S. y KEMPE C.H., 1978, *Child Abuse*, Fontana, Open Books.
2. TAYLOR B., 1981, *Perspectives on Paedophilia*, Batford, London.
3. FINKELHOR D., 1979, *Sexually Victimized Children*, The Free Press, New York.
4. CIARETTO H., 1981, *A Comprehensive Child Sexual Abuse Treatment Program. Sexually Abused Children and their Families*, Oxford, Pergamon Press.
5. MRAZEK P.B., BENTOVIM A., LYNCH M., 1981, *Recognition of Sexual Abuse in the United Kingdom. Sexually Abused Children and their Families*, Oxford, Pergamon Press.
6. STOLLER R., 1975, *Perversion, The Erotic Form of Hatred*, London, Karnac Books.
7. BENTOVIM A. y OKELL JONES C., 1987, *Sexual Abuse of Children: Fleeting Drama of Lasting Disaster?*, Year Book of IACP.
8. FREUD S., (1892-99), *Las primeras aportaciones a la Teoría de las Neurosis*, Edit. Biblioteca Nueva, Madrid.
9. BENTOVIM A., 1988, *The Diagnosis of Sexual Abuse*, Bulletin of the Royal College of Psychiatrists.
10. FREUD Anna, 1981, *A Psychoanalyst's View of Sexual Abuse by Parents*, in *Sexually Abused Children and their Families*, Beezley-Mrazek and Kempe-Oxford, Pergamon Press.
11. FURNIS T., 1984, *Organizing a Therapeutic Approach to Intra-familial Child Sexual*

- Abuse*, Journal of Adolescence, 1984.
12. BENTOVIM A., 1987, *Physical and Sexual Abuse of Children - The Role of the Family Therapist*, The Association of Family Therapy.
 13. *Child Sexual Abuse within the Family*, 1984, CIBA Foundation - Edited by Ruth Porter, Tavistock Publications, London.

Tratamiento con padres maltratantes

**Dra. DIANA BECHER
DE GOLDBERG**

Psiquiatra Infantil. Psicoanalista.
Coordinadora del Centro de Violencia Familiar
del Hospital de Niños "Pedro de Elizalde".
Charcas 3028, P.B. "E". (1425) Buenos Aires.

Trabajo presentado en el Congreso
Internacional sobre Niños y Adolescentes
maltratados realizado en Río de Janeiro el mes
de septiembre de 1988.

En 1977/8 en nuestro país surgió la preocupación por un tipo de problema para el cual yo era particularmente sensible por mis tareas como Jefe de Psicopatología en el Hospital de Niños, al cual llegaban a menudo situaciones como las de los chicos maltratados. Mi interés se centró en el estudio de las familias de estos niños, convirtiéndome en la primer psicoanalista que se ocupó de estos temas en mi país.

Como se trata de una problemática con implicancias morales y punitivo-delicuenciales, me encontré con todas las dificultades que tienen los pioneros. Mis investigaciones tomaron progresiva repercusión, hasta alcanzar un nivel de importancia como el que actualmente tiene, ya que hoy existe un área en particular dedicada al tema.

Todos los profesionales aquí reunidos, sabemos que se trata de un síndrome que,

aunque muy antiguo, es rescatado de la historia cada vez que nos consulta una familia maltratadora.

Pero, también sabemos que hay más conciencia de detección de estos casos y más posibilidades de controlar el daño.

Respecto a la cuantificación, en nuestra realidad, todo está por hacerse, sin embargo, la comprobación fáctica de las personas que trabajan en el tema, su repercusión sobre la opinión pública, la comprobación que el ser humano puede convertirse en agresor de sí mismo y de sus hijos, llevó a las autoridades sanitarias a decidir la inclusión de un Programa de Prevención Primaria del Maltrato Infantil, elaborado por mí en los planes de Salud Mental de la Municipalidad.

El Primer Seminario Interdisciplinario sobre el tema, fue realizado en el año 1982, organizado en el Hospital de Niños, por el Servicio de Psicopatología, una de cuyas conclusiones fue la necesidad de crear un Centro Piloto de Violencia Familiar.

Este Centro es que el actualmente dirijo. Funciona en el C.S.M. Nro. 3 y en el Hospital de Niños P. Elizalde, donde se lleva a cabo el proyecto mencionado.

La tarea de nuestro Centro está centrada fundamentalmente en la familia como institución natural de la sociedad, donde se produce la humanización del niño.

A partir de allí, la presentación en seminarios, jornadas, congresos, artículos periodísticos y medios masivos de comunicación, permitió la amplia difusión del tema.

Me referiré ahora al perfil psicológico de los padres abusadores.

Comúnmente la edad de los causantes es inferior a 30 años y conviven en el mismo hogar pero, en medio de una manifies-

ta discordia psico-emocional.

La mayoría de estos padres fueron criados del mismo modo, estuvieran o no sometidos a castigos físicos en su niñez, han sido agobiados por la desaprobación de sus propios padres.

Es habitual que desconozcan las características básicas del desarrollo del niño y tengan un equivoco concepto del significado del castigo corporal. Carecen de la capacidad de controlar la conducta de sus hijos de un modo no violento y no tienen la capacidad para interactuar positiva y atentamente con un niño en situaciones cotidianas.

La psicodinámica del cuadro está basada en una especial disposición psicológica del progenitor, quien crea una pauta de interacción en la que los malos tratos tienden a producirse. No existe una categoría común de diagnóstico psiquiátrico para clasificar a los padres apaleadores.

Son raras las sociopatías genuinas y a veces se observan estados psicóticos, esquizofrénicos o depresivos. Más comunes son las psico-neurosis y las perturbaciones del carácter. Las variables de personalidad que con mayor frecuencia se atribuyen a padres abusivos, incluyen un pobre control de los impulsos, baja tolerancia a la frustración y dificultades para expresar adecuadamente la ira; pobre autoestima, sentimiento de insuficiencia, inmadurez emocional y un estilo de personalidad rígida e inflexible.

Hay poca evidencia empírica que apoye la existencia de un tipo claro de personalidad abusiva y como consecuencia, no parece posible predecir si un individuo es un abusador basándose solamente en las características de su personalidad.

En la actitud del abusador hacia los bebés, es básica la convicción en parte in-

consciente, de que los hijos existen para satisfacer las necesidades de los padres. Los niños pequeños que no lo hagan, deben ser castigados físicamente. La exigencia es desmentida en relación con la edad del niño; por supuesto se desconoce su desamparo, sus necesidades, sus deseos y su capacidad evolutiva para responder en la forma esperada por el progenitor. Es el fenómeno de "inversión de roles". El padre incapaz de sentir confianza, vive aislado y mira hacia el niño en una última y desesperada tentativa de recibir ayuda.

Es así como se produce la inversión de roles y cuando esta inversión se quiebra, porque el niño llora, el padre frustrado descarga su agresión en él.

Es probable que todos los progenitores tengan la necesidad de que el bebé les responda compensatoriamente. La psicoanalista Therese Benedek ha descrito la interacción de recompensa recíproca entre madre e hijo en que cada uno satisface de manera adecuada las necesidades y expectativas del otro.

Inmaduros y dependientes, anhelan ser amados y comprendidos. Los acosa un profundo sentimiento de inferioridad y una incapacidad de confiar en que alguien los pueda amar, comprender y asistir realmente. Su honda convicción de ser desvalidos se oculta tras la proclamada virtud de sus ideas y sus afirmaciones del derecho a vivir sin que nadie se inmiscuya en sus vidas.

Como todos los niños, buscaban en la madre comprensión y cariño. Nada de eso hallan, por lo cual caen en el desengaño, la desilusión y la disminución de la autoestima; de ahí su ira, que no puede expresarse directamente hacia los padres sin sentir la amenaza hasta un grado insostenible.

Existe una falta de percepción real del niño por parte de sus padres. Se lo aprecia como "malo". El padre apaleador considera a su hijo como una re-edición del "sí mismo malo" de su propia infancia.

Esta misma transferencia colorea los demás vínculos del progenitor. Cuando necesita ser consolado, recurre a su identificación con sus propios padres y espera que un niño lo asista.

Los tempranos datos históricos de nuestros pacientes, indican que se vieron privados del sentimiento de *mothering* (cualidad materna). Los aspectos más mecánicos del cuidado son bien desempeñados, pero, hay déficit en la interacción afectiva con el bebé y en la empática percepción de sus sentimientos y aptitudes.

Contrariamente a lo que se pudiera esperar, el niño maltratado desarrolla una intensa unión con sus padres y ellos hacia él. Esto confunde el diagnóstico, ya que el interés demostrado por estos padres hacia el niño parece negar el maltrato. La cualidad de esta unión complica el tratamiento, porque el padre apaleador se opone intensamente a que le quiten la custodia de su hijo; quiere que se lo curen; y en su casa se repite el apaleo.

Estas fluctuaciones son índice de su ambivalencia y su incapacidad de contener las emociones por las cuales son manejados. La ausencia del niño hace que lo quieran, pero su presencia es más de lo que pueden tolerar.

Hay un núcleo psicopatológico esencial en el acto de la violencia física que distingue a este síndrome. Consiste en la capacidad parental de proyectar percepciones distorsionadas sobre sus hijos y responder impulsivamente de acuerdo con sus propias percepciones ilusas o erróneas.

La falta de seguridad que muestran es-

tos padres, hace suponer que no desean auxilio o son inasequibles a toda intervención terapéutica. Lo cierto es que exigen un cabal conocimiento de la dinámica psicológica por parte de profesionales de mucha experiencia.

Además de este vínculo deficitario con la madre, es importante resaltar un déficit en el vínculo con el padre, que no permite al niño construir una estructura super-yoica protectora por un lado y dadora de normas comunes por otro. El yo infantil se apegaba a la ilusión de un padre que habría de resolver aquellos problemas que el niño no puede enfrentar. La decepción de esta ilusión culmina en un afán de venganza que se expresa en un estallido de furia cada vez que la realidad plantea un problema. Esta conducta, característica del padre apaleador, depende de un doble déficit: déficit de la función nutricia y déficit de la función educadora ligada a la autoridad, funciones relativamente independientes del sexo de los progenitores.

En los tratamientos familiares observamos que las principales características de las relaciones de sus integrantes entre sí y con el medio son:

1. Existe un vínculo desafiante contra las normas. Poseen otro código basado en el afán de venganza de alguno de sus miembros, que hace de líder y no es rectificado por los otros, que sustituyen la crítica por una identificación cómplice. Este vínculo es expresión de una relación de decepción con respecto a sus propios progenitores, a quienes reprochan no haber sido escuchados como niños y tratados injustamente. Es un desafío desde la pasividad.

Este sentimiento se contrapone a toda posible admisión de una legalidad que los

hermane. Ellos hacen justicia por su propia mano, transforman lo pasivo en activo, por sentirse humillados y avergonzados. El temor al escándalo no los frena y sus asuntos toman estado público. Es como dijieran: "Después de esto van a decir que soy una 'hija de mala madre' y van a tener razón porque insulto a mis padres y mi apellido".

Una conquista espiritual de la humanidad es privilegiar el pensar por sobre el percibir. Se percibe que el bebé nace de la madre pero, la participación del padre se infiere. Como forma de ostentar esa conquista del pensar, cada cual se da a sí mismo el apellido del padre, que pasa a ser un símbolo del pensar. El apellido del padre es una posición intrapsíquica excéntrica al yo. Y desde allí llegan respuestas. Estos pacientes se oponen al pensar. En el momento en que debe aparecer el pensamiento ligado a la palabra paterna, es reemplazado por la acción.

Este reemplazo es producto de un cambio en la defensa, de la pasividad a la actividad y de un modo de funcionamiento social: el hijo como posesión.

2. El padre (en esta pareja) tiende a sustituir un pensar insostenible (que implica realizar un duelo con respecto a su propio padre) por actos violentos; ataca en el hijo las evidencias que éste le da de su imposibilidad de ser padre. Exige que su hijo mediante la obediencia sostenga su imagen paterna que sabe que no tiene. Conjeturamos que ataca en sí mismo el juicio de que su padre lo desampara.

3. La madre se identifica con la violencia paterna, en lugar de rectificarla. Fue criada en un vínculo de desamparo y da por supuesto que la realidad le debe algo, que obtiene reivindicatoriamente a través

del padre. De este modo soborna y corrompe su propio juicio crítico acerca del modo de ejercer la paternidad y la maternidad. Satisface así sus celos y su envidia y su sentimiento de culpa.

Un miembro de la pareja es el portavoz activo, el otro induce desde la pasividad.

4. El hijo maltratado, si bien por momentos se rebela por la violencia sufrida, en otros momentos permite ser objeto del sadismo, en parte por identificación con su agresor, en parte por culpa de desear la muerte de su madre o padre, ya que ellos lo abandonan.

TECNICAS DE ABORDAJE EN EL CENTRO DE VIOLENCIA FAMILIAR

El niño agredido es traído por sus propios padres. Otros casos, generalmente menos graves, llegan a los consultorios externos. Otros, es necesario ir a buscarlos con el auxilio de la autoridad pública. En estos casos no contamos con un encuadre jurídico ni grupos de rescate y por lo tanto probamos técnicas no tradicionales para poder llegar a estas familias. Otros niños provienen de hospitales, de escuelas, de la denuncia de vecinos o directamente enviados por el juez.

Si el niño es menor de 3 años, se lo trata de internar en un Hospital de Niños cualquiera que sea la gravedad del traumatismo.

La evaluación diagnóstica se basa en una historia clínica tipo: examen físico, fotografía de las lesiones, exámenes de laboratorio y radiografías características. Se realizan entrevistas psiquiátricas en las

que se estudia el potencial de maltrato de los padres. El diagnóstico psicológico del niño con la técnica de la hora de juego. Se estudia la crisis familiar y el nivel social. Después se efectúa una reunión de los profesionales que intervinieron en el estudio, para la confirmación diagnóstica, que se obtiene mediante varios ítems:

- 1) de la confirmación de los signos y síntomas observados;
- 2) de la frecuente asociación de hematomas subdurales con fracturas de huesos largos. Pero, además deben estar presentes los siguientes indicadores: 1. potencial de maltrato de los padres estudiando la psicodinámica de la entrevista familiar; 2. un niño que es visto como diferente o que es diferente; y 3. una crisis familiar en personalidades frágiles.

Si no es un niño apaleado, se lo da de alta. Si se confirma el diagnóstico del apaleo, se determina la estrategia terapéutica y el Centro de Referencia puede elevar la denuncia a los jueces con fuero del menor y/o a los organismos protectores del menor.

Se determina entonces el grado de riesgo, diferenciando familias de alto, mediano y bajo riesgo, según standards establecidos en el Proyecto de Atención Integral de Niños y Adolescentes Maltratados.

Esta escala está hecha sobre los siguientes factores: dos variables identificadas: la macrovariable social, en función de los ingresos (NBI) y la macrovariable psicológica independiente de lo económico, más ligada a lo cultural: variable Familia-Hijo, consideradas "potenciales de maltrato" que en su entrecruzamiento con la situación de crisis familiar nos darán el

grado de predicción del riesgo. "Proyecto pág. 23".

Se trata de detectar, sobre todo, las familias consolidables. Un 20% no lo son.

Se establece un plan de tratamiento psicoterapéutico con objetivos de corto y largo plazo. Si la familia es de alto riesgo, el Centro informa al Asesor de Menores, quien tramita la intervención judicial.

Si la familia es de mediano riesgo, se realiza el tratamiento a corto plazo, mientras se mantiene internado al niño, internación que funciona como protección, se trata a los padres; luego se da de alta al niño y se continúa el tratamiento de los padres en forma ambulatoria y con visitas domiciliarias por asistencias sociales.

Si es una familia de alto riesgo, el menor queda a cargo de otro familiar, de una familia sustituta o un ama externa en forma transitoria por orden judicial, y se brinda tratamiento psiquiátrico a la familia natural.

Si la familia no es recuperable, el juez decide la adopción.

El tratamiento comienza tan pronto como la presunción diagnóstica es suficiente.

La incredulidad del paciente ante la idea misma de ser asistido y su hipersensibilidad al desengaño, dificultan la alianza de trabajo con él. Si el terapeuta es avezado y tolerante, el tratamiento comienza a ser significativo.

Se establece una relación de dependencia con el terapeuta, en la cual el paciente adquiere la vivencia emocional correctora de una nueva modalidad de vínculo padres-hijos. Intentar disminuir la dependencia demasiado pronto implica el riesgo de poner fin al tratamiento y devolver al paciente a su anterior incredulidad a toda asistencia.

Nuestras metas terapéuticas son de alcance limitado: modificar el modelo de inter-relación padres-hijos y romper el círculo vicioso que hace que esta interrelación pase sucesivamente de generación en generación; no intentamos obtener un cambio caracterológico profundo, pero al modificarse las interacciones, se producen cambios estructurales.

A medida que avanza el tratamiento y por identificación con el rol del terapeuta, adquiere importancia una función paterna, simultáneamente protectora y organizadora de un sistema valorativo, que no impone sumisión, sino comprensión de las necesidades del niño. Esa función paterna no solamente exige respeto sino consideración y tolerancia hacia el problema de los padres.

El conflicto con la autoridad paterna explica primero, su miedo a la autoridad y su tendencia a evitar el castigo, engañando acerca de los motivos de los síntomas del niño. En segundo lugar, explica la dificultad del terapeuta para evitar una actitud sancionadora y para hacer comprender a los padres que las medidas no son castigos, sino ayuda.

El equipo médico-social establece los criterios de alta, avalados por el Centro en acuerdo con el juez. Producida ésta, se continúa con el seguimiento ambulatorio a largo plazo. En el caso de familias consolidables, el juez decide el reingreso o no del niño al hogar.

EJEMPLIFICAREMOS CON UN CASO CLINICO

Recibimos la denuncia de una escuela con respecto a Luis, alumno de 3er. grado, quien llega frecuentemente con lesiones.

El equipo de Violencia Familiar concurre a la escuela: una psiquiatra, una pediatra, una asistente social y una abogada. Realizado el examen clínico se constata: niño de 8 años, pálido, temeroso, con ropas adecuadas al clima del día pero, desprolijas y un aspecto general descuidado y con manchas de sangre en la ropa interior que corresponden con las lesiones infraumbilicales y glúteas. El examen físico presentaba escoriaciones, por mordeduras, rasguños, hematomas importantes en distintos períodos de cicatrización en todo el cuerpo, mordeduras y rasguños en el dorso de ambas manos.

Se envía detalle de estas lesiones al asesor de menores, realizando la denuncia y citando a los padres a través de la maestra de grado.

Ella notifica al Centro de Violencia Familiar que Luis concurre a la escuela con una nota. El padre se niega a la citación y el niño presenta nuevas lesiones en la cara y las manos: una de las cuales no puede usar adecuadamente por el dolor pues estaba fracturada. Las lesiones de la mano, que fueron producidas porque la madrastra ejerció un tironeamiento de los dedos abriéndolos y estirándolos al mismo tiempo hacia la cara dorsal de la mano. Se fotografían las lesiones.

La caución judicial del niño por el Asesor de Menores y la autorización del Director del Colegio, nos posibilitan su internación en el Hospital de Niños. A Luis se le explica que se lo lleva al hospital para tratar sus lesiones y que sus padres iniciarán un tratamiento para que puedan estar nuevamente todos juntos.

Los padres aceptan con desagrado el tratamiento psicoterapéutico y la participación en los grupos de autoayuda para familias con problemas de abuso.

Piden que el niño sea dado de alta y se avienen a que viva transitoriamente en la casa de un familiar (tío de la madrastra y abogado) para dar tiempo a un psicodiagnóstico familiar y evitar un nuevo riesgo al niño.

Constelación Familiar

Viviana: 35 años. Secretaria de una empresa, de 8 a 19 horas.

Pablo: 40 años. Bibliotecario.

Viviana tiene 3 hijos de un matrimonio anterior: Roberto, 15 años; Ignacio, 14 años; Constanza, 13 años.

Luis es hijo de Pablo, 8 años.

Historia Familiar

Llevaron 3 años de casados y ambos estuvieron casados anteriormente.

Pablo se casó a los 27 años con María Elena de 35 años. Se llevaban bien aunque tenían inconvenientes con la familia de él por la edad de ella.

En 1983 fallece María Elena de un paro respiratorio.

Viviana se casó a los 19 años. A los 20 tuvo el 1er. hijo. A los 21 el 2do. y a los 22 el 3ro. A los 24 se separó de su primer marido. Esté la maltrataba. Era policía. En una oportunidad, le rompió la nariz. En otra, después de un episodio de golpes, quedó ciega 24 horas.

Luis tenía 4 años cuando falleció su madre. A los 5 años de Luis, Pablo se casa con Viviana.

Viviana al principio se llevaba bien con Luis y le dedicaba mucho tiempo. Empezó a estar mal con él cuando sintió la falta de anuencia de Pablo. Se quejaba de su conducta, de que no tenía límites y no quería hacer los deberes.

Luis habló tarde: 2 años y medio. No le dieron el pecho.

Pablo tiene tres hermanos. Uno falleció. La madre era sobreprotectora. Se trasladaban frecuentemente porque el padre era militar. Era severo y les daba palizas. Cuando sobrepasaban el límite, les pegaba con el cinturón. Considera normal que su padre le castigara. Lo "de otro planeta es que no se le pegue".

Viviana dice que se descontrola frente a las mentiras de Luis. Entonces, llama por teléfono a Pablo y éste "se borra".

Viviana se queja de su ausencia durante los fines de semana. Los hijos están en función de él y no él en función de los hijos.

Entrevista Familiar

Concurren Pablo, Viviana, los 3 hijos de ella y Luis. Pablo muestra su protesta leyendo el diario en un extremo del consultorio. "A él nadie le va a decir lo que tiene que hacer". Protesta también por la internación de Luis en el Hospital. "Esto es un complot contra nosotros", dice.

Viviana se muestra más colaboradora.

Diagnóstico Familiar

Luis ocupa el lugar del que es pegado, como lo era Viviana en su 1er. matrimonio. Con ello, también castigaba a Pablo. Para ella, Luis representa un fracaso frente a un proceso de adopción. Hay un "como si" fuera la madre pero, algo fracasa desde ambos lados de esta dupla (madre-hijo). Para el chico, ella no puede sustituir a su madre y se lo demuestra constantemente. Pablo busca a alguien para cuidar a su hijo, alguien que reemplace a su mu-

jer anterior, para no verse comprometido en ningún tipo de esfuerzo psíquico ni familiar. Si Viviana cuida a su hijo, él desmiente la muerte de su esposa. Ella busca, quizás, a alguien que la ayude con sus hijos y cada uno frustra las expectativas del otro. El hijo funciona como chivo emisario. Por otra parte, de esta manera el niño, al ser golpeado, deja sin elaborar el duelo por la madre muerta. Pablo tiene rasgos psicopáticos, no permite el pensamiento de los integrantes de la familia así como el de la analista. Le hace vivir a Luis lo que él vivió cuando era chico.

Pablo no tiene un lugar psíquico de padre. Buscó una madre en su primera mujer, lo mismo que en la segunda.

Este grupo familiar se caracteriza por una escisión interna. Luis es el emergente de esta situación, manteniendo el equilibrio del sistema.

De ahí la insistencia para que Luis vuelva a la casa.

Si el niño no habla hasta los 2 años y medio es porque su padre privilegia las acciones y no las palabras. En esto, Luis parece identificarse al padre.

Pablo denuncia su propia transgresión cuando se refiere al complot que, supuestamente, hacen contra él. La palabra "complot" muestra lo que él hace para que la esposa le pegue al hijo y lo deje a él borrado, desconsiderando el llamado de la ley. En él está en juego el mecanismo de la desmentida y una actitud tendiente al desafío, afán de venganza, hacerle al otro lo que él padeció.

Los parámetros generales que expresamos anteriormente, se observan en este caso. Luego consideraremos también el tercero de los factores, es decir, por qué el niño se dejaba golpear.

Para mayor claridad, dividí este tratamiento en tres partes.

Primera parte

"En toda esta primera parte Pablo protesta enojado por la obligación de tratarse. El no tiene que cambiar. Confunde a la terapeuta con el juez y dice que ella lo condenó a esta cárcel. Usa palabras despreciativas hacia la terapeuta. Las sesiones son muy violentas. Insiste que le devuelvan a Luis. "Que se lo sacaron, se lo extirparon, como si le hubieran sacado un brazo".

— Aquí se observa la lógica de que el hijo es carne de su carne. Y como en el código griego o romano, él tiene derecho a hacer con su hijo lo que quiera, porque es como una extensión de él, en lugar de que aparezca otra legalidad rigiendo la relación vincular.

"En otras sesiones se burla, mientras la terapeuta interpreta.

En cambio, Viviana acepta el tratamiento y dice que no quiere ser 'la voz cantante de la familia'. Pablo va a separarse de Viviana para que le devuelvan a Luis y que de esta decisión nosotros somos culpables".

— Estas son las presiones con las que trata de manejarnos. Las presiones constituyen un capítulo especial de estos tratamientos; presiones que utilizan para que se les devuelva el hijo.

— "Dice que todo esto le hace recordar la película Kramer vs. Kramer, anticipando el desenlace ulterior de este tratamiento. Piensa que la devolución de su hijo depende de mí, él quiere seguir siendo como es.

Para Viviana los problemas empezaron

cuando empezó a ponerle límites a Luis. Las normas que ella pone en la casa no tienen ningún sentido para Pablo".

— "Que ella era muy rígida y él muy tolerante".

Pablo va admitiendo que dejó a Viviana las dos funciones, la de padre y la de madre.

En este tramo del tratamiento, fueron elaborando el duelo por la muerte de María Elena, que seguía ocupando su lugar en la casa".

— Para Viviana, Luis era una representación de Pablo y también una representación de la primera esposa: de ahí sus celos y su envidia.

— Vivían el tratamiento como un cautiverio porque les era muy doloroso pensar, ellos actuaban en vez de pensar.

A pesar de las protestas, reconocen cambios en Luis. En las sesiones él me maltrata como fue maltratado por su padre y no puede creer que pueda recibir ayuda. Los chicos, mediante juegos, también expresan esa misma desesperanza. Luis teme por la continuidad del tratamiento, dada la violencia que impera en las sesiones familiares. Pablo expresa lo mal que se siente por haber descuidado a su mujer y a su hijo. Se sintió forzado a reemplazar su mujer muerta por otra y ahora plantea separarse. La mujer se murió y se generan situaciones para que termine de morirse y esto sólo ocurriría si desaparece Luis. Ella, a su vez, muestra que es el portavoz activo, la que pega. Que la posición de Pablo es muy cómoda, que ignoraba todo lo que pasaba en la casa. Pablo, a su vez, le reprocha que si ella no hubiera pegado no estarían allí y ella responde que si no hubieran pasado otras cosas antes, ella no hubiera llegado a esto. Las cosas de antes, era que ambos eran

maltratados.

— "Hay una falta de padre y madre". "Y los niños lo muestran en un juego donde expresan la búsqueda de una familia. consta de un carrito que tiene cubos de distintos colores y los niños colocan cubos de iguales colores de tres en tres y en el centro queda un lugar vacío. Toman el tiempo que tarda cada uno, el que más tarda es Luis, es al que más le cuesta encontrar una familia. El agujero significa que Luis no está en casa. Si hay un agujero, es porque ellos usan a Luis como tapón. Luis tapa muchos agujeros. El vacío de no pensar, se tapa con los golpes que recibe.

Constantemente me piden a mí que les devuelva al hijo, confundiéndome con el juez. Creen que están aquí porque yo los obligo. Les explico que transgredieron la ley, que Luis les será devuelto por disposición del juez pero, a pesar de mi insistencia, parecen no escuchar.

Esta relación de violencia que establece Pablo en las sesiones quieren comunicar algo: ¿es un mensaje verbal sin palabras? ¿o es una descarga? o es una puesta en juego de un modelo sociocultural. El material que ellos dan es difícilmente interpretable, no me dan un espacio simbólico. Al respecto es necesario pensar qué técnicas terapéuticas resultan pertinentes para crear ese espacio simbólico y reflexivo.

— En las siguientes sesiones, se elabora sobre todo el desamparo de Pablo y su necesidad de ayuda. Viviana cuenta que Pablo en los momentos de mayor resistencia al tratamiento, delante de los hijos, en la casa, llamaba a las sesiones "la casa de las brujas".

— Ella es una caracterópata histérica y

él tiene una estructura psicótica con elementos psicopáticos.

Segundo Período

— Viviana plantea la separación. Entonces, Pablo comienza a preguntar en qué tiene que colaborar y qué tiene que cambiar. (Tomar conciencia de la infracción de la ley). “Hasta hace poco yo era terminante, ponía mis propias reglas, ahora trato de ser más flexible. Quiero cargar con mis propias culpas y no echarle más la culpa a la terapeuta”. Aparecen todas las quejas de Viviana sobre la negligencia de Pablo hacia Luis. Dejaba todo en manos de Viviana. Esta no podía pegar a Pablo y le pegaba a Luis. Este ocupaba un lugar muy especial en la casa, como ya vimos.

Pablo acepta intervenir en el Grupo de Padres Anónimos y acepta un tratamiento individual para Luis. En las sesiones siguientes, el tema es la separación de Pablo y Viviana. Podemos ubicar en este momento, una situación muy importante que es la situación de cambio en la defensa, o sea, que en él comienza a ceder la desmentida y en ella disminuye la identificación con el afán de venganza del hombre.

Tercer Período

Solamente intervienen ahora Pablo y Luis.

El juez ordena que Luis vuelva a vivir con su padre. Se mudan a un departamento y Viviana y sus hijos quedan viviendo en la casa anterior.

Pablo relata que Luis pega a otros chicos en el colegio y decide cambiarlo.

— Según relata Pablo, Luis nunca se queja. Se apretó el dedo con la puerta del armario al querer sacar un destornillador.

Se fracturó el dedo. Tampoco se quejaba al padre cuando Viviana le pegaba. El niño ponía su cuerpo, sus huesos, porque mantenía el “núcleo familiar” y creía hacer feliz al padre.

Ellos tampoco tomaban en cuenta el sufrimiento del niño y sólo daban órdenes. Esta actitud era similar a la de los torturadores: admiran a los que no dan información, como los padres al niño que no llora. Destruyen a los que dan información, como los padres lo hacen con el niño que llora, pues así informa sobre el sufrimiento.

Ahora, Pablo organiza su vida de acuerdo a las necesidades de Luis. Y el niño cada vez más le recuerda que lo necesita como padre. En el nuevo colegio los chicos lo llaman “trollo”. “Trollo” significa “invertido”, condensando un doble significado del cual yo tomo uno: el significado no sexual. El les puso picante en los caramelos y bombitas de mal olor. Es decir, que cambiaron de colegio pero, llevaron su problema a otro colegio. Antes Luis ponía el cuerpo para que Pablo tuviera a Viviana, ahora induce a que lo maltraten los chicos. Por eso le decían trollo, porque hacía todo al revés. Cuando Pablo observa cómo dialoga con el hijo, aprende él mismo a escuchar los problemas de Luis. Todavía hay un espacio vincular entre ellos que no entra a la sesión. Es un vínculo muy frágil. Luis lo mostraba haciendo navas espaciales que se deshacían en el aire con violencia. La violencia vincular es un objeto de tal naturaleza que la mente no puede contener y por eso la dispara al aire. La violencia debía ser expresada en palabras, tal como ocurrió luego. Lo promisorio es que vengan los dos. Esto habla del deseo de repararse. Antes, Pablo no sufría por los golpes de su hijo. La separación de

Viviana le reaviva la separación de su mujer muerta y reaviva sus sentimientos congelados. Comprende que el cambio del colegio era porque ellos necesitaban tiempo para cambiar y el colegio contenía las cosas locas de su hijo. Se sienten más entendidos por mí, me escuchan más y están experimentando en esas relaciones vinculares, sus propias relaciones padre-hijo. Luis se preocupa cada vez más por el colegio y los deberes. Pero, nuevamente, tiene encontronazos con los chicos y siempre sale golpeado. Piensa que no le duele porque está tan muerto como la madre muerta.

Pablo se convierte en líder del grupo de Padres Anónimos. Acepta y comprende la denuncia del maltrato y expresa con palabras su violencia. Luis sintió la muerte de la madre como un derrumbe. Ella era la base que sostenía a la familia. Cuando ella murió, él se sintió obligado a sostener al padre “poniendo el cuerpo”. Pensaba que la catástrofe era mayor para el padre y ahora se da cuenta cuánto le tocó sufrir a él. Ahora están experimentando: él como hijo que necesita a su padre, y el padre respondiendo a esa necesidad. Se está resolviendo la inversión de roles. Pablo pide ayuda a su propia madre, de la cual estaba alejado. Pablo se siente útil, y asiste con gusto a las sesiones; lo que se ve es que se está resquebrajando la desmentida frente a la pérdida de objeto. Antes, cuando fracasaba la desmentida, surgían bruscos estallidos de ira y desafíos a la ley que le exigía ser padre. Ahora reclama ayuda a su madre sin dejarse invadir por la furia. La alianza defensiva patológica con el hijo se quiebra y sólo en estas condiciones Pablo permite entrar al tercero. Luis no se pelea con sus compañeros y está integrado en el colegio. La abuela lo

lleva a natación y lo trae.

El aspecto de Pablo se ha modificado notoriamente. Venía desprolijo, era gordo. Adelgazó 11 kilos y se viste elegantemente. Luis tiene amigos que antes nunca podía tener. Ha transcurrido un año de tratamiento”.

En este caso la discriminación condujo a la separación.

Deseo comparar este caso con otro que va a presentar la Dra. Mindez, abogada del caso. Ambas familias son de clase media y poseen la misma estructura. El padre es viudo y tiene 2 hijos del 1er. matrimonio y la esposa de este 2do. matrimonio es divorciada también con hijos. El padre era una persona distante afectivamente, un abogado con actuación política e influencias a través de familiares y correligionarios. Era de clase social superior a la de su esposa que aparentemente era la que golpeaba. Pero, a diferencia del caso recién descrito, el padre rehusó continuar el tratamiento, mantuvo el predominio de la desmentida y una actitud desafiante respecto de la ley, y se valió de todas sus influencias para dificultar nuestra labor. Ante este panorama se presentaba un complejo proceso jurídico tendiente a proteger la integridad física de los niños. En cambio, la evolución del caso que describimos ahora permitió el reintegro del hijo al hogar.

Recuperó lo que nunca había tenido, un padre. Antes Pablo no podía poner límites. Ahora cumplía adecuadamente su función. Empezó a admitir la ley cuando la mujer se separó. Esto fue una repetición de la pérdida de la primera esposa, sólo que en el primer caso él no pudo soportarlo y ahora entró en la cordura.

LA RELACION CON LA LEY

Una diferencia fundamental entre estos tratamientos y una psicoterapia convencional de grupo familiar o de binomio vincular o de pareja, consiste en que en estos casos es insoslayable el análisis de la relación con la ley. Se presenta toda una relación entre el juez y el terapeuta, y entre el juez y los pacientes. En algunos casos incluso trabajamos sin denuncias a la justicia porque sabemos que los padres tienen interés en el tratamiento y porque respetan al Centro y sus profesionales como autoridad.

En cambio, en otros, donde la transgresión es muy severa, porque desafían todo tipo de autoridad, es necesario trabajar con denuncias, con apoyo de la ley, y entonces hay mucho más riesgo de fracaso, porque es más difícil crear un vínculo de confiabilidad. En estos pacientes, hay una legalidad en lo intrapsíquico: hay una ley que ellos destruyen. Así como el psicótico ataca sus vínculos con la realidad, estos pacientes atacan sus vínculos con la ley: es una defensa particular que no les hace perder el contacto con la realidad, sino su contacto con la ley.

Freud habló de la pérdida de realidad en la psicosis. Aquí uno podría hablar de la pérdida del Super Yo, o de la pérdida de la ley, o de la idea jurídica, de los derechos humanos, digamos, y se introduce otra legalidad en esta familia, donde el hijo pasa a ser posesión de sus padres, como lo era en el derecho griego, y en el derecho romano. En estos padres se conserva una lógica distinta a la lógica vigente, en que se supone que el hijo, si bien es de los padres, no pertenece enteramente a ellos.

La sociedad se hace cargo del niño; hay un código que los defiende, código que estos padres desafían.

Estos padres suelen tener una doble ética. La ética convencional, y otra desafiante de la convencional. A medida que sufren más heridas narcisistas, destruyen la ética convencional, y actúan según la lógica primitiva. Afirman "yo con mi hijo hago lo que quiero".

También el terapeuta tiene una relación con la ley, y sólo puede pensar en estos problemas clínicos si supone que el juez no es solamente alguien que sanciona sino que cuida y ampara. Esa es una de nuestras metas clínicas, que el paciente logra concientizar que hay una relación de amparo en la justicia y no solamente una relación de condena. Meta clínica muy difícil de alcanzar porque muchos pacientes sólo aceptan el tratamiento para que les conmuten la pena. Esta es una tentativa de corromper el vínculo. Cuanto más corruptores son, peor es la patología, como surge de la comparación hecha anteriormente.

Parte del tratamiento está abocada a que ellos tomen conciencia de que hay una ley y un tratamiento que los protege. Y esto funciona bien, cuando el asesor de menores y el juez conciben esta misma filosofía.

En Argentina tenemos la suerte de que podemos trabajar bastante cerca de los asesores y de los jueces, pero no todos los jueces todavía piensan con respecto a estos casos lo mismo. Muchos lo toman directamente como un delito que hay que penar y no piensan en modos alternativos de la pena. Sólo piensan en el castigo y no en la rehabilitación por el tratamiento. Así este delito puede llevar a otro peor que es convertir en abandonado un chico

maltratado.

Es necesario formar futuros jueces específicamente para este tema.

En la dehiscencia que hay entre el juez y el terapeuta, perdemos el paciente.

Todavía en nuestro país no hay un código del menor ni una ley específica de maltrato. Varios diputados y senadores presentaron proyectos de ley y un código del menor que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.

Es necesario formar terapeutas que contemplen este problema en su relación con la ley. En la modalidad clínica convencional, el terapeuta está solo con su paciente. Pero en este campo multidimensional, se necesita una visión más amplia y tomar en cuenta otras variables: la jurídica, la relación de la inserción al medio.

INFLUENCIA DE LA CONTRATRANSFERENCIA EN EL TERAPEUTA Y EL EQUIPO

En estos tratamientos surgen dificultades transferenciales y contratransferenciales que provocan distintos efectos emocionales en el terapeuta y en el equipo, que pueden interferir en el trabajo. El horror de lo que está ocurriendo puede transformar al terapeuta en hiperjusticiero, transformando en sanción su actividad terapéutica. En otras ocasiones, la angustia que le provoca el cuadro lo lleva a negar núcleos importantes de la problemática y, en ese caso, se transforma en una especie de aliado de los corruptos. Otras veces, no logran diferenciarse del juez.

El tratamiento familiar se ve dificultado porque estas familias trasgresoras cuestionan las normas terapéuticas, desautori-

zan las palabras del terapeuta, desestiman la gravedad del problema y su participación personal en él.

Inclusive la intervención de terceros perturba la continuidad del tratamiento.

Los profesionales del equipo pueden sufrir el riesgo de verse envueltos en los mismos ciclos de violencia por las situaciones contratransferenciales provocadas.

Los mismos factores predisponentes que actúan en las familias abusivas actúan también en la familia profesional, provocando relaciones agresivas entre sus miembros, identificados con la violencia familiar. Debido a ello el equipo debe tener una estructura básica firme, procedimientos realísticos para el diagnóstico, delineamiento de roles con responsabilidad definida, supervisión de casos de manera regular, consultas y un programa continuo de entrenamiento.

Es necesario, por otra parte, un grupo de reflexión sobre la tarea con inclusión de todos los profesionales, para controlar las masivas proyecciones de que son objeto, y para evitar convertirse en profesionales golpeados, y por lo tanto ineficaces para la tarea.

Otros servicios implementados para el tratamiento integral son la asesoría legal a las familias y sobre todo a los padres, así como también a los profesionales que consultan a nuestro Centro.

Se está organizando una escuela para padres.

En caso de necesidad, se realizan tratamientos a parejas e individuales a los padres y a los niños, y tratamiento psicopedagógico; apoyo de Servicio Social, psiquiatría jurídica de urgencia, ya que hay que denunciar al juez e incautar al niño si los padres no aparecen. También seguimiento de las familias sustitutas y aten-

los padres no aparecen. También seguimiento de las familias sustitutas y atención pediátrica del niño agredido y sus hermanos.

RESUMEN

Esta presentación ha pretendido:

1º) Describir la psicopatología de los padres abusadores, sus pautas de crianza y su especial estructuración psicológica.

2º) Describir en estas familias maltratables las principales características de las relaciones de sus integrantes entre sí y con el medio.

3º) Proponer técnicas de abordaje en la institución hospitalaria ante esta emergencia pediátrico-social.

4º) Influencia de la contratransferencia en el terapeuta y el equipo.

5º) La relación con la ley.

6º) Desarrollar el tratamiento de un

caso para ilustrar algunos de los puntos tratados.

SUMMARY

The aims of this paper are:

1º) To describe the abusive parents psychopathology, their own background and their peculiar psychological structure.

2º) To describe the outstanding features of these child-abusive families regarding their mutual relations and with environment.

3º) To propose approach techniques within the Hospital setting to cope this Pediatric-Social emergency.

4º) To emphasize the influence of countertransference on the therapist and the team.

5º) To point out the legal aspects.

6º) To present the development of a case to show some of the issues presented in the paper.

Una modalidad de violencia conyugal: mujer golpeada

Lic. MARIA CRISTINA VILA de GERLIC

Lic. en Psicología de la UBA. Coordinadora del Proyecto de Investigación y Asistencia a la Mujer Golpeada de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA. Responsable del Área Psicológica de la Comisión de Violencia de la Subsecretaría de la Mujer. Berutti 3032, 7mo. "19". (1425) Buenos Aires.

INTRODUCCION

No es posible definir todos los actos entre personas que incluyen la fuerza física (prácticas rituales, trompadas en un ring, actos de tortura), con la simple palabra "violencia". Ni tampoco agrupar, para pensarlos de manera similar actos de violencia realizados en distintos contextos (hogares, campos de batalla, calles). Tampoco reunir y pensar unívocamente la violencia producida en diferentes tipos de vínculos (entre familiares, desconocidos, enemigos políticos), y darles una explicación en su conjunto. Es por esto que desde hace varias décadas, los teóricos e investigadores, han desechado la meta de formular un único modelo teórico para comprender todas las formas de violencia.

El siguiente texto sintetiza seminarios

centrados en una modalidad de violencia específica: La violencia ejercida contra las mujeres en el vínculo conyugal.

Los fundamentos de los conceptos desarrollados se encuentran en la producción intelectual internacional realizada hasta el momento al respecto, en los acuerdos internacionales referidos a ella, en el ejercicio de la práctica clínica personal, en la coordinación de grupos de tarea institucional abocados a la misma, en la tarea de concientización comunitaria.

El problema de las Mujeres Gopeadas se ha hecho progresivamente conciente, para la comunidad internacional. Nunca en el pasado se lo había denunciado, en diferentes países, tal como ahora se lo está haciendo.

Se reconocieron primero y con mayor facilidad las manifestaciones de violencia fuera de la familia y transcurrió mucho tiempo hasta que se derribaran, al menos parcialmente, los mitos que ocultaban la violencia familiar.

Sabemos, gracias a un considerable número de investigaciones que los incidentes violentos no ocurren con la misma frecuencia o gravedad entre todos los miembros de la familia. Si bien padres, hijos, nietos, esposos, hermanos, se pueden golpear, atacar sexualmente o matar, en todo tipo de combinatorios y grados de violencia física, psíquica y sexual.

Es necesario explicitar que la definición de violencia física, psíquica y sexual con la que desarrollamos la conceptualización sobre Mujeres Golpeadas no es tan trivial que incluya cualquier sentimiento, empujón, grito o acercamiento sexual "desagradables". Incidentes violentos menores ocurren posiblemente en la mayoría de los matrimonios, pero no es a ellos a los que nos referimos cuando hablamos

de mujeres golpeadas o de maridos golpeados.

La violencia conyugal es la forma más frecuente de la violencia familiar.¹

De acuerdo al informe realizado por el Departamento de Justicia de los EE.UU. —elegimos este país ya que cuenta con estadísticas totales a las que nos es posible acceder—, los hombres son responsables del 95% de los asaltos entre cónyuges, siendo además la severidad y la extensión de las injurias causadas a las mujeres más significativa que la ocasionada por éstas a los esposos.²

En Canadá el 60% de las mujeres asesinadas son mujeres golpeadas.³

Algunos de los especialistas entre los que se incluye Leonore Walker, consideran que el 50% de todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia física por parte de sus compañeros en algún momento de sus vidas.

El disponer de documentación fehaciente sobre el problema y la consecuente concientización ha comenzado a modificar profundamente el significado de este fenómeno para cada sociedad, y para cada una de las personas comprometidas en esta forma de violencia intrafamiliar.

Así como en Latinoamérica las mujeres testimonian y se organizan solidariamente frente a esta problemática en talleres de violencia hacia la mujer, tareas de concientización, protestas ante la indiferencia de las autoridades; de EE.UU. nos llega la historia —real— de una mujer golpeada (homicida de su golpeador), narrada en el notable film “La cama en llamas”, en el cual los hechos subyacentes a la problemática de la Mujer Golpeada jamás hubieran sido expuestos antes de la década del 70³ ante la opinión pública, desde una perspectiva en la que se leyerá con tal

claridad el proceso de victimización de la esposa y la participación de las instituciones sociales en el mismo.

La tangibilidad del problema de la Mujer Golpeada se acentúa con ímpetu desde los días de los primeros refugios (en Inglaterra) para Mujeres Golpeadas, de las organizaciones de mujeres que luchan (en Europa, EE.UU. y Latinoamérica) por difundirlo, desde los primeros trabajos académicos (básicamente sajones), hasta la concreción que le brinda el protagonizar series televisivas, la organización de grupos asistenciales, el interés de los organismos del Estado —y en los tres últimos aspectos ya hablamos de la Argentina—.

Murray Strauss nos dice “nadie sabe si ha aumentado (la violencia conyugal) o disminuido debido a que no hay estadísticas apropiadas en períodos históricos previos. Lo que ahora sabemos es que por la gran cantidad de razones (tales como el impacto del movimiento de mujeres, la angustia nacional debida a la violencia de las guerras, de los asesinatos, los crímenes violentos en las calles) ha habido recientemente mayor reconocimiento del problema y se ha constituido un compromiso para obrar sobre el mismo. También ha habido un incremento de actividades científicas acerca de este aspecto hasta hace poco formalmente ignorado de la familia”.⁴

Es necesario que distingamos a la violencia hacia la esposa como una de las modalidades de la violencia conyugal, la cual constituye a su vez una categoría de la violencia familiar.

Hay violencia conyugal de diferentes tipos:

a) *Los ataques cruzados entre cónyuges.* Con esta denominación nos referimos

a las parejas con conductas violentas en sus interacciones, en las cuales la balanza de poder entre cónyuges está distribuida con “cierto equilibrio”, y desde el contexto de poder semejante, el uno agrede al otro en una dinámica que se preserva “igualitaria” para la violencia y para otras conductas.

b) *El fenómeno del esposo golpeado.* Esta situación se produce, cuando el poder se concentra en manos de la mujer y entre otras formas de ejercerlo, ésta castiga al cónyuge físicamente (y psíquicamente), fenómeno poco descripto aún, que se observa en parejas en las cuales las mujeres son más jóvenes y ante la declinación física del cónyuge, establecen formas de abuso. También ocurre cuando se trata de cónyuges varones imposibilitados por otros motivos, como por ejemplo enfermedades.

Debe diferenciarse el poder de la esposa sobre el marido (que incluye abuso físico) de la *contraviolencia* con que responden las Mujeres Golpeadas a la violencia de un cónyuge abusador surgida ante el fracaso de otras opciones de defensa.

Las investigaciones han demostrado que el abuso físico de larga duración entre los cónyuges casi siempre es ejercido por el hombre. De allí que las pocas mujeres que hieren gravemente a sus maridos lo hacen después de haber soportado un período de violencia muy prolongado contra sí mismas y sus hijos.

c) *El haber pasado la mujer una sola vez por el ciclo de la violencia conyugal.* Mildred Pagelow denominó a esa única situación de golpes “golpiza principal” y describe que un número significativo de mujeres abandonan después de la misma la situación conyugal. Cuando la vincula-

ción entre los cónyuges no persiste en una relación en la que la violencia fue protagonizada sólo una vez por la mujer, ésta no es considerada una Mujer Golpeada.

d) A través de la literatura, el cine y la clínica se describen uniones en las cuales las mujeres (o los hombres) obtienen esencialmente placer sexual de un acuerdo que incluye la violencia física como estímulo de sensaciones eróticas. A estas situaciones las denominamos *acuerdos eróticos sadomasoquistas* (comparar con violación marital, más adelante, en Modalidades de Abuso).

e) *La Mujer Golpeada.*

La Mujer Golpeada es una mujer víctima de violencia física, psíquica, sexual, ejercida por su marido, compañero o novio.

La psicóloga norteamericana Mildred Pagelow define a la Mujer Golpeada como “La mujer adulta que ha sufrido abuso físico o psíquico intencional de maneras que han ocasionado dolor o injurias, y/o ha sido forzada a realizar acciones que no deseaba, o a quien se le ha impedido realizar acciones que deseaba por parte de un hombre, estuviera o no legalmente casada con él”.⁵

De acuerdo a Leonore Walker, “Una Mujer Golpeada es una mujer que ha sido repetidamente sometida a coerción física o psicológica por un hombre para que ella hiciera algo que él deseaba sin tomar en cuenta los derechos de ella. Mujeres Golpeadas pueden ser esposas u otras mujeres con diferentes tipos de relaciones íntimas con los hombres. Para categorizar a una mujer como golpeada, la pareja debe haber pasado por el ciclo de la violencia al menos dos veces. Cualquier mujer puede hallarse en una relación abusiva con un

hombre una vez. Si ocurre una segunda vez y ella permanece en la situación se la define como Mujer Golpeada".⁶

Según Emerson Dobash y Russel P. Dobash: "El uso de la fuerza física contra las esposas, debe ser visto como el intento por parte del marido de que las cosas se desarrollen como él lo desea. Es básicamente una conducta con un propósito y no una acción aberrante o inusual... Más aún, los hombres que injurian a sus esposas, viven de acuerdo con las prescripciones culturales que se comparten en la sociedad occidental —agresividad masculina-subordinación femenina— y usan la fuerza física como una manera de reforzar tal dominio".⁷

El Consejo Asesor Canadiense sobre el status de la mujer, define a la Mujer Golpeada como "la víctima de violencia física y/o psicológica, ejercida por el marido o un compañero varón, o en una relación lesbiana por quien toma el rol de marido (el cual la "esposa" no consiente), y que es directa o indirectamente permitido por las leyes y actitudes prevalentes en la sociedad en la que ocurre".⁸

Esta última definición nos parece excepcionalmente clara respecto a la interrelación entre sistema familiar y sistema social.

Los autores que han investigado esta problemática consideran que la estructura de relación en la que se engendran golpes es la del hombre que manda y la de la mujer que obedece. Steven Morgan acuñó la frase "terrorismo conyugal",⁹ que sintetiza las amenazas de distinto tipo con que muchos cónyuges aterrorizan a "sus" mujeres. Literalmente controlan los movimientos de sus novias, esposas o amantes, por medio de actos de violencia.

Es insoslayable establecer una analogía

entre la violencia contra los niños y la violencia contra las esposas.

Se dice muchas veces de los niños que con ellos se aplica la fuerza física por motivos legítimos. Con frecuencia se les dan cachetadas y esto suele considerarse "normal" en la crianza de los hijos. Pegarle a un niño se considera parte del proceso por el que un adulto le enseña a una criatura sin experiencia cómo debe comportarse correctamente. Desde el punto de vista de los padres parecería tratarse de un hecho beneficioso y natural en la relación con el niño, ya que los padres ejercen una posición de autoridad y se sienten responsables de que el niño se conduzca de acuerdo con las normas sociales establecidas y también con las demandas específicas de la familia. Si el niño no se conduce de acuerdo con estas expectativas hay distintos mecanismos para controlarlo; uno de los cuales es el castigo físico.

El derecho de golpear a un niño está garantizado y justificado por la diferencia de status, autoridad y responsabilidad que se les atribuye universalmente a los padres, reconocidos como superiores en relación con sus hijos en la escala jerárquica. A los padres se les restringe con límites vagos, las sanciones sólo se utilizan cuando la violencia extrema amenaza la vida del niño, lo que plantea el dilema de proteger los derechos del padre y, al mismo tiempo, proteger a los niños del abuso de esa autoridad.

La relación entre maridos y esposas podría compararse, en el sentido de la jerarquía, a la de los padres e hijos. Tengamos en cuenta que el uso de la fuerza física por parte del marido contra la esposa era, no tan lejanamente, una expresión de la desigualdad de status, autoridad y po-

der que, avalada por la sociedad, otorgaba al marido una posición superior respecto de su esposa, por estar legalmente investido de la responsabilidad de controlar la conducta de ella, considerada legalmente como menos capaz y responsable que su marido.

Consideramos de acuerdo al marco teórico planeado por Dobash (ver bibliografía) que la situación de hombres y mujeres como maridos y esposas ha sido organizada históricamente en una estructura jerárquica en la cual los hombres poseen y controlan a las mujeres. La autoridad del marido sobre su mujer tiene cuantiosos referentes legales, económicos, e ideológicos, que incluyen la aprobación de la utilización de la fuerza física contra la mujer.

"Si bien el derecho legal del hombre de golpear a su mujer ha dejado de ser reconocido explícitamente en la mayoría de los países occidentales el legado patriarcal continúa generando las condiciones (el subrayado es mío) y relaciones que llevan a que su marido utilice la fuerza contra su mujer".

Dichas condiciones en lo legal, hacen depender a la mujer del marido o le impiden litigar contra él, en lo económico le dificultan sobrevivir sin él, en lo ideológico le plantean por un flanco la imagen de mujer indefensa y por otro la compelen, desde las instituciones a quedarse en "su lugar".

LA PROBLEMÁTICA DE LA MUJER GOLPEADA

Forma parte de los objetivos de este trabajo que el tema de las Mujeres Golpeadas

sea considerado a la luz de algunos de los diferentes aportes que sobre el mismo se han desarrollado.

Desde esta perspectiva, es crucial remitirse a las declaraciones del grupo de expertos sobre la violencia en la familia con especial referencia a sus efectos sobre la mujer (Viena, 1986), convocada en respuesta a la resolución 1986/14 del Consejo Económico y Social, y organizada por la Subdivisión para el adelanto de la Mujer, en colaboración con la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de Naciones Unidas.

En dicha reunión se aseveró que "Durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, ha ido reconociéndose cada vez más que la violencia en la familia es una cuestión compleja que constituye una ofensa intolerable para la dignidad de los seres humanos".

El Consejo admitió que "el problema de la violencia en la familia es una cuestión compleja y de larga data que requiere una atención seria y cuidadosa. Se instaba a los Estados miembros a que adoptaran medidas apropiadas para llevar a cabo las consecuencias adversas que tiene la violencia en la familia para los hombres, las mujeres y los niños afectados y para la sociedad en su conjunto y formularan soluciones a nivel nacional".¹

Muchas comunidades y gobiernos han reconocido, en la actualidad, el efecto destructivo que produce sobre las familias el abuso de la mujer y por ello han provisto de refugios y apoyo de índole legal y psicológica a las Mujeres Golpeadas y a sus hijos. Asimismo ha surgido la necesidad de instrumentar servicios para la rehabili-

tación de los golpeadores.

Dando un paso más adelante existen las comunidades que, con acentuada responsabilidad, informan a la población que éste es un problema inherente a todos los ciudadanos, porque afecta el futuro de la sociedad. A partir de esta premisa básica surge, en consecuencia, como vía de comunicación privilegiada de esclarecimiento y prevención: la educación. Así estas comunidades avanzadas (Canadá es el ejemplo más importante) encaran desde la escuela primaria la prevención de la violencia doméstica.

En la Argentina la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (Nº 23.179), y la sanción de la Ley de Patria Potestad y Filiación (Nº 23.264), son de 1985, es decir sanciones sumamente recientes y se requiere aún profundizar la vocación social para reconocer la igualdad de derechos femeninos. Otras circunstancias legales y de costumbres sexistas impiden que la legislación Argentina considere la violación marital como un delito.

En nuestro país, el problema de las Mujeres Golpeadas, ya tiene existencia como fenómeno social. Como señalamos previamente, organizaciones de mujeres, organismos de diferente tipo y la Subsecretaría de la Mujer han contribuido a dar una respuesta primera y modesta a las necesidades de las Mujeres Golpeadas en nuestro medio.

Los prejuicios más comunes

Aunque las mujeres son mayoritariamente las víctimas de la violencia física sistemática, las primeras preguntas que surgen de un grupo² cuando se trata el tema son:

“¿Y los maridos golpeados?”, a la que luego se agregan: “por algo será”, “les gusta”, “lo necesitan”, “no es un problema”, “sólo les pasa a los pobres y forma parte de un sistema de vida”. Y también: “por qué se preocupan tanto por las mujeres y no por los chicos”, “él debe estar enfermo” o “ella debe ser una enferma que lo enfermó a él” ó “porque ella se queda” ó “cómo puede vivir así”, etc. Si intentamos resolver el problema de la violencia que sufre la Mujer Golpeada debemos también tener en cuenta y tratar de entender estos comentarios, emergentes de la sociedad en la cual se ejerce violencia hacia la esposa.

Se cree que la “violencia matrimonial” y en consecuencia la problemática de la Mujer Golpeada son un patrimonio de los sectores populares y se los asocia con variables tales como promiscuidad, alcoholismo y falta de cultura. Lo que sucede es que existe más información acerca de lo que ocurre en los sectores populares, simplemente porque las mujeres de dichos grupos tienden, en situaciones graves, a hacer denuncias y no existen paredes que tamicen gritos y golpes. Las clases medias y altas acuden a abogados, médicos u otros profesionales. El factor educación tampoco puede correlacionarse con el problema. Se dan casos de mujeres profesionales o que han desarrollado actividades comerciales o académicas con éxito que son golpeadas por sus cónyuges. La causa reside en la “falta de poder” de la mujer en la estructura familiar, que no coincide necesariamente con la ausencia de poder en otros ámbitos.

Muchas esposas de clase media o media alta llegan a la terapia por otros motivos de consulta (por ej.: depresión). Únicamente si el terapeuta les hace preguntas

precisas podrá saber que es víctima de abuso por parte del marido. Pueden pasar años de terapia sin decir nada al respecto. Este silencio precisamente es lo que dificulta la toma de conciencia pública del problema. La mujer que sufre el problema se siente culpable, lo vive como una falta grave cometida por ella, busca en su propia conducta el desencadenante de la agresión de su marido. Muchas mujeres sufren los golpes en silencio. Nuestra primera tarea es hacer que la mujer tome conciencia de la situación que vive, ya que la violencia se incrementa si se somete pasivamente a ella. El peligro al que se enfrentan es real y no imaginario; muchos homicidios fueron y son el resultado de años de violencia que comenzaron con violencia menor (verbal, física o sexual).

El medio social (familiares, amigos, vecinos) contribuyen al silencio de la mujer. Cuando ella cuenta lo que le está pasando ó cuando grita, la primera reacción es de incredulidad. Complejos mecanismos psicológicos de negación posibilitan esta conducta. Ya dijimos que nos resulta muy difícil reconocer la violencia tanto en la propia casa como en la de los seres cercanos. Esas cosas sólo les suceden a los otros y los otros no son nuestros amigos, parientes o vecinos, sino desconocidos que aparecen en las crónicas policiales.

La no comprensión de este “entreteji-do de afectos contradictorios” explica que muchas personas cercanas en lugar de ayudar ejerzan hasta una violencia verbal contra la propia víctima³ (por ej.: “te lo merecés por sometida”). Esta reacción agudiza la sensación de culpabilidad e impide buscar soluciones positivas.

Por otro lado la apatía institucional (comisarías, hospitales, etc.) refuerzan la

sensación de impunidad del agresor y de desamparo de la víctima. Los profesionales que actúan en instituciones conocen, por experiencia, que muchas mujeres con lesiones graves o víctimas de homicidio han solicitado auxilio previo, varias veces, infructuosamente.⁴

En otro orden institucional, recién algunos grupos religiosos han comenzado a producir un tratamiento adecuado del problema. Este tema nos preocupa muchísimo ya que las mujeres recurren muchas veces a sus confesores ante las situaciones de violencia que padecen en su hogar. Los confesores socializados en las pautas de la obediencia —sutil o no sutil— que la mujer le debe al marido, pueden tener respuestas tales como “pon la otra mejilla”. Respuestas poco adecuadas que, en el caso de nuestro país, forman parte de la negación e ignorancia en lo que atañe a este tema.⁵

Tampoco podemos olvidar que la sociedad argentina se ha impregnado de autoritarismo, agravado por las sucesivas dictaduras y la enorme represión a la que nos hemos visto sometidos. La impunidad y la falta de control social son factores importantísimos, casi el co-relato, el acompañante de la violencia que puede ejercerse sabiendo que existe tal impunidad y falta de control.

Hemos advertido, por ejemplo, que muchas mujeres que antes de 1983 no se animaban a divorciarse, tomaron la decisión a partir de sus experiencias de vida en un momento democrático, ya que las amenazas que se generan en el ámbito conyugal podían enfrentarse en un país en democracia. En un contexto democrático la mujer tiene mayor posibilidad de discernir esas amenazas. Pero en la situación como la que vivimos durante la dictadura, sabía-

mos que determinadas amenazas podían cumplirse. Desde el campo ideológico debemos decir que había hombres de todas las ideologías que golpeaban o abusaban de sus esposas, incluídos aquellos de los sectores que estaban asociados al "proceso". En este último caso las amenazas de los Hombres Golpeadores articulaban a su mundo privado el "arsenal" de poder político. Hemos atendido —en la práctica privada— a mujeres que estaban casadas con hombres pertenecientes a sectores represores y las amenazas que recibían no eran las amenazas con que actualmente un marido golpeador puede asustar a su mujer. Quizá la más obvia sea: "Si esto no te gusta te hago desaparecer..." Nuestras prácticas profesionales se insertan aún con una política nacional en sus inicios respecto al tema del maltrato.

MODALIDADES DE ABUSO

El trasfondo del modelo del hombre que manda y de la mujer que obedece está constituido con los vestigios de antiguas legislaciones y teologías organizadoras de un orden moral que refuerza la jerarquía marital y le dificulta a la mujer luchar en contra de la misma, porque su lucha es considerada, según ese código moral, equivocada.

Las tres modalidades de abuso que se incluyen en el concepto de "Mujer Golpeada" son: *abuso psicológico, físico y sexual*.

En el *abuso psicológico*, la mujer sufre por parte de cónyuge, compañero o novio; burlas, insultos, la negación de su mundo afectivo, la no aprobación de sus realizaciones, gritos —en público o en privado—

culpabilización de todos los problemas de la familia, ser llamada "loca", "puta", "estúpida", etc.; el ser amenazada con violencia extensible a los hijos, sufrir el establecimiento del miedo, acusaciones de inepta, etc.; hechos que son el desencadenante de estados depresivos y otros síntomas de alteración mental que conducen generalmente a que sea diagnosticada como "loca", situación que puede culminar con el suicidio de la mujer. Muchos suicidios de mujeres (en EE.UU. el 25% corresponde a Mujeres Golpeadas) todavía no son asociados a las historias de abuso emocional que ellas han sufrido, el suicidio resulta una opción desesperada para escapar de la situación de desequilibrio.¹

En el *abuso físico* la mujer recibe: empujones, tirones de pelo, bofetadas, puñetazos, patadas; se la golpea en partes específicas del cuerpo; se le proyectan objetos de la casa transformados en armas de agresión; se la hace abortar; se la deja "de hospital"; se le producen cortes; se le quiebran huesos; se la deja desfigurada o lisiada, así progresivamente en una escalada que puede terminar con el *homicidio* de la mujer. La prensa, con su manipuleo de la noticia, contribuye también a desvirtuar el fenómeno del abuso que sufren las mujeres, de este modo tras el título de "crimen pasional", se ignoran largas historias de abuso.

La muerte por homicidio se puede producir también cuando los hijos adolescentes intervienen en defensa de la madre; estas muertes no han sido correctamente asumidas en nuestra sociedad como la consecuencia del abuso de la esposa.

En el *abuso sexual*, el hombre se burla de la sexualidad de la mujer; le critica su cuerpo y su manera de hacer el amor, la

acusa de infidelidad, la obliga a distintas formas de acercamiento sexual en contra del deseo de la mujer; utiliza objetos o armas que desde el punto de vista sexual pueden producir lesiones en la mujer. Uno de los aspectos de esta modalidad del abuso es el de la "violación marital".²

Las investigaciones sobre el abuso sexual en el matrimonio (por ej., la de los sociólogos David Finkelhon y Kersty Yllo, en su discutida obra "*Permiso para violar*").³ describen los motivos por los cuales los maridos violan y el trauma emocional posterior a la violación.

Nos informan que:

- En EE.UU. la violación marital comprende todos los grupos socio-económicos.
- La violación marital no se ejerce solamente sobre mujeres golpeadas.
- La violación marital se produce cuando los maridos utilizan el grado de fuerza necesario para ser coercitivos con sus esposas respecto al sexo.
- La violación marital suele reproducir el esquema de poder y control del hombre sobre la mujer.
- La violación marital puede dejar heridas físicas y daños psicológicos (traumas).

La violación marital no es considerada delito real.⁴ Aunque en algunas legislaciones (Francia y Dinamarca desde 1986) se la toma en cuenta, no existe en el imaginario social. Más allá de los distintos debates sobre el tema, la sociedad tiene una idea muy vaga de la problemática. Las historias de las víctimas de este delito no han tocado la conciencia de la comunidad. La ignorancia popular acerca del problema de la violación marital es muy profun-

da. Por ej., cuando se le pidió a estudiantes de los EE.UU. que inventaran una historia sobre la violación marital uno de ellos escribió: "*El quería, ella no, él ganó*".⁵

De las cincuenta mujeres entrevistadas por los sociólogos David Kindelhon y Kersty Yllo:

- Una había sido violada a punta de cuchillo, contra la pared y amenazada de muerte.
- A otra mujer el marido le quitó el bebé y dijo que se lo devolvería después que tuviera relaciones sexuales con él.

Ninguna de estas atrocidades se informó a la policía o a los diarios.

Algunas no fueron informadas a nadie. Si estas imágenes quedaran inscriptas en la memoria de las personas la violación marital dejaría de parecer algo sin sentido.

En la opinión de David Finkelhon y de Kersty Yllo: "Para mucha gente la sexualidad forzada en el matrimonio tiene poco que ver con lo que se podría llamar una *verdadera violación*". De acuerdo con estos sociólogos éste es el primero y más básico de los mitos sobre la violación marital. "Cuando la gente piensa en violación, piensa en un extraño, en un arma, en un ataque forzado, en una amenaza a la vida de la mujer".⁶

El sexo marital forzado, por otro lado, evoca una situación matrimonial desagradable pero no especialmente grave.

En su investigación estimaron que la violación marital es frecuente y que ocurre de entre el 10 al 14% de las mujeres casadas. Un porcentaje similar arroja la investigación de Diana Russell, en San Francisco,⁷ sobre 930 mujeres. Cuando se trata de un problema de esta dimensión

no es justo decir que la violación marital es una agresión más desagradable que otras.

Si nos circunscribimos estrictamente a la violación marital como un modo del abuso sexual, de acuerdo a Finkelhor y Yllo, se pueden establecer esquemáticamente tres categorías: *violación con golpes*, *violaciones sin golpes*, *violaciones obsesivas*.

Las *violaciones con golpes* son las más brutales e incluyen incidentes que luego mencionaremos en las fases del ciclo de violencia. Ocurren en relaciones donde además de abuso sexual hay abuso físico. Los maridos que producen esta forma de violencia suelen ser muy *agresivos* con otras personas del medio. La violación, en estos casos, es tan impredecible como la aparición de otras modalidades de violencia. En ocasiones parece estar poco relacionada directamente con una problemática sexual, ya que muchas de las mujeres entrevistadas relataron a los investigadores citados que están sexualmente a disposición de sus maridos. Sin embargo, los hombres se sienten motivados por un intenso deseo de castigar, humillar, degradar y utilizan la violación para estos propósitos, vale decir como un medio. El 45% de las mujeres entrevistadas, sufrían este tipo de violación.

Las *violaciones sin golpes* se dan con más frecuencia en matrimonios de clase media que tienen historias menos violentas o abusivas. El factor precipitante de estas violaciones suele tener que ver con duelos sexuales, por ejemplo, con qué frecuencia se tienen relaciones sexuales y de qué tipo son. La fuerza se utiliza en estos casos para lograr el acceso sexual y no para causar daño físico. Parecen violaciones menos motivadas por la rabia y más por el

deseo de ejercer poder, control, enseñar una lección, quién es el patrón, etc. (Otro 45% de las violaciones que relataron las mujeres entrevistadas pertenecen a este tipo).

Finalmente existe una tercera clase de violación marital denominada *obsesiva* (el 10% de las mujeres entrevistadas padecieron esta clase de violación).

En esta relación de carácter obsesivo el marido tiene preocupaciones sexuales inusuales. Algunos de ellos están obsesionados por la pornografía; quieren que sus mujeres hagan lo que en los materiales pornográficos han visto. Otros tienen miedo de ser impotentes u homosexuales. Suelen tener rituales muy estructurados en referencia con la sexualidad. Parecería que estos hombres necesitaran violencia para acceder a la mujer. La humillación los estimula. Las mujeres que han padecido esta clase de violación marital sienten que han sido usadas como objetos.⁸⁻⁹

En el caso de que se expandiera el campo de la investigación quizás se podrían encontrar otros tipos o situaciones de violación marital. Si aparecieran las investigaciones estas categorías serían revisadas. Es importante que podamos situarnos mentalmente en estas modalidades de violación marital y escuchar a las mujeres que las han vivido.

La ausencia de estas historias en la conciencia de la comunidad genera una interpretación desvirtuada de la violación marital; esta interpretación concierne estrictamente a su *impacto*. La gente no cree que la violación marital produzca sufrimiento.

Las opiniones de este tipo llevan a comprender el trauma de la violación en términos de generalidades, excluyendo el tér-

mino específico de la violación marital. Lo que no se alcanza a comprender es que la violación no es traumática porque se trata de un acto realizado con un desconocido, sino porque ese acto no es deseado, ya sea con un extraño, amigo o marido.

Violación es la violación íntima de la confianza y autonomía de una persona.

Las investigaciones en los refugios han demostrado que las víctimas de la violación marital sufren un trauma mayor y durante más tiempo que otras víctimas de violación. Estas conclusiones no sorprenden a quienes han hablado con víctimas de la violación marital y pueden reconocer, también empíricamente, los tres tipos de daño psíquico que produce la violación marital: sentirse traicionada, atrapada y aislada.

Más aún que otras víctimas de otro tipo de violación, las víctimas de la violación marital sufren una profunda desconfianza. De los testimonios de las mujeres entrevistadas se dedujo, entre otras manifestaciones, que el hecho de que alguien necesitado afectivamente pudiera violarlas destruía en ellas la capacidad de confiar en otras personas.

Años después del cese del acto de violación marital, muchas de estas mujeres entrevistadas consideraron imposible la intimidad con un hombre. Este es un componente de la violación marital que no tiene un paralelo idéntico con el de la violación efectuada por un extraño. Las víctimas de la violación marital no son violadas una vez sino muchas veces. La mitad de las mujeres entrevistadas fueron violadas veinte veces o más por sus maridos. Vivieron meses, a veces años, con la amenaza real de una posible violación. Estas mujeres experimentaban una ansiedad

permanente, preguntándose cuándo ocurriría el próximo episodio de sexo forzado. El impacto destructivo de la violación marital puede ser sintetizado así: cuando una mujer es violada por un extraño vive con un recuerdo que la asusta. Cuando es violada por su marido debe vivir con su violador.

Por último, si bien todas las víctimas de violación se sienten estigmatizadas y con vergüenza, pocas sufren el total aislamiento que implica la violación marital. Ni parientes ni amigos sentirán por lo general, piedad por el dolor de estas mujeres. Ni la policía, ni la justicia se harán cargo de lo que han sufrido; en tanto que la ley no considere que la violación marital sea un delito.

En este aislamiento las mujeres tienden a culparse a sí mismas y se sienten "distintas" desde una perspectiva de inferioridad, desvalorizante; sentimiento éste muy difícil de modificar.

El sentimiento de aislamiento de la mujer que ha sufrido episodios de violación marital tal vez sea la prioridad de la que debemos ocuparnos. El debate acerca de considerar como delito la violación marital incluye bastantes temáticas legales, igualdad, detención del delito, modalidades de atención a los violadores, etc. De todos modos el más importante desde el punto de vista humano parece ser el de poder *compadecer* a la víctima.

En realidad, deberíamos legitimizar esta compasión. Los médicos necesitan, por ejemplo, conocer que no se trata solamente de que después de una intervención médica las mujeres violadas maritalmente eviten la sexualidad. La planificación sexual necesita tomar en cuenta que el tipo de matrimonio de estas mujeres, el díafrag-

ma, por ejemplo, como método de anti-concepción no es una protección adecuada. Los abogados, a su vez, necesitan reconocer la vulnerabilidad de las mujeres de estos matrimonios para poder enfrentar a maridos conflictuados durante el período posterior a una separación. Quienes hacen e implementan terapia de pareja o familia deberán saber que lo que no se habla constituye un duelo inelaborable para las esposas violadas.

Como podemos observar, la mayoría de las investigaciones acerca de la problemática de la violación marital se han realizado en los EE.UU. Aunque allí la violación marital no tiene un status legal en la mayoría de los estados, las investigaciones de Groth y Birnbaum, del año 1979,¹⁰ indican que puede ser más frecuente que las otras formas de violación combinadas.

Las estadísticas de la investigadora Russell,¹¹ correspondientes al año 1980 arrojan un porcentaje alarmante, pues de ellas se estima que la violación marital afecta a una de cada ocho esposas. Los factores motivantes pueden ser la rabia, la necesidad de dominar y, ocasionalmente, un conflicto sexual. Estos investigadores coinciden en que la violación marital ocasiona más perturbaciones psíquicas que la violación no conyugal. La violación en los matrimonios violentos parece tener consecuencias más graves, en la que hace a la auto-estima de las víctimas y en las actitudes de éstas hacia los hombres, que las relaciones de golpes sin violencia sexual.

Las Mujeres Golpeadas que han sido, además, violadas por sus maridos han vivido previamente a esta situación episodios de violencia no sexual más graves que el de otras mujeres. Los indicadores de las investigaciones muestran que los maridos

que violan a sus esposas con más frecuencia que otros hombres golpeadores tienen problemas de alcoholismo o han sido educados en familias con disfunciones graves o intentan el dominio absoluto de sus matrimonios.

Un investigador dedicado a esta temática, Bowker¹² no halló diferencias demográficas entre las familias con violencia sexual y las familias sin violencia sexual, y entre las familias con violencia física y las que no la padecían. Aunque el número de separaciones era semejante, el grado de insatisfacción por parte de las esposas violadas por sus maridos era mayor. En general, las esposas violadas buscan más ayuda que otras Mujeres Golpeadas; si bien las promesas de recomposición familiar son menos efectivas con ellas.

Siempre de acuerdo con Bowker, la violación en un matrimonio violento permite aproximar un pronóstico negativo para la continuación del matrimonio aunque la violencia cese; y un pronóstico negativo también para la calidad de los matrimonios que continuaran juntos. El daño que ocasiona la violación marital es tan profundo que los profesionales tratan de ayudar a la pareja a separarse, más que a vivir juntos.

Los resultados de la investigación de Bowker indican que los maridos que violan no tienen más probabilidades que otros maridos violentos de abusar de sus hijos, golpear a sus esposas mientras están embarazadas o utilizar alcohol u otras drogas cuando son violentos.

La única diferencia que señala la investigación es que estos maridos atacan a sus esposas más frecuentemente que los golpeadores que no violan.

Podemos señalar que en veinticinco

años, estimativamente, de producción e implementación de terapias sexuales, no se encuentran referencias al problema de la violación marital, hecho que, según las estadísticas de los que han investigado el problema, se ejerce sobre una de cada cien esposas.

Demasiados años han pasado sin que la violación marital se constituyera en problema. Cuando las personas sufren problemas que no existen se convierten en personas que no existen, ni ante sus propios ojos ni ante los ojos de los otros.

Configurar la violación marital como un delito les devolvería la existencia integral a muchas víctimas e interrumpiría graves situaciones, de consecuencias hondamente traumáticas, en nuestra comunidad.

RESUMEN

El trabajo presenta el problema de la mujer golpeada desde las perspectivas más recientes (sociales y académicas). El mismo es considerado en su especificidad y se lo diferencia de otras modalidades de violencia conyugal e intrafamiliar. Enumera los prejuicios más comunes en torno a la problemática y detalla las modalidades de abuso emocional, físico y sexual.

Se intenta una descripción del abuso sexual conyugal hasta hace poco ausente de la bibliografía. Las notas y las referencias bibliográficas intentan configurar una guía para los interesados en el tema.

SUMMARY

This work shows the problem of the battered woman from the most recent perspec-

tives (social and academic). The same is considered in its specificity and it is differentiated from other ways of marital and intrafamily violence. It enumerates the most common prejudices around the problem and details the different kind of emotional, physical and sexual abuse.

It is intended to make a description of the sexual marital abuse, until now out of the bibliography. The notes and bibliographic references are a guide for those interested in the subject.

Notas de la "Introducción"

1. Ver VILA de GERLIC, María Cristina, "Violencia Familiar: Mujeres Golpeadas", *Opúsculos de Derecho Penal y Criminología*, Nro. 22, Editorial Marcos Lerner, Córdoba, Pág. 18, Nota 8.
2. Department of Justice, "Report to the Nation on Crime and Justice", en *Response*, 1984, Vol. 7, Nro. 1, 2000 P Street, N.W., Suite 508, Washington D.C., USA 20036, Pág. 9.
3. La historia narrada en el film "La cama en llamas", cuenta la historia de Francine Hughes acusada por haber matado a su esposo, Mickey Hughes, en 1977. Ver bibliografía "The burning bed".
4. Murray Strauss en su introducción a Jean Giles-Sims, en *Wife Battering a systems theory approach*, The Guilford Press, New York, London, 1983, Pág. 5.
5. Pagelow Mildred Daly, *Woman battering victims and their experiences*, Sage Beverly Hills, London, 1981, Pág. 33.
6. Walker Lenore, *The battered women*, Harper and Ron, New York, 1979, Pág. 15.
7. Dobash Emerson y Dobash Russell, *Violence Against wives*, The Free Press, New York, 1979, Pág. 9.
8. "The Canadian Advisory Council on the status of women: Wife battering in Canadá. The vicious circle", Canadian Government Publishing Centre Supply and Services, Canadá, 1980, Pág. 7.
9. Morgan Steven, *Conjugal terrorism: A psychological and community treatment model*

- BROWN, Bruce W., El trabajo de la mujer y la emergencia de prescripciones del rol marital igualitarias, *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. IX, Nro. 1, 1978. Traducción distribuida en diversas actividades científicas en nuestro medio, entre ellas el VIII Congreso Latinoamericano de Psicología y Psicoterapia de grupo, 1979, Bs. As.
- CAPLAN, Paula J., *The Myth of women's masochism*, New American Library, Chicago, USA, 1985.
- DOBASH Emerson y DOBASH Russell, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, Free Press, 1979.
- HOFELLER, Kathleen H., *Social Psychological and situational factors in wife abuse*, R y E Research Associates, Inc. 936, Industrial Ave., Palo Alto, California 94303, 1982.
- GILES-SIMS, Jean, *Wife battering a systems theory approach*, The Guilford Press, New York, London, 1983.
- VILA de GERLIC, María Cristina, "Violencia familiar. Mujeres Golpeadas", *Opúsculos de Derecho Penal y Criminología*, Nro. 22, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1987.
- "Violencia Familiar. Mujer Golpeada", Seminario. Coordinadora: Lic. María Cristina Vila. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Comisión de la mujer y sus derechos. *Publicación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos*, 1988.
- Journal of Interpersonal Violence*, Volumen 2, Nro. 2, June 1987, Sage Publications, Newbury Park, Beverly Hills, London, New Delhi.
- "Inavan News, International Net work against violence against women", Winter, 1987. Sharon Atkin, 30901, E. Lake Morton Drive S.E., Kent, Washington, USA.
- MARCHIORI, Hilda, "¿Conoce el juez las consecuencias del delito?", *Opúsculos de Derecho penal y criminología*, Nro. 34, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1988.
- Ayer Fempress*, Uruguay, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¡Coraje Mujeres!, Pág. 3, enero 1988, Nro. 77, Ilet. Casilla 16 637, Santiago 9, Chile.
- MC NULTY, *The burning bed*, Bantam Books, Toronto, New York, London, Sydney Auckland, 1981, en el prefacio.
- Rezeaux-Systemes-Agencements, *Therapies Familiales et Pratiques de Rezeaux*, Nro. 4/5, Editions Universitaires, Francia, 1981, de Scandariato Romano. "La Violence dans les Relations Famille/Societe", Pág. 105.

- RAVAZZOLA, María Cristina, *Violencia y Familia*, Trabajo presentado en el Primer Simposium de Prevención de la Violencia Familiar auspiciado por el Servicio de Psicopatología del Hospital Piñero, 1985.
- Response*, 1984, Vol. 7, Nro. 1, 2000 p Street, N.W., Suite 508, Washington D.C., 20036-5997, Pág. 9.
- Revista *Todo es Historia*, Año VII, Nro. 81, Febrero 1984, Ed. Toris SCA.
- Scandariato Romano, "La Violence dans les relations Famille-Societe", en *Rezeaux-Systemes-Agencements, Therapies Familiales et Pratiques de Rezeaux*, mars 1981, Organe officiel de "l'institut d'Etudes de la Famille et des Systemes Humains", Bruxelles.
- VIANO, Emilio, "Violencia, Victimización y cambio social", *Opúsculos de Derecho Penal y Criminología*, Nro. 28, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1987.

Bibliografía de "La problemática de la Mujer Golpeada"

- ALSDURF, Jim M., "Wife abuse and the Church: the response of pastors", en *Response*, Vol. 8, Nro. 1, Winter 1985.
- Boletín "Noticias de la Mujer", publicado por la Secretaría de las Naciones Unidas (Viena), Enero de 1987, "La Violencia en la Familia", Pág. 1.
- COULTON G., *Medieval Panorama, The English Scene from conquest to reformation*, New York, Meridian Books, 1955, Pág. 617.
- Naciones Unidas, "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder", Departamento de información pública, DPI, /895, October, 1986, 2M.
- VILA de GERLIC, María Cristina, "Las Mujeres Golpeadas", en *La Razón*, Sección Psicología, 19-1-86.
- Organización Panamericana de la Salud, Grupo de Trabajo del Comité regional de la Organización Mundial de la Salud, 97a. reunión, Washington D.C., junio 1986, CSP 22/13, Español, anexo.
- "Inavan News International Network against violence against women", Spring Fall, 1987, Sharon Atkin, 309001 E. Lake Morton Drive, S.E. Kent, Washington, USA 98042.
- Annual Conference of First Ministers Vancouver, British Columbia, November 20-21, 1986. Dimensions of Equality: A Federal

- Goberment Work Plan For Women.
- STARK Eva y FLITCARFT, "Medical Therapy as repression: The case of battered women", en *Response*, 1984, Vol. 7, Nro. 1, 2000 p Street, N.W., Suite 508, Washington D.C., 20036-5997, Pág. 10.

Bibliografía de "Modalidades de Abuso"

- ADAMO S.J. Monsignor, Calling rape "a husband's right is wrong", *Phil Daily News*, April, 16/87.
- ADAMO S.J. Monsignor, Time for a new definition of wifely obedience, *Phil Daily News*, 12-7-84.
- CAPLAN Paula J., *The Myth of women's masochism*, New American Library, Chicago, USA, 1985.
- DOBASH Emerson y DOBASH Russell, *Violence Against Wives*, The Free Press, New York, 1979.
- DOWDESWELL Jane, *La Violación*, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1986.
- FINKELHOR David, *Marital Rape. The Misunderstood crime, Address to the New York County Lanyer's Association*, May 3, 1984, University Library: 415 Main Library, 1408 West Gregory Drive Urbana, Illinois 61801.
- FINKELHOR David, YLLO Kersty, *License to rape*, Holt, Rinehart and Winston, New York, New York 10175, 1985.
- HELTON M. Anne, "The pregnant battered woman", en *Response*, Vol. 9, Nro. 5, 1986, Pág. 23, 44.
- JONES Lee, Artículo: "Basta apretar un botón: pornografía en su casa", en *Ediciones de las Mujeres*, Isis Internacional, Mujeres y Medios de comunicación Asia y Pacífico, Nro. 2.
- MORGAN Steven, "Conjugal terrorism: A psychological and community treatment model of wife abuse", Palo Alto, California, 1982, Pág. 2.
- PRIEM Teresa, "Marital Rape: what happens when women fight back?", *New women's Times*, May 1981, The National Center of Women and Family Law, 799 Broadway, Suite 402, Nro. 4, Nro. 41003.
- RUSSELL, Diana E.H., "Rape in Marriage", en *Response*, 1984, Vol. 7, Nro. 2, Pág. 9.
- SOMMERVILLE Barbara, "Basic misunderstanding leads to 'date-rapes'", *Times*, New York, Feb. 19/84.
- STARK Evan y FLITCRAFT Anne, "Domestic Violence and Female Suicide", en *Response*, 1984, Vol. 7, Nro. 1, 2000 p Street, NW, Suite 508, Washington D.C., 22306-5997, Pág. 9.
- WALKER Lenore, *The battered Women*, Harper and Ron, New York, 1979.
- "The Canadian Advisory Council on the Status of Women: Wife Battering in Canadá. The vicious circle", Canadian government, Publishing Centre Supply and Services Canadá, 1980.
- "Confronting the moral and legal issue of marital rape", *New York Times*, June 1/1981.
- PAGELOW Mildred Daly, "Women battering victims and their experiences", Sage Beberly Hills, 1981, Pág. 33.
- "New Lans Recognizing Marital Rape as a crime", *Times*, New York, Dec. 29/84.
- "Breaking the myth. That once she says 'Yes' to someone she can never say 'no' to anyone . . .", *San Gabriel Valley Tribune*, California, 4-8-84.
- "After sexual assault", Escrito y editado por Illinois Coalition Against Sexual Assault, 1984.
- "Marital Rape Exemption: state-by-state", Analysis National Center on Women and Family law, 1985, 799 Broadway, Room 402, New York, New York 10003.
- "Can a wife say 'no'? Protesting marital rape", The elkhart truth, Indiana, March 26, 1985. Colección *Response*, Vol. 7, Nro. 2, Pág. 10, 15.

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, Palo Alto, CA

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Mau, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of **FAMILY PROCESS** are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.*

FAMILY PROCESS

**149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021**

Gentlemen:

DATE 20/05/2020

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

- ☐ \$24.00 per year United States
- ☐ \$27.00 per year Canada & Latin America
- ☐ \$30.00 per year All other countries

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

- ☐ \$35.00 U.S.
☐ \$38.00 Canada & Latin America
☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

El desnudo del Trabajador Profesional en los casos de Abuso Sexual a Niños

SEBASTIAN KRAEMER

Tavistock Clinic, Londres.
Marzo 1988.

Esta es una versión revisada de un manuscrito entregado a la División Pediatría, Hospital de Clínicas "José de San Martín", Universidad de Buenos Aires, Argentina, octubre 1987.

¿POR QUE?

Se sabe que en los últimos cinco años más y más niños y en especial más niñas han sido sexualmente abusadas por sus tutores, principalmente padres y padres adoptivos. El hecho de que este fenómeno esté ocurriendo ahora en la historia debe tener que ver con la elevación de voces femeninas en la sociedad moderna.

En la antigüedad (y aún ahora en algunas partes del mundo) las mujeres y los niños eran propiedad de sus amos, hacían lo que complacía a los mismos, y nunca se oyeron protestas por el abuso de poder que ejercían dichos amos, sin embargo ahora sí hay protestas. A pesar de la predominante unción de que estamos experimentando una epidemia de algo totalmente nuevo, como el SIDA, de Mause señala,

enfáticamente que no es así. "Hay suficiente evidencia en las fuentes para indicar que el abuso sexual de los niños era más común en el pasado de lo que es ahora".

(1976) A pesar de que las razones para ello, no son del todo claras, lo que está sucediendo ahora es el descubrimiento de algo que siempre ha sucedido, pero que finalmente es posible conocer.

Sin embargo, este conocimiento está lejos de un camino honrado, y mi principal punto práctico es que cada caso de abuso sexual a un niño causa disturbios y divisiones muy dolorosas entre profesionales.

PROTECCION A UN NIÑO ABUSADO SEXUALMENTE

En la mayoría de los departamentos de los servicios sociales, el procedimiento estatutario para tratar el abuso sexual a los niños es en principio igual al requerido en cualquier otra clase de abuso a un menor o de abandono del mismo, pero en la práctica lo que sucede es casi siempre muy diferente. Colegas, quienes usualmente trabajan bien, encuentran que trabajando en un caso de abuso sexual los desacuerdos entre sí y aún los predecibles desacuerdos clínicos se convierten en luchas personales. Este proceso de división refleja la naturaleza básica del incesto y del abuso sexual en la sociedad, esto sólo puede acontecer por división, desconexión o partición.

Debemos aceptar que el incesto ha tenido siempre lugar en todas las sociedades, pero no hay una ley contra el mismo, si

existe un tabú, es decir que no debe hablarse del incesto. El mismo continúa pero lo negamos. En este sentido las experiencias del autor y de la víctima del abuso sexual son similares.

Un hombre que abusa regularmente de una niña (su hija o hijastra) puede disgustarse con sí mismo, pero también funcionar como un ciudadano parte del tiempo y virtualmente olvidar sus crímenes secretos. Del mismo modo el niño/la niña sabe que está envuelta en algo malo, pero puede, a veces, imaginar que en verdad eso no sucedió, que su padre es un buen hombre (ella lo ama, a pesar de todo, y depende de su amor) y que ella es malvada al haber "soñado" tal cosa.

Su madre puede haber sospechado algo, y aún semi-concientemente alentado esto, pero puede desechar esta idea como algo imposible.

Estas son reacciones comunes humanas con respecto a algo intolerable o inimaginable. Uno no puede creer en su propia muerte, lo que temo muchos de nosotros hacemos. Hay una abertura entre el conocimiento y la creencia.

Cuando, en niveles individuales o sociales, esta abertura se salva y la conexión es hecha, sobreviene un shock como un flash de alto voltaje eléctrico que amenaza con tornar el sistema a su previo estado, por un corto-circuito. El efecto del descubrimiento del abuso sexual en trabajadores profesionales, como individuos, en trabajos grupales, y en el público en general, profundo y tan sorprendente que conduce a difundir la desconexión.

Los síntomas de estos son algunas veces aparentemente inocentes, tales como un trabajador se olvide de comentarle a un colega de una reunión, pero otras secuencias, son obviamente, más infe-

lices. Estos efectos deben ser anticipados en conferencias disponiendo de más tiempo de lo que es usual y esperando que los participantes se molesten por el material en discusión, por sus propias reacciones al respecto y por las reacciones de otros. Por ejemplo la gente se puede sorprender al verse identificados no sólo con la víctima, sino también con el abusador.

El stress es de otro orden diferente del que se encuentra en otra clase de problemas y no puede ser contenido por nuestras usuales actitudes profesionales. Una sola estadística establece que en una reunión de gente, tal como es una conferencia, es probable que hay por lo menos una víctima de abuso sexual y posiblemente un autor también.

LA PARTICIPACION DE OPINIONES

Actualmente en Gran Bretaña hay un duro debate, por ejemplo en las columnas de las cartas de los diarios y en los diarios para profesionales con respecto a la prevalencia, diagnóstico y manejo de un niño que haya sido abusado sexualmente. Hay dos visiones, la principal polarización está entre aquellos que piensan que las cifras que tenemos están todavía gruesamente subestimadas, y aquellos que dicen que las mismas son grandemente exageradas. Mucho depende de la definición, por supuesto, pero la fuerza emocional detrás de estas opiniones es más de lo que se puede encontrar en un seminario filosófico. Es como si nuestra civilización dependiera de la salida de la misma —si es verdad que el incesto es una ocurrencia difundida y no meramente una práctica peculiar hecha

por gente extraña en comunidades aisladas, entonces tenemos que revisar nuestra visión de la sociedad.

Tal vez es porque el tabú es tan fundamental para nuestra identidad como especie, que parece haber urgencia en decidirnos sobre esto, y en estar seguros de dónde estamos parados. El problema es que no se dispone fácilmente de los datos.

En cada caso en particular la revelación del abuso sexual de un niño encierra una dolorosa revelación, valga la redundancia, de secretos y mentiras, algunas veces por largos períodos de tiempo. En verdad es imposible investigar el real incidente de incesto o abuso sexual en cualquier país, por eso nos manejamos con estimativos, sobre los cuales discutimos y tomamos posiciones. Por alguna razón es muy difícil no tomar posiciones. No hay neutralidad en un tema tan importante como éste.

En cualquier área hay oponentes, haciendo lugar a los insultos. Entre los expertos se ha desarrollado el conflicto más vicioso. Trabajadores que toman a los niños que han sido abusados para demostrar con muñecas anatómicas lo que se supone les ha sucedido a dichos niños, alentándolos con preguntas que hace el entrevistador, estos trabajadores han sido acusados de abuso de menores por sus oponentes, quienes sostienen que todos los niños son sugestionables y darán la respuesta que ellos piensan que el examinador quiere.

No sorpresivamente este escándalo es gritado en las cortes, donde el desacuerdo es tan esperado. La evidencia dada por los expertos conocidos conformando dicho abuso es regularmente desconfiada por otras autoridades. A raíz de las consecuencias catastróficas al cometer un error, la tensión crece, pero creo que la polariza-

ción extrema de opiniones tienen más que ver con el pensamiento de incesto en sí que con la obligación presionante de las cortes y de los servicios sociales para alcanzar conclusiones claras. La división o ruptura sucede en la sociedad y en la mente de cada persona. Como lo es para un niño contemplar el acto sexual entre sus padres, esto es algo creíble y no creíble, como dije antes, es como pensar en la propia muerte.

Las sociedades y sus religiones se definen por sus actitudes hacia la muerte y la sexualidad, pero la prohibición del acto sexual entre padres e hijos las definen a todas, ahora estamos forzados a pensar en esto. Puede no ser un mero accidente que el tabú sobre la contemplación de la presente guerra nuclear está, también, siendo abandonado. Ambos procesos son, esencialmente, abusos del poder masculino que, una vez comenzó, se convirtió en adictivo y que es difícil de parar.

NO HAY ESPACIO PARA LA INCERTIDUMBRE: UN EJEMPLO

En algunos casos es imposible, a pesar de (o tal vez por) la evidencia limitada a permanecer indecisos. Recientemente los padres de ella nos pidieron que viéramos a una niña discapacitada con dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Durante la entrevista ella le dijo al Psicólogo del grupo que no le gustaba cuando su padre iba a su habitación durante la noche, e interpretó una tarjeta con dos monos. "Uno de ellos tenía su dedo en el ombligo del otro", esto no es lo que dicha tarjeta mostraba en realidad. En presencia de la niña la psicóloga, quien había sido

maestra de escuela por años, experimentó indefinibles sentimientos sexuales. Hubo gran ansiedad en el grupo cuando ella comentó esto y la posibilidad de abuso sexual parecía más grande, segura, de hecho.

Después vi a la niña y no fui capaz de establecer alguna evidencia confirmatoria, a pesar de un cuestionario que le hice con respecto a las visitas de su padre a su habitación. Después de esto, todo el equipo y yo comenzamos a ver todo muy diferente, como si el primer juicio hubiera sido una aberración.

Significativamente, la psicóloga había dejado el grupo. Por el contrario, el juicio sobre el abuso sexual parecía depender no tanto de la evidencia, como de alguna clase de convicción, que tiene un efecto inflexible y casi engañoso sobre todas las observaciones hechas por los miembros de este grupo.

El hecho yace, sin embargo, en que hay áreas grises y que se cometerán errores en el abuso sexual del niño.

Algunos niños que han sido abusados retirarán aseveraciones y algunos, tal vez un 2%, harán aseveraciones que no son ciertas —principalmente cuando la relación entre sus padres se está rompiendo y el niño está en medio de ambos y cuando el abuso sexual pasado de un padre permanece oculto y sin resolver. En el juicio clínico, es útil apuntar a uno o varios niveles de probabilidad (Bentovim), pero esto implica admitir que la certeza es rara vez posible.

Cualquiera sean las razones, es muy desagradable no estar seguros de los hechos del abuso sexual, pero usualmente es así.

A veces los datos, cuando los tenemos, son aún más desconcertantes y desagradables.

SEGUNDO EJEMPLO: UNA RED DE TRABAJO PARALIZADA

En cada caso de abuso a un menor me he encontrado, a pesar de que los detalles varían enormemente, con esta partición o desconexión, en individuos o entre individuos; es la causa de una tensión extraordinaria en reuniones o conferencias. Un caso particular viene a mi mente: dos adolescentes, un varón y una nena, habían sido abusados durante años por su padrastro hasta que el varón le contó a la madre. Esta le contó al médico quien lo reportó a los servicios sociales. Los niños fueron entrevistados por un trabajador social confirmando los datos, pero no dando detalles. La madre y el padrastro se acercaron a mí preguntando por una terapia familiar, pero no querían que yo me contactara con una asistente social o con un oficial de policía. Les dije que no podía trabajar de este modo. Se realizaron conferencias con asistentes sociales, policías, psicólogos, consejeros legales, médicos generales, maestros, psiquiatras, etc., pero no hubo grandes cambios. La familia quedó intacta, sin garantías de que el abuso hubiera cesado. Después de varios meses los asistentes sociales tomaron la custodia y los niños fueron entrevistados por un psiquiatra, hasta entonces la madre se había rehusado.

Fui invitado y vi a los niños pero no obtuve mucha más información de ellos. Ellos estaban, como su madre, furiosos conmigo. Sintieron que yo había —como el médico general— frustrado su confianza en un doctor, con quien esperaban guardar un secreto.

La traición, por supuesto, ya había

tomado lugar dentro de la familia.

Las conferencias mensuales dieron la única información real sobre este caso, pero no lo hicieron de una forma fácilmente dirigible.

Nadie parecía refutar la revelación de los niños, aún así no hubo acción.

Un oficial de policía dijo que él entrevistaría al padrastro esa noche, pero la conferencia oyó un mes más tarde, que la policía no había actuado.

Mientras tanto los adolescentes dijeron a los asistentes sociales que si el abuso se reiteraba se lo dirían a su madre y su padrastro sería echado de la casa.

A raíz de esto, los trabajadores sociales trataron de persuadir a la conferencia de que no se abusaba más de los niños y de que estos no corrían riesgo. Un psicólogo señaló que los niños estaban, en tal caso, investidos con la tarea de cuidarse a sí mismos y en efecto, eran responsables por la supervivencia de la familia, y que también actuaban como asistentes no pagos. La presión sobre los asistentes sociales, un hombre y una mujer, era intensa porque la mayoría de las decisiones tomadas en estas reuniones debían ser llevadas a cabo por ellos, incluyendo sacar a los niños de su hogar, si ello llegaba a ser necesario. Estos dos profesionales eran asimismo víctimas.

Frecuentemente era imposible pensar con claridad sobre la conferencia, pues la atmósfera de incertidumbre y frustración era paralizadora.

Cualquiera que no se presentaba (la policía muchas veces) o estaba ausente inevitablemente (el juez, la madre, el padrastro o sus abogados), era culpado, para excusar a los asistentes sociales. Tal vez a raíz de las poderosas experiencias comparadas, había cierta presión en continuar

con estas reuniones, siempre realizadas en el mismo altílo bien amueblado de la iglesia transformada. Los miembros se saludaban tímidamente al principio, pero partían con la entusiasta promesa de reunión, como un grupo en terapia.

Nueve meses después de la revelación original la corte ordenó otro examen psiquiátrico y el psiquiatra designado esta vez logró que le contaran detalles del abuso sexual. Este informe, junto con otros, fue presentado al Juez, quien aceptó los fallos. La madre estaba sentada en la corte junto al padrastro y entre ellos el padre de los niños, quien había abandonado la casa hacía cinco años. La madre y el padrastro bufaban y se reían como una pareja de adolescentes que habían sido atrapados mientras fumaban, el padre, aparentaba estar inconsciente de ello. Justo antes del veredicto el padrastro aceptó dejar la casa y la corte acordó cuándo vería a los niños; los domingos dos horas durante el día.

A pesar de que me opuse a que los niños vieran a este hombre bajo cualquier contexto, por lo menos por unos pocos meses, mi última impresión fue la de una sesión en la Corte Suprema discutiendo todo esto cuando el hombre responsable de repetidos ataques a niños estaba sentado allí sin ser juzgado, y además reconocido por el Juez como un "buen padre" para los niños. Ruptura.

En las reuniones había un fuerte sentimiento de repulsión hacia el padrastro, pero estábamos protegidos de actuar en esto, de convertirnos en "una masa que lincha" por esta separación de las cortes civiles y criminales. De hecho, además, el hecho de que los abusadores son frecuentemente enviados a prisión y maltratados por otros prisioneros y por el staff de la

prisión, respalda esta clase de disociación, ya que la función primaria de la conferencia y de la decisión familiar de la corte es "la protección del niño", y no la justicia criminal. (Experiencia de USA sostiene que si se da la libertad a algunos culpables y además órdenes para su tratamiento, en vez de sentencias en prisión, las probabilidades de rehabilitación de la familia son mayores).

Este no es necesariamente un camino fácil para los autores del hecho, ya que tienen que asumir la responsabilidad de lo que han hecho, más que ser castigados por ello.

Muchos son incapaces de asumirlo.

EL DESNUDO

Había veces en que la tentación de culpar a uno u otro de los profesionales era irresistible. Los asistentes sociales parecían estar muy temerosos, y ser a veces deshonestos, la policía parecía no interesarse, el juez estar ciego y así todos los demás, pero no creó que ninguno de ellos fuera incompetente.

De hecho, tengo gran respeto por todos ellos. Lo que parece ser que sucede en los casos de abuso sexual a un menor, es que despojan al acicalado profesional de sus vestimentas para revelar la vulnerabilidad (y la humanidad) de la persona que hay debajo de las mismas; es posible ver en dicha persona una variedad de debilidades estereotipadas. Estas percepciones, entonces, toman el lugar de los pensamientos acerca del abuso sexual (es decir, los eventos que llevaron a la formación de esta red de trabajo) que es un tabú. Es más fácil culparse entre sí que imaginar los actos sexuales entre padres e hi-

jos.

Si se exponen las debilidades de este proceso, también pueden exponerse las fuerzas. Más que en ninguna otra clase de trabajo, es necesario en casos de abuso sexual e incesto, hablar dulcemente con los colegas y clientes.

Bajo presión, las habilidades y estrategias profesionales que no son parte de uno, se caen de uno como una armadura que no ajusta.

Desvestirse así, es una forma de dejar libre a la mente, y frecuentemente las cosas que se necesitan decir son muy simples (por ejemplo, ¿quién hizo qué a quién?), pero son difíciles de decir porque son interrumpidas, entre otras cosas, por fantasías incestuosas.

El reporte de Bentovim de sus entrevistas con víctimas adolescentes de incesto (1987) en las que él pregunta qué creen que él, un experto, puede decir al juez, es presentado como una intervención estratégica como si ésta fuera una técnica del autor.

Creo que así es, está muy claro que lo que les estuvo diciendo a las niñas estaría muy cerca de lo que en verdad estaba pensando decirle al Juez.

Siguiendo su (correcta pero incompleta) interpretación del material incestuoso como una fantasía deseada por el niño, parece más difícil tener en mente los motivos o deseos de los adultos que abusan sexualmente de los niños. La tendencia, dirección del reconocimiento de las conductas de seducción de un adulto fue alentada no sólo por el genio y prestigio de Freud sino también por la presencia social y por la necesidad propia del analista de disminuir esta idea de ansiedad (Devereux 1953).

Desconcertados con esta clase de inter-

ferencias todos estamos expuestos a dicho descabro y a volvernos tontos, e intentos por cubrir todo esto tomándose de los mecanismos profesionales parece hasta ridículo (otra experiencia de desnudarse, a pesar de que hay que vestirse para ello, es ir a la corte, el trabajo más temido).

El profesionalismo toma otro significado en este nivel de trabajo que tiene más que ver con el coraje que con la decencia. No estoy proponiendo un abandono o relajación de los procedimientos profesionales (por el contrario), sólo su purificación para permitir el shock.

Mis propias contribuciones a este decreto, que por reflejo parecen haber sido un ensayo para escribir esto, se muestran como una tendencia para seguir el proceso del espejo, en el cual las dinámicas de familia se vuelven a jugar en la conferencia del caso, y luego en la corte. (Este fenómeno ha sido descrito como "un conflicto por poder" por Furniss, 1983).

Valerie Sinason (1986) ha escrito sobre los efectos del abuso sexual en niños quienes luego parecer ser discapacitados mentales.

Sin tener que reflejar cualquier rol particular del individuo, los asistentes sociales pueden describir actitudes a las que pueden ser vulnerables estando con stress, en mi caso un grado inusual de tozudez y reiteración.

Iba a las conferencias determinado a no cambiar mi pensamiento, dejando poco espacio para la curiosidad o para el punto de vista de otra persona. Pienso que el urgente deseo del grupo de conferencia por mantenerse unido y mi compulsión por seguir, reflejaban el estado de lucha de la familia en discusión.

Las discusiones sobre el abuso de un menor tienden a ser adictivas (Furniss,

1988).

El objetivo de mi historia es advertirles de que este proceso es muy común en casos de abuso, y que el único camino para tratarlo es reconocerlo, antes de ser abrumado por el proceso de mirarse al espejo y encontrarse desempeñando papeles que no te pertenecen (ver Britton, 1981, Rader y Kraemer, 1980). El signo revelador es cuando uno comienza a pensar de un colega en términos muy personales y críticos, como si esto fuera lo más importante. Por supuesto que las personalidades de los colegas son relevantes, pero la tarea primaria no es tratar esto sino trabajar juntos en el caso, y es una evidencia de parálisis cuando se ve que el problema de la familia es menos importante que el del profesional que está con uno.

La llave para el éxito en el trato de un niño abusado —siempre hay obstáculos, errores—, es primero que nada dejar tiempo y lugar a las reacciones de la gente ante el caso. Sin estar preparados para el tipo peculiar de perturbación que he tratado de describir, fracasarán los intentos por mantener las siguientes recomendaciones rutinarias. Mantener las disciplinas apropiadas acerca del trabajo de equipo multiprofesional, en particular reuniones, mantener a los demás informados sobre otros y sobre el caso, asegurarse que se invita a toda la gente importante y que estos pueden concurrir y finalmente, usar el procedimiento adecuado para la protección del niño, que ya existe, en vez de ceder a la tentación de cambiar las reglas, por ejemplo: excluir a colegas que no están de acuerdo con uno y reunirse secretamente sin ellos.

Dichas cosas suceden, y reflejan las dinámicas de los individuos y familias con incesto y abuso de menores —un catálogo

go de vicios— la ruptura de límites, secretos, mentiras, no tener capacidad de parar, abuso de confianza y lo que es peor, desarrollar una capacidad sorprendente para estar sordo y ciego ante lo que está sucediendo.

“El incesto . . . es el lugar para esconder los sentimientos más secretos, dolorosos, intensos, delicados, grotescos, inmorales, vergonzosos, y al mismo tiempo, los más sagrados que forman la riqueza increíble e inexplicable de las relaciones humanas y les da a las mismas un poder convincente. Como los tentáculos de un pulpo que se enrollan invisiblemente alrededor de los padres e hijos”. (Jung 1946).

Estoy muy agradecido a Sheila Miller, Carolyn Okell-Jones, Julia Nelki, Anne Mc Fadyen, Wilhelmina Kraemer-Zurne, Tilman Furniss, Valerie Sinason, Janice Uphill y Peter Roder por ayudarme y apoyarme y a Emilia Dowling por traducir el texto en español para su presentación original, y a Lucila Agnese por invitarme a hacerlo, a pesar de mis protestas porque no soy un experto en el manejo de casos de niños que han sufrido abuso sexual.

RESUMEN

Quiero considerar algunos efectos del abuso sexual de niños por sus padres o tutores en la sociedad, en particular en los grupos de profesionales armados para tratar este tema. El tabú contra el incesto parece ser fundamental a la raza humana y es esencialmente un antiguo secreto. Ahora se están sacando las coberturas en una escala sin precedentes, con algunos efectos perturbadores. Uno de estos es el reflejarse en el espejo en cualquier nivel, desde el individuo al pequeño grupo, a la sociedad toda, de la disociación original que nos ha mantenido, por mucho tiempo, en un es-

tado de ignorancia. Este proceso, de desconexión o partición, conduce a la caricatura de diferencias personales y socava todas las habilidades profesionales salvo las más auténticas, obligándonos a trabajar en un estado de desnudez relativa.

“El abuso sexual del niño es un tema intensamente controvertido y profundamente divisivo. Separa a los niños de sus padres, a las madres de los padres, a las familias de sus amigos, vecinos y parientes. Pone a los trabajadores sociales contra los psiquiatras, a los terapeutas contra los investigadores, a estos contra los abogados, a estos contra los jueces, a estos contra los jurados y a cada parte contra la sociedad misma. Cualquier alianza tradicional o potencial se ve amenazada y cualquier desconfianza naciente se exagera. Cada pregunta se convierte en una disputa y cada respuesta en un insulto. Aquí en medio del florecimiento de la razón y la ilustración científica es un vestigio descuidado de temas míticos y supersticiosos casi no tocados por la conciencia adulta”.

(Summit, 1986).

SUMMARY

I want to consider some effects in society, in particular in the professional groups set up to deal with it, of the sexual abuse of children by parents and guardians. The taboo against incest seems to be fundamental to the human race and is essentially an ancient cover-up. Now the covers are coming off on an unprecedented scale, with some disturbing effects. One of these is the mirroring at each level, from the individual through the small group to

society at large, of the original split that has for so long kept us in a state of ignorance. This process, of disconnection or partition, leads to the caricature of personal differences and undermines all but the most authentic professional skills, leaving us to work in a state of relative undress.

“Child sexual abuse in an intensely controversial, deeply divisive subject. It splits children from parents, mothers from fathers, and families from their friends, neighbours and relatives. It divides social workers against psychiatrists, therapists against investigators against prosecutors against judges against jurors, and every player against society itself. Any traditional or potential alliance is threatened, and every nascent distrust is exaggerated. Each question becomes a dispute and every answer an insult. Here in the midst of the flowering of 20th-century reason and scientific enlightenment is a neglected relic of mythic and superstitious issues almost untouched by mainstream adult consciousness”.

(Summit, 1986).

BIBLIOGRAFIA

- BENTOVIM A., (1987)a, “The diagnosis of child sexual abuse”, *Bulletin of the Royal College of Psychiatrists*, 11, 295-299.
BENTOVIM A., (1987)b, “Physical and sexual abuse of children - the role of the family

therapist”, *Journal of Family Therapy*, 9 (4), 383-388.

BRITTON R., (1981), “Re-enactment as an unwitting professional response to family dynamics”, in (eds) S. Box et al, *Psychotherapy with families: an analytic approach*, London, Routledge and Kegan Paul.

DE MAUSE, L. (1976), “The evolution of childhood”, in (ed) L. de Mause, *The History of Childhood: The Evolution of Parent-Child Relationships as a Factor in History*, London, Souvenir Press.

DEVEREUX G., (1953), “Why Oedipus killed Laius”, *International Journal of Psychoanalysis*, 34 (2), 1-10.

FURNISS T., (1983), “Mutual influence and interlocking professional-family process in the treatment of child sexual abuse and incest”, *Child Abuse and Neglect*, 7:207-223.

FURNISS T., (1988), *Surviving Child Sexual Abuse - principal ways and practical problems in a multiprofessional approach*, London, Routledge and Kegan Paul.

JUNG C.G., (1946), “Psychology of the transference”, in *The Practice of Psychotherapy*, (Vol. 16, the Collected Works of C.G. Jung), London, Routledge and Kegan Paul, p. 179.

REDER P., & KRAEMER S., (1980), “Dynamic aspects of professional collaboration in child guidance referral”, *Journal of Adolescence*, 3, 165-173.

ROCHDALE NSPCC., (1986), *Doing Networks and Case Conferences*, Rochdale Area Review Training Sub-Committee (copies available from Jacob Bright Children Centre, Whitworth Rd, Rochdale, Lancs, England, OL26EP).

SINASON V., (1986), “Secondary mental handicap and its relationship to trauma”, *Psychoanalytic Psychotherapy*, 2, (2), 131-154.

SUMMIT R., (1983), “The child sexual abuse accommodation syndrome”, *Child Abuse and Neglect*, 7, 177-193.

SUMMIT R., (1986), Foreword in (eds) K. Macfarlane & J. Waterman, *Sexual Abuse of Young Children: evaluation and treatment*, London, Holt, Rinehart & Winston.

¿Cuando usted cuenta a los miembros de una familia incluye el televisor?

Dra. GRACIELA PEYRU

Médica Psiquiatra.

Directora de Talleres de Psicoterapia.

"La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis".

Umberto Eco¹

La construcción de los ideales sociales incluye procesos complejos en los que participan mitos, creencias, resortes de poder, tradiciones y las condiciones objetivas de vida de un pueblo.

Una vez constituidos los ideales tienen una cierta persistencia y permiten establecer frente a ellos escalas de preferencias y sustentar privilegios.

Las relaciones de distancia y cercanía con los ideales establecidos y las aspiraciones que las regulan, juegan un papel esen-

cial en el bienestar personal. Satisfacción e insatisfacción consigo mismo son, de modo predominante, el resultado de la comparación entre lo alcanzado y la marca ideal que es construida colectivamente e internalizada como propia.

Esto ocurre también en distintos aspectos de la relación con nosotros mismos, incluyendo nuestro cuerpo, el que no concurre al escenario de los encuentros cotidianos como un objeto natural, se presenta en escena enteramente tatuado y tensionado por los modelos corporales y los ideales estéticos que hemos incorporado.

No nos vivenciamos en una relación directa, de primordial complicidad, nos percibimos, comprendemos y evaluamos refractados a través de los esquemas y modelos dominantes en la familia y en la cultura en que nos criamos y llegamos a ser adultos. Estos modelos organizan patrones de referencia constantes y fijan actitudes, posturas y conductas que deben ser logradas.

Los márgenes de variación en el cumplimiento de los ideales se han ido estrechando en los últimos 300 años y en cada momento de ese movimiento un grupo de personas ha quedado excluido de la posibilidad de sostener con alguna facilidad su autoestima.²

Las definiciones de los ideales se hacen cada vez más estrechas no sólo para los individuos sino también para las familias. En un estudio realizado sobre 6.000 familias norteamericanas se concluyó que el 83% sufren trastornos psicopatológicos. Esto significa, en otros términos, que sólo el 15% de las familias cumple con las aspiraciones del ideal de salud familiar en alguna medida compartido y especificado para este estudio por los investigadores que lo realizaron.³

¿Y cómo vamos construyendo los especialistas, los individuos, las familias, estos altos standards que, a cada instante, hallamos más arduo conquistar?

VINCULOS, IDEALES Y VIOLENCIA

"Los museos son el cementerio del arte muerto. El arte real de los años 80 es la propaganda, la T.V., películas, ropas, deportes, ¡Bebedlo todo!
John Nixon⁴

La mayor parte de los procesos de comunicación se desarrollan hoy en el campo de los mass media. A diario en ellos se construyen y demuelen ídolos e ideales y se transmiten con persistencia modos vinculares que llegan a la recepción familiar, a través de códigos disímiles entre los que predominan las imágenes de la red en mosaico que es la pantalla televisiva y sus sonidos asociados.⁵

Las aguas se separan dejando emerger la figura colosal de un gran robot. Al ritmo de la percusión de un rock lento, cañones en perspectiva panorámica se proyectan desde tanques anaranjados y son demolidos por discos voladores. Monstruos mecánicos impresionan la retina al tiempo que son degollados. El rock sigue sonando. Los aviones son despedazados antes de alcanzar a perfilar su silueta completa. Rayos lumínicos fragmentan todo lo que está a su encuentro. Los edificios se incendian. Un cuerpo metálico es atravesado en el centro mismo de sus entrañas. En brillantes colores, mientras el rock sigue sonando, en sólo 36 segundos, los niños sentados ante la pantalla del televisor han

recibido ocho impactos de destrucción total. Se ha presentado el Mazinger Z, serie televisiva de origen japonés, de difusión masiva a los niños del mundo occidental.⁶

Como productos colaterales incluye una historieta semanal, varios films de largometraje, figuritas, muñecos, remeras, etc.

Esta serie, quizá la más completa, se ve flanqueada por las brigadas metálicas especializadas de "Robotech", "Transformers", "Rey Apolon", "Justiciero", "Los Gobbots" y varios otros que, desde los programas regulares o los videos clubes, se dirigen en forma organizada a capturar el consumo de la audiencia infantil.

El avance de las series de robótica no es nada despreciable, en los países occidentales cubre entre el 30 y el 50% de la programación destinada a la infancia.

La similitud de los mensajes de las distintas series, indica que sus características no constituyen un fenómeno aislado, ni un sencillo entretenimiento infantil. Por el contrario, son un ejemplo evidente y singularmente deslumbrante de la eficacia alcanzada por los medios de comunicación de masas, en la fabricación de nuevos íconos.

Todo un sistema de valores, está siendo transmitido mediante la urdimbre mítica de estos nuevos bisontes que, desde las paredes de las cavernas electrónicas, permiten a los niños aprehender como total una visión de la realidad compartida sólo por un sector de la colectividad.

El ritmo cada vez más frenético que no permite la reflexión, la reiteración de la violencia, los grandes tamaños, la resplandeciente espectacularidad de la animación, el impacto de los nuevos inventos, la repetición y la insistencia, son recursos que

crean grandes expectativas y por ello hacen recordar a las técnicas de la publicidad. En las campañas de propaganda, como en estas series, existe una tendencia a usar la repetición unida a la velocidad al presentar los productos a vender. Todo, incluso el consumidor, queda envuelto en una cierta confusión y profusión de imágenes.⁷

Y sin embargo, dentro de este desorden aparente existe el orden claro de los ideales sociales, aquellos que se quieren vender.

El océano, un barco navega en medio de la noche, un torpedo emerge de la oscuridad, el barco estalla: "La corporación de la cabeza de la muerte" ha comenzado. Suenan las alarmas, Koji se dirige a buscar al Mazinger Z a su silo subterráneo. Las fuerzas del mal organizan un ataque masivo de lanchas torpederas. Las lanchas y el Mazinger Z se dirigen a un punto de encuentro. Mediante veloces proyectiles, aquellas son destruidas. Han pasado 175 segundos. No sabemos por qué han peleado. La lucha ha sido muy veloz, la destrucción total. Los elementos tecnológicos implicados evocan claramente los instrumentos de guerra nuclear.

La bomba atómica es presentada directamente en "El monstruo mecánico de los siete lagos" y su hongo explosivo (en tectinicolor) es acompañado de una música romántica. La probable contaminación radioactiva de tres niños es, por otra parte, manejada por los adultos sólo como una travesura que debe ser reprendida suavemente.⁸ Risas y carcajadas concluyen el episodio.

Estas series se construyen mediante la reiteración, a pequeños intervalos, de escenas de destrucción sin sentido y sin explicaciones. En imágenes visuales suma-

mente atractivas, crean una cadencia casi sedante. La reiteración esquemática de los sucesos, unida a una trama muy simplificada, genera una sensación de predictibilidad sumamente tranquilizadora.

La destrucción y la violencia cambian así de signo: se transforman en aquello que el niño está esperando que ocurra, para comenzar a calmarse. Se revela así a los millones de niños del planeta la imagen de un mundo posible pero no actual, en el cual la destructividad se transforma en el principal valor y la única regla de subsistencia.

De modo concordante, las emociones y ansiedades que habitualmente experimentan los niños, son presentados como vivencias sumamente peligrosas, que es necesario controlar con un pasaje compulsivo a la acción. La alegría, la angustia frente a la separación, el llanto, la necesidad de amor, el temor a la muerte, son suprimidos rápidamente por los protagonistas. Si así no lo hacen se exponen a la ironía, la desvalorización o el desprecio de los demás.

Shiro, el más pequeño de esta historia, es un personaje excepcional, sus emociones, si bien breves y fugaces, guardan relación con los hechos que vive: se asusta ante los tanques, llora con las pérdidas, ríe cuando está contento. Su posibilidad de conmoverse resulta claro signo de inmadurez, ya que todos los demás más grandes, valiosos y atractivos, carecen de este rasgo psicológico.

Los personajes de estas aventuras habitan un universo agitado, en el que ataques y contraataques constituyen un presente continuo. El aplanamiento de los tiempos impide reflexiones y emociones. Lo valioso es la acción instantánea, velocidad de chip electrónico: los que destruyen a los

destructores no deben hesitar.

Shiro, niño aún, se siente sacudido por sollozos ante la reciente muerte de su hermana (ocurrida hace 15 segundos). Koji, su hermano mayor, que ya ha entrado en el universo tecnológico, le señala rápidamente que no es pertinente llorar, no hay tiempo para ello. Tampoco para nosotros. Dentro de 7 minutos contemplaremos otra escena de dolor, la más larga de estos episodios. Sigue a la muerte del abuelo, y sus nietos, que acaban de perder a su hermana, lo lloran durante 18 segundos.

No se trata sólo de reacciones emocionales afectadas por el estado de emergencia, al final de otro episodio y ya sin más urgencias por resolver, otra niña comienza a llorar la muerte de su madre, ahogada en el mar mientras ella se salvaba: se repone en sólo segundos declarando haber aprendido a controlar su dolor.

Este modelo de conducta afectiva tiene amplia oportunidad pedagógica en estas series dada la rampante destrucción de vidas humanas que se repite en cada episodio.

La teoría de la catarsis, punto central en la justificación del uso de la violencia y la agresión en el entretenimiento, postula un alivio en las frustraciones mediante la participación intermediada en la agresión ajena. La predicción básica es que la visión de un contenido violento disminuye la probabilidad de una conducta violenta, en los espectadores de la televisión. Independientemente de los efectos catárticos inmediatos que tales imágenes poseen (y algunos estudios señalan como resultado de un incremento inmediato de la agresión), se debe tener en cuenta el modo en que las conductas violentas o hipercontroladas son presentadas al espectador. En este sentido es importante si la conducta vio-

lenta o hipercontrolada aparece como valiosa o desvalorizada, como necesitada de justificación o arbitraria.⁹⁻¹⁰⁻¹¹

Por cierto los personajes de estas series funcionan como modelos ideales para los espectadores y los procesos de aprendizaje, con que llegan a aprender todas las formas nuevas de conducta, operan cuando están sentados frente al televisor.¹²

Del mismo modo que cuando el niño observa a sus hermanos, no siempre adopta en forma mecánica la conducta del modelo televisivo. Pero, mediante la mimesis o imitación imaginaria, no sólo ama, sufre, ataca, ríe y perdona, sino enfrenta conflictos existenciales y aprende acerca de las distintas alternativas posibles para su solución. De este modo, se prepara para elecciones futuras, para aquellas ocasiones en las que el saber de la ficción se actuará, en singulares aplicaciones, a la solución de los problemas de la realidad.

EL CUERPO FRAGMENTADO Y LOS IDEALES DE LA CONDUCTA

Cuando los griegos encargaron a Zeuxis una pintura de Helena de Troya para el templo de Hera, en Croton, le enviaron además hermosas doncellas para elegir modelo. Zeuxis, con perspectiva helénica, entendió que ninguna cara singular, tangible, por más bella que fuera, podía encarnar la legendaria perfección del rostro de Helena. Lo compuso entonces combiñando sobre el lienzo las más bellas facciones de cinco doncellas. Sólo así, se podría construir la imagen ideal de la mujer más bella del mundo.

Esta Helena, al igual que numerosas esculturas de Venus, no representa a una

mujer real, ni tiene rasgos distintivos que la identifiquen como un individuo. Su imagen guarda un indefinible parecido sensible con las otras imágenes ideales que la rodean. Sus proporciones siguen cánones estrictos, pautas estéticas que han sido dominantes durante siglos.

El tronco, del mismo largo que las piernas, la cintura delgada, las caderas suavemente redondeadas y finas son, según Plinio el Viejo, los ideales estéticos del siglo I de nuestra era y también los de Alberti en la "Della Pintura" del siglo XV de Italia. Formas corporales y relatos, referentes (distantes o cercanos) de muchas generaciones de artistas y habitantes occidentales.¹³

Este modo de construcción del ideal social puede considerarse centrípeto o unitario. Toma una serie de rasgos que se encuentran distribuidos en distintos individuos y los unifica en una imagen central. En él predominan los procesos de integración, los rasgos y valores diversos se organizan en un modelo o patrón central que constituye una guía universal.

El ideal, así conformado, atraviesa siglos y fronteras y sus armónicas proporciones corporales logran sostener de igual modo la escultura de Cincinnatus senador de la República de Roma, que deja su retiro para luchar por su patria (siglo III) y el óleo del general Sir Barnase Tarleton, pintado por Reynolds en Inglaterra (siglo XVIII).

La teoría de que existe un conjunto de proporciones perfectas para el cuerpo humano ha fascinado a artistas y otras personas por siglos, pero quizá ese ideal no alcanzó en ninguna otra cultura el grado de unificación y uniformidad que desarrolló entre los griegos. Figuras de hombres y mujeres, conformando las abstracciones

casi personalizadas de dioses y atletas, se mostraban no sólo armónicos, finos y capaces de acción, se los ve además relajados y confortables. Esta doble cualidad corporal-conductual se encontrará en las imágenes icónicas de todas las épocas.

Para los griegos cualquier rasgo individual debe ser deliberadamente omitido, los ideales deben servir de aspiración guía a todo el conjunto.

Cuando por otro lado, en la edad media, la Iglesia enfatizó la necesidad del arrepentimiento, las confortables y confiables figuras desnudas le resultaron inapropiadas y aún chocantes. Las nuevas proporciones del ideal gótico, nada clásicas y muy incorrectas en su anatomía, lograban sin embargo transmitir intensas y sutiles emociones. Torturadas, fulgurantes y dramáticas en sus gestos y posiciones, estas figuras cristianas evocan de modo ineludible en quien las contempla, arrepentimiento y dolor.

Valores estéticos y éticos, conflictivos profundas, sentimientos y normas de conducta, propuestas religiosas y aspiraciones colectivas cristalizan en las extensas amalgamas expresivas que conforman los ideales corporales de una época.¹⁴

Pero aquel arte gráfico, que sentara sus reales en las paredes rocosas de nuestra prehistoria, logró finalmente escaparse de su encierro de las catedrales del medioevo y trasladarse al refugio de los palacios renacentistas. Dando señales de las suaves o violentas mutaciones que desde allí viviera, preserva hoy sus valiosos originales en nuestros museos y galerías actuales. En sus quietos recintos, cuidadosamente iluminados, los habitantes del planeta podemos aún establecer contacto sensible con los productos directos de nuestros artistas.

Pero si los originales están en los museos, los grafismos de nuestra cultura no se detienen allí, el arte vivo de nuestro siglo habita las autopistas, las calles, las plazas, los supermercados del planeta entero. Numerosas copias e infinitas repeticiones gráficas palpitan, se extienden, se irradian y llegan a nosotros a través de los medios de masas. Titilan desde las pantallas electrónicas, carteles, avisos, revistas, envases, periódicos y remeras. Distorsionadas o exactas, estas imágenes turbulentas demandan de nuestra sensibilidad sobreestimulada y transmiten con insistencia los lineamientos implacables de los nuevos ideales.

En la producción de estas nuevas imágenes la tarea pareciera comenzar al modo de Zeuxis eligiendo una modelo publicitaria, cuyo rasgo aislado se acerca a algún ideal de perfección. Pero allí se detiene la similitud, este rasgo lejos de unirse a otro en una imagen integrada, persistirá extrañamente aislado.

En el comercial sobre shampoo el pelo de la modelo lejos de unirse a la boca de otra y los ojos de una tercera, pasará casi a separarse del cráneo de su portadora y flotando en ondas de notable autonomía, sobredimensionado, ocupará íntegramente la pantalla del televisor. Llevado a imagen total, sentará desde allí el standard triunfal de brillo, textura, movimiento y color para los cabellos de la población.

Será seguido, de modo claramente discontinuo, por el fragmento corporal de la cintura y primer tercio de la cadera (de frente y perfil) que ilustran las virtudes del yogurt descremado dietético. Una cinta métrica se desliza ágil por los contornos y delimita este trozo del standard corporal, con precisión de centímetros. Mar-

gen estrecho de variación (nulo) cuyo inaccesible cumplimiento dejará a la mayor parte de los habitantes en permanente tensión y sensación de insuficiencia, quizá útil para garantizar el consumo.¹⁵

En las imágenes helénicas construidas socialmente, ojos, narices, bocas, espaldas, muslos, rodillas convergen hacia un ideal central, basado en la armonía de las proporciones. Entre nosotros, la poderosa centrífuga de los medios separa cada parte del cuerpo, fijando un ideal autónomo: bocas inmensas, carnosas y sensuales (degustan chocolates), manos suaves y delgadas (detergentes y jabones), pies (zapatillas), nalgas (jeans).

Y cada trozo, copiado en serie, reiterado por incansables repeticiones, se difunde por los medios de masa transmitiendo el standard a alcanzar y la conducta (adquisitiva) destinada a lograrlo.

El standard estricto, la conducta asociada sencilla e inmediata. Los rasgos (ideales) circulan por los medios a gran velocidad, hasta que cualquier resto de su origen y materialidad queda disuelto. Líneas y formas aisladas, exiladas de una totalidad significativa, sueltas, flotando, se recortan destacadas sobre un difuso fondo comunicacional. Dispersados por un proceso social centrífugo, llegarán a conformar los pequeños trozos de un ideal fragmentado.

Bajo la influencia de la presión constante de los medios, quizá un gran número de personas ha comenzado a pensar que realmente estos fragmentos están separados (en el cuerpo y en las conductas) y, como ocurre en estos casos, intenta organizar su vida de acuerdo con esa idea.

¿JAMES, CHER Y BARRY SON DE LA MISMA FAMILIA?

"James Patrick Cooney era un chico alegre y extrovertido, con confianza en sí mismo".

Cornelius Mc Carthey, Director del Colegio Fordham (Time)¹⁶

"Me gusta operarme y yo siempre hago lo que quiero".
Cher (Paris Match)

Como muchos otros adolescentes de Nueva York, ese viernes James necesitaba un auto para salir a pasear con su chica. Consiguió prestado el Chevrolet del padre de su amigo Barry. Un pequeño accidente contra un poste ocasionó a la carrocería daños por 900 dólares.

Durante las 48 horas que siguieron James, Barry y tres compañeros del colegio secundario, a los que convocaron frente a la emergencia, desencadenaron una disparatada concatenación de destrozos, asaltos, robos y muertes.

Los cinco no registraban trastornos previos: buenos alumnos, compañeros queridos, de relaciones agradables con muchachos y muchachas de su edad, estaban por graduarse en pocos días, en su estricto colegio jesuita. Tres de los hogares pertenecían a la clase trabajadora, realizando un esfuerzo para financiar los aranceles escolares. La madre de James, empleada pública, era viuda. Su marido, quien ha criado al muchacho, oficial de policía.

Los cinco estaban inscriptos para comenzar sus cursos en la universidad en el otoño.

No hay indicios de uso de alcohol o drogas.

Y sin embargo, a partir del daño material al automóvil, en cada punto del camino, tomaron la decisión incorrecta. Salieron del auto, llamaron a sus amigos, se colocaron máscaras, tomaron un rifle calibre 22, asaltaron un pequeño almacén, obtuvieron 140 dólares, balearon las ventanillas de autos estacionados, amenazaron a un conductor, y dispararon contra el interior de su vehículo. La víctima estaba armada (calibre 38), era un policía fuera de servicio, repelió la agresión y mató a James.

Sus amigos transportaron el cadáver en su auto, lo tiraron en un descampado, quemaron sus propias ropas ensangrentadas y juramentaron silencio. Por casi tres días actuaron como si nada hubiera ocurrido, aún ante la desaparición de su amigo.

Cada decisión fue la incorrecta y sin embargo la más rápida, de alta eficacia, en la resolución del problema, de la carrocería, en forma irreflexiva, desactivada, con sentido fragmentario, la solución comprada, inmediata, conseguía el standard, en la pantalla.

No afectan a Cher ni el descontrol ni el caos, el máximo de orden, espiral fragmentada, se sostiene prolija en una medicina acaudalada.

Según la revista Paris Match, Cher, estrella de estrellas, con dos Oscar laureada, ha pasado 10 veces por la cirugía estética, pagando en la empresa 37.000 dólares.

He aquí el listado de los fragmentos así retocados:

- Cola, levantar y redondear, 1980, 5000 dólares.
- Muslos, reducir 5 cm, 1980, 4000 dólares.
- Ombligo, flaccidez del vientre, 1981, 3000 dólares.

- Cara, acné, 1981, 2000 dólares.
- Senos afirmados, 1969, 1979, 1983, 15000 dólares.
- Nariz, achicar, 1987, 4000 dólares.
- Mentón y pómulos, rellenar, 3000 dólares.

Con el paso del tiempo, trozo a trozo, con alto esfuerzo, en un cuerpo alienado, se han cumplido las metas segmentarias de un ideal fragmentado.

¿Un muerto, cuatro procesados y un cuerpo tan tallado, pertenecen, son acaso, seis miembros de una familia de siete, con el televisor al lado?

¿Compartieron la infancia en un sistema que todos habitamos, un living comunal, sentados como hermanos, en la aldea global?

¿Y es el tam-tam de las costumbres, de nuestros ideales familiares, transmitido por horas en pantallas cuadradas?

SINTESIS

El artículo plantea si es posible entender los problemas de la consulta clínica sólo mediante el análisis de las alternativas conductuales del sistema familiar o es imprescindible incluir además en las hipótesis la inoculación directa de modelos operativos y sistemas de valores por los medios de comunicación de masas.

SUMMARY

In this article we analyse if it's possible to understand the consultant's problems just by analysing the different behavioral patterns in the family system or we need to include in our hypothesis also the di-

rect in-put of behavioral patterns and values through the mass media.

BIBLIOGRAFIA

1. ECO, U., *Apocalípticos e integrados*, Lumen, Barcelona, 1965.
2. FOUCAULT, M., *Vigilar y Castigar*, Siglo XXI, 1977.
3. WHITE, M., *Seminario Interfas*, Buenos Aires, 1988.
4. NIXON, J., *Manifiesto for a Reviewed art*, Art y Text, Australia, 1981.
5. STEARN, G., y otros, *Mc Luban: Caliente y frío*, Sudamericana, Buenos Aires, 1973.
6. PEYRU, G., *Apocalipsis a la media mañana*, Il Bambino e il Médico, Trieste, 1988.
7. PEYRU, G., *Temas de Psicología Social*, Bs. As., 1988.
8. PEYRU, G., *Bunkers para la mente*, Criterio, Bs. As., 1988.
9. PEYRU, G., *Mazinger Z y el discurso atómico*, Symposium sobre "El Malestar en Nuestra Cultura", APA, Bs. As., 1986.
10. DE FLEUER, M.L. y BALL-ROKEACH, *Teoría de la comunicación de masas*, Bs. As., 1982.
11. REARDON, K., *La persuasión en la Comunicación, teoría y contexto*, Paidós, Bs. As., 1981.
12. MOSCO, V., *Fantasías Electrónicas*, Buenos Aires, 1982.
13. ECO, U., GOLDMAN, L., BASTIDE, R., *Sociología contra Psicoanálisis*.
14. WOOLF, F., y CASSIN, M., *Bodylines, The Human Figure in Art*, The National Gallery, London, 1987.
15. MAISONNEVE, J. y BRUCHOW, SCHWEITZER, M., *Modelos del Cuerpo y Psicología Estética*, Paidós, Bs. As., 1984.
16. PEYRU, G., "El Cuerpo Quieto de las Terapias Habladas", en *Boletín Talleres de Psicoterapia*, Bs. As., 1986.
17. "Five Friend in a Car", en *Time*, Julio 11, 1988.

Instituciones que atienden gratuitamente problemas de violencia familiar

MUJERES DE CARRERA JURIDICA

Corrientes 1985 - 3º Piso - Depto. "E"
Capital Federal

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

MUNICIPALIDAD DE MORON

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

Comisión de la Mujer
y sus Derechos

Callao 569 - 1º Piso - Of. "15"
3er. Cuerpo
Capital Federal
Tel.: 46-4382 / 45-6073

ESCUELA SALUD PUBLICA

Marcelo T. de Alvear 2002
Capital Federal

SUBSECRETARIA DE LA MUJER

Defensa 120 - 1er. Piso
Capital Federal

Próximos números

1989

TERAPIAS BREVES

Editores invitados:

Lic. Celia Elzufán

Lic. Hugo Hirsch

TERAPIAS DE PAREJA

Editor invitado: -

Psic. Alberto González

FAMILIA SANA Y

PREVENCION

Editora invitada:

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Los autores interesados en algunos de estos temas pueden enviar sus artículos a la Secretaría de la Revista según las "Instrucciones para los autores" que se encuentra en la página siguiente.

PARA PUBLICIDAD EN ESTA REVISTA

DIRIGIRSE POR CARTA A:

C.C. Nro. 94 - Sucursal 28

(1428) Buenos Aires - ARGENTINA

Instrucciones para los autores

La Revista TERAPIA FAMILIAR publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

ARTICULOS

—Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista, Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, PB, 1428 Capital Federal, República Argentina.

—La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

—No se pagan honorarios por los trabajos aceptados.

—El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o someterlos a corrección de estilo.

—Los trabajos se deben presentar con un original y dos copias; escritas a máquina y a doble espacio e incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su en-

vío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

—Incluir nombre completo de (los) autor (es), título profesional, dirección e institución a la que pertenece.

—Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a las normas internacionales: 1) Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2) Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3) Título completo del trabajo citado. 4) Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

Ejemplos:

ASHBY, W.R. Introducción a la Cibernética (1956), Bs. Aires. Ed. Paidós. 1972.

o

RUDRAUF, J.. Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica. TERAPIA FAMILIAR. 1980. Vol. IV. Nº 7/8, págs. 87-98, Buenos Aires. Argentina.

—Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

—Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

Ficha de suscripción

Nros. 20 y 21

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Ediciones A.C.E., No a la Orden.

DIRECCION: C.C. Nro. 94 - Sucursal 28 - Buenos Aires - Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION Nros. 20 y 21

ARGENTINA: Solicitar precio por carta.

EXTERIOR: U\$S 30.—

GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

SECRETARIA E INFORMES
DE LA REVISTA

TERAPIA FAMILIAR:
C.C. 94, Suc. 28, (1428) Bs. As.,
Argentina.

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre
de 1988 en IMPRECO GRAFICA, Viel 1448
Buenos Aires, República Argentina